

Buku Ajar

KONSEP DASAR KEPERAWATAN 2

Kartika Wijayanti • Maryadi • Ari Susiani
Betty Suprspti • Aida Kusnaningsih



BUKU AJAR

KONSEP DASAR KEPERAWATAN 2

Penulis:

Ns. Kartika Wijayanti, M.Kep.

Maryadi, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Ari Susiani, M.Kep

Dr. Betty Suprspti SKp. MKes.

Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU AJAR KONSEP DASAR KEPERAWATAN 2

Penulis: Ns. Kartika Wijayanti, M.Kep.
Maryadi, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Ari Susiani, M.Kep
Dr. Betty Suprspti SKp. MKes.
Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah, S.Pd

ISBN: 978-634-7294-10-4

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan buku ajar ini dengan judul "Konsep Dasar Keperawatan". Buku ini hadir sebagai wujud komitmen kami untuk berkontribusi dalam perkembangan pendidikan keperawatan yang berkualitas serta untuk mendukung mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam menguasai konsep-konsep dasar yang penting dalam menjalankan tugas profesionalnya secara optimal.

Keperawatan sebagai disiplin ilmu dan profesi terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan global yang semakin kompleks. Untuk itu, pemahaman terhadap konsep-konsep dasar keperawatan menjadi sangat penting karena merupakan fondasi bagi setiap tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan yang efektif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Tanpa pemahaman yang kuat tentang konsep dasar ini, akan sulit bagi seorang perawat untuk mengembangkan kemampuan kritis, melakukan pengambilan keputusan klinis yang tepat, serta memberikan intervensi keperawatan yang profesional dan manusiawi.

Dalam buku ajar ini, kami telah menyusun materi dengan struktur yang sistematis dan komprehensif, yang mencakup berbagai aspek fundamental dalam praktik keperawatan. Materi yang kami sajikan meliputi sejarah perkembangan keperawatan, filosofi dan paradigma keperawatan, etika keperawatan, tren dan isu dalam keperawatan modern, serta penerapan konsep-konsep tersebut dalam praktik klinis sehari-hari. Kami menyajikan setiap topik secara terperinci dan mendalam dengan tujuan agar mahasiswa maupun praktisi keperawatan tidak hanya mendapatkan wawasan teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan konsep tersebut secara nyata di lapangan.

Kami sadar bahwa buku ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kritik konstruktif selama proses penyusunan buku ini. Kami juga berharap bahwa buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, baik dalam kegiatan pembelajaran di institusi pendidikan keperawatan maupun sebagai panduan dalam praktik klinis sehari-hari.

Kami menyadari bahwa buku ini tentu masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan dan pengembangan buku ini di masa depan. Akhir kata, semoga kehadiran buku "Konsep Dasar Keperawatan" ini mampu memberikan manfaat nyata

bagi pembaca dan menjadi salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kualitas keperawatan di Indonesia.

Penulis

Juni, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 TEORI KEPERAWATAN.....	1
A. Teori Keperawatan.....	3
B. Teori Keperawatan Menurut Para Ahli.....	5
C. Pedoman Memilih Teori dalam Praktik Keperawatan.....	30
D. Latihan Soal.....	31
E. Rangkuman Soal.....	35
F. Glosarium.....	35
G. Daftar Pustaka.....	36
BAB 2 FALSAFAH DAN PARADIGMA KEPERAWATAN.....	39
A. Definisi dan Ruang Lingkup Falsafah Keperawatan.....	40
B. Prinsip-prinsip Utama Falsafah Keperawatan.....	42
C. Paradigma Keperawatan dan Komponennya.....	43
D. Hubungan antara Falsafah dan Paradigma dalam Praktik Klinis.....	45
E. Peran Falsafah dan Paradigma dalam Pengambilan Keputusan Klinis.....	47
F. Latihan Soal.....	49
G. Rangkuman Materi.....	51
H. Glosarium.....	52
I. Daftar Pustaka.....	54
BAB 3 TREN KEPERAWATAN DIMASA YANG AKAN DATANG.....	55
A. Teknologi dalam Keperawatan.....	57
B. Keperawatan Berbasis Bukti (EBP).....	58
C. Interprofesionalisme dan Kolaborasi.....	61
D. Pendekatan Holistik dalam Asuhan Keperawatan.....	62
E. Peran Perawat dalam Pencegahan dan Promosi Kesehatan.....	64
F. Latihan Soal.....	67
G. Rangkuman Materi.....	69
H. Glosarium.....	70

I. Daftar Pustaka	73
BAB 4 SEJARAH KEPERAWATAN	75
A. Sejarah Perkembangan Keperawatan pada Masa Pra-Modern	76
B. Kontribusi Florence Nightingale dalam Pengembangan Profesi Keperawatan	77
C. Perkembangan Keperawatan di Indonesia.....	79
D. Tantangan dan Perkembangan Keperawatan Modern	81
E. Latihan Soal	84
F. Rangkuman Materi.....	86
G. Glosarium	87
H. Daftar Pustaka	89
BAB 5 TREN DAN ISSUE	91
A. Tren Utama dalam Keperawatan Modern.....	93
B. Isu Utama dalam Keperawatan	95
C. Strategi Mengatasi Tren dan Isu dalam Keperawatan.....	97
D. Latihan Soal	99
E. Rangkuman Materi.....	101
F. Glosarium	102
G. Daftar Pustaka	105
PROFIL PENULIS	107

BAB 1

TEORI KEPERAWATAN

Tujuan Instruksional:

- Mengetahui sejarah teori keperawatan
- Memahami tingkatan konsep dalam teori keperawatan
- Mengenal dan memahami berbagai teori keperawatan
- Memahami konsep teori keperawatan dan mampu menghubungkan teori dengan praktik asuhan keperawatan
- Memahami tentang pemberian asuhan keperawatan secara holistik dengan mengaplikasikan teori keperawatan yang sesuai
- Mampu memilih teori keperawatan yang dalam memberikan pelayanan keperawatan yang sesuai dengan kondisi klien

Capaian Pembelajaran:

Pengetahuan

- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep *Meta theory*, *Grand theory*, *Middle Range Theory* dan *Practice Theory*
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait berbagai teori dalam keperawatan
- Mahasiswa mampu memahami konsep empat metaparadigma dari berbagai teori

Sikap

- Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat dan profesi dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan teori keperawatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi terkait

Keterampilan

- Mahasiswa mampu menjalankan Asuhan Keperawatan sesuai kode etik keperawatan, berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif dengan berdasar pada teori keperawatan
- Mampu melakukan edukasi, komunikasi dan kolaborasi dalam memberikan asuhan dan/atau pelayanan keperawatan berdasarkan teori bukti ilmiah keperawatan terkini
- Mampu memahami dan memilih teori keperawatan yang sesuai untuk digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu keperawatan

Pendahuluan

Konsep teori keperawatan sangat penting bagi profesi keperawatan saat ini dan masa depan. Teori keperawatan pertama dikembangkan oleh Florence Nightingale pada abad ke-19 yang dinamainya Teori Lingkungan yang masih tetap relevan bagi praktisi hingga saat ini. Seiring dengan terus berkembangnya perawatan kesehatan, jenis teori keperawatan baru dapat berkembang untuk mencerminkan pengobatan dan perawatan.

Pendidikan dan pelatihan menunjukkan pentingnya teori keperawatan. Peneliti dan akademisi perawat berbagi ide-ide untuk memastikan praktik terbaik di seluruh industri dan hasil yang diharapkan pasien, dan pendidik perawat membentuk kurikulum mereka berdasarkan penelitian ini. Ketika perawat mempelajari teori-teori ini, mereka memperoleh data untuk menjelaskan alasan di balik pengambilan keputusan klinis mereka. Perawat memposisikan diri mereka untuk memberikan perawatan terbaik dengan membiasakan diri dengan teori-teori yang telah teruji waktu. Mengenali tempat mereka dalam sejarah keperawatan memberikan rasa memiliki yang memvalidasi dalam sistem perawatan kesehatan yang lebih besar. Itu membantu pasien dan penyedia layanan kesehatan lainnya lebih memahami dan kontribusi perawat dalam tatanan layanan kesehatan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah konsep teori keperawatan, tingkatan teori keperawatan, beberapa teori yang dikembangkan para ahli beserta konsep metaparadigma yang dibangun, serta berisi pedoman memilih teori dalam praktik keperawatan. Pada Bab ini juga berisi latihan soal dan kasus singkat singkat yang dapat digunakan sebagai bahan latihan untuk melatih pemahaman tentang teori keperawatan. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan soal dan studi kasus, serta dilengkapi dengan rangkuman.

Uraian Materi

A. Teori Keperawatan

Teori mengacu pada sekelompok proposisi umum yang koheren yang digunakan sebagai prinsip penjelasan. Teori keperawatan didefinisikan sebagai penataan ide yang kreatif dan cermat terkait pandangan tentatif, terarah, dan sistematis terhadap suatu fenomena. Melalui penyelidikan sistematis, baik dalam penelitian maupun praktik keperawatan, perawat mampu mengembangkan pengetahuan yang relevan untuk meningkatkan perawatan klien (Chinn & Kramer, 2010).

Florence Nightingale merupakan tokoh pencetus lahirnya teori keperawatan hingga saat ini yang dikenal dengan "*Environmental Theory*". Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Ia mengikuti program sekolah keperawatan di Kaiserswerth, Jerman pada tahun 1850 dan 1851. Nightingale bekerja sebagai kepala perawat di Institution for Care of Sick Gentlewomen in Distressed Circumstances, di mana Ia banyak melakukan perubahan untuk meningkatkan perawatan klien yang kemudian ia ditunjuk untuk bekerja di Rumah Sakit Tentara selama perang Krimea, Turki. Nightingale berasal dari keluarga kaya, tetapi ia memilih untuk bekerja di bidang keperawatan, meskipun dianggap sebagai pekerjaan yang "rendah". Ia percaya bahwa keperawatan merupakan panggilan dari Tuhan, dan menyatakan bahwa orang sakit berhak mendapatkan perawatan yang beradab, terlepas dari status mereka dalam kehidupan (Alligood, 2014b).

Teori keperawatan Nightingale tentang kuman dan teori ilmu kedokteran lainnya diterima secara umum dikembangkan sebelum teori penyakit modern. Nightingale mengetahui teori kuman, dan sebelum teori tersebut dipublikasikan secara luas, ia telah menyimpulkan bahwa kebersihan, sanitasi, kenyamanan, udara segar, dan sosialisasi diperlukan untuk penyembuhan. Melalui karyanya, ia mengubah keperawatan dan perawatan kesehatan secara dramatis. Ia menulis banyak buku dan laporan untuk lembaga federal dan di seluruh dunia, di mana buku-buku yang ia tulis yang sangat penting bagi perawat dan keperawatan. Buku tersebut meliputi "*Notes on Nursing: What It Is and What It Is Not*" tahun 1860, "*Notes on Hospitals*" tahun 1863, dan "*Sick-Nursing and Health-Nursing*" tahun 1893 (McEwen & Wills, 2014).

Teori keperawatan memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat abstraksi konsep didalamnya. Menurut Walker & Avant (2014) ada empat tingkatan dalam teori keperawatan, yaitu *Meta theory*, *Grand theory*, *Midle-Range Theory* dan *Practice Theory*.

1. Meta Theory

Meta theory merupakan teori di level paling tinggi sehingga tingkat abstraksinya juga paling tinggi. *Meta theory* merujuk pada area studi komponen filosofis, teoritis, dan empiris serta hubungan mereka dalam struktur pengetahuan. Ini merupakan istilah yang digunakan dalam banyak disiplin ilmu, dan terkadang merujuk pada teori menyeluruh. *Meta theory* bukanlah teori ilmiah semata, melainkan domain perangkat konseptual yang menginformasikan pengembangan teori substantif, konsep teoritis, dan desain penelitian (Higgins & Moore, 2000).

Meta theory keperawatan mengidentifikasi domain keperawatan yang membahas perspektif filosofis, fokus substantif, dan metode yang berkaitan dengan pengetahuan keperawatan. *Meta theory* mencakup semua elemen yang digunakan dalam mengembangkan pengetahuan keperawatan terutama pada filosofi dan metode sains keperawatan, ontologi dan epistemologi keperawatan, metaparadigma keperawatan dan model konseptual yang menguraikan konsep metaparadigma, *middle range theory* dan tingkat lainnya, nilai-nilai pribadi perawat, serta domain praktik profesional keperawatan (Reed, 2017).

2. Grand Theory

Grand theory merupakan sistem teoritis yang juga masih sangat abstrak yang membingkai pengetahuan disiplin keperawatan dalam prinsip-prinsip keperawatan, dan konsep serta proposisinya. Body of Knowledge secara analitis dan filosofis yang muncul dari *grand theory* memberikan bukti keilmuan yang membedakan keperawatan dari disiplin ilmu lain yang terkait erat dan melegitimasi keberadaannya di antara disiplin ilmu akademis. Dengan demikian, *grand theory* memiliki kontribusi paling signifikan bagi pembentukan dan pembuktian identitas dan batasan disiplin ilmu keperawatan (Higgins & Moore, 2000).

Mengingat sifatnya yang abstrak, *grand theory* memberikan penjelasan universal terkait pemahaman tentang keperawatan, bukan hal-hal khusus yang diperlukan untuk pengujian empiris. Oleh karena itu *grand theory* hanya memiliki sedikit kemampuan prediktif. Beberapa *grand theory* juga menggunakan bahasa yang sulit bagi mahasiswa pemula dan tidak dikenal oleh banyak pembaca. Meskipun demikian, *grand theory* telah secara signifikan memengaruhi pengembangan pengetahuan dalam disiplin ilmu keperawatan dan terdapat banyak contoh penggunaannya dalam memandu penelitian, praktik, dan pendidikan keperawatan. *Grand theory* juga berkontribusi pada perspektif historis keperawatan, yang mencerminkan waktu dan konteks di mana para

penulis mengembangkan teori-teori mereka, serta landasan filosofis dan perspektif pendidikan dan praktik keperawatan (Higgins & Moore, 2000).

3. Middle Range Theory

Mirip dengan *grand theory*, *middle range theory* menjelaskan dunia keperawatan secara empiris, tetapi lebih spesifik dibandingkan dengan *grand theory*. Dasar filosofis dan asumsi teori tingkat ini lebih implisit daripada eksplisit. *Middle range theory* merupakan teori yang cukup spesifik untuk memandu penelitian dan praktik, akan tetapi cukup umum untuk mencakup berbagai populasi klinis dan mencakup fenomena serupa, sehingga teori pada tingkatan ini dapat diuji secara empiris. Konsep atau fenomena yang diminati dapat dikodekan secara objektif dengan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif, dan memiliki potensi untuk mendalilkan hubungan yang terukur antara fenomena. Meskipun dapat diuji di beberapa populasi klien dan lingkungan yang berbeda, teori tertentu pada tingkatan ini tidak mencakup semua klien di semua lingkungan. Peran utama teori rentang menengah adalah untuk mendefinisikan atau menyempurnakan konten substantif ilmu dan praktik keperawatan, dan teori ini harus menjadi fokus penting bagi para akademisi dan praktisi keperawatan saat membangun pengetahuan untuk disiplin ilmu keperawatan (Higgins & Moore, 2000).

4. Practice Theory

Teori praktik juga disebut teori khusus situasi, teori preskriptif, atau mikroteori dan merupakan teori yang paling sederhana. Teori praktik lebih spesifik daripada *middle range theory* dan menghasilkan arahan khusus untuk praktik. Teori ini mengandung konsep paling sedikit dan merujuk pada fenomena spesifik yang mudah didefinisikan. Cakupannya sempit, menjelaskan aspek kecil dari realitas, dan dimaksudkan untuk bersifat preskriptif. Teori ini biasanya terbatas pada populasi atau bidang praktik tertentu dan sering menggunakan pengetahuan dari disiplin ilmu lain. Contoh teori praktik yang dikembangkan dan digunakan oleh perawat seperti *theories of postpartum depression*, *infant bonding*, dan *oncology pain management* (McEwen & Wills, 2014).

B. Teori Keperawatan Menurut Para Ahli

1. Florence Nightingale: Environmental Theory

Teori yang dikembangkan Nightingale berorientasi pada lingkungan merupakan *Meta Theory* karena tingkat abstraksinya yang tinggi (McEwen & Wills, 2014). Nightingale percaya bahwa lingkungan klien harus diubah agar alam dapat bertindak pada klien. Karyanya sebagian besar berfokus pada klien dan

lingkungan tetapi juga mencakup perawat dan kesehatan. Misalnya, perawat bertugas mengubah lingkungan klien sehingga alam dapat bertindak pada klien dan memulihkan kesehatannya (Alligood, 2014b).

Ada empat komponen metaparadigma Nightingale yang sekarang diakui sebagai teori di era teori ini yaitu lingkungan, manusia, keperawatan, dan kesehatan: (Alligood, 2014b)

a. Lingkungan

Lingkungan merupakan hal yang dapat diubah untuk memberikan klien pada kondisi terbaik agar alam dapat bertindak seperti ventilasi, kehangatan, cahaya, nutrisi, obat-obatan, stimulasi, suhu ruangan, dan aktivitas.

b. Orang

Orang merupakan makhluk yang dinamis dan kompleks yang dilihat dari komponen fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.

c. Kesehatan

Filosofi kesehatan bukan hanya tentang menjadi sehat, tetapi juga tentang mampu menggunakan kesehatan itu dengan baik. Pencegahan dan peningkatan kesehatan selain merawat klien dari sakit hingga sehat.

d. Keperawatan

Keperawatan merupakan panggilan spiritual sehingga perawat harus membantu alam yang menyembuhkan klien berdasarkan kaidah ilmiah dan terampil untuk diterapkan dalam asuhan keperawatan.

Florence Nightingale mengembangkan istilah "*Critical Thinking*" untuk digunakan oleh perawat saat melakukan observasi selama merawat klien. Ada sebanyak 13 poin pemikiran kritis yang merupakan inti dari teori Nightingale yang dapat dilihat pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1.1. *Critical Thinking* Teori Florence Nightingale

<i>Critical Thinking</i>	Proses dan Pemikiran Keperawatan
Ventilasi dan Kehangatan	Kaji suhu tubuh klien, suhu ruangan, dan ketersediaan udara segar atau ventilasi yang memadai serta bau busuk yang mengganggu. Susun rencana untuk menjaga ruangan tetap sejuk dan bebas bau sambil menjaga suhu tubuh klien.
Pencahayaan	Periksa apakah ruangan memiliki pencahayaan yang memadai. Cahaya matahari adalah yang terbaik. Ciptakan dan terapkan pencahayaan yang memadai di kamar klien tanpa menempatkan klien di bawah cahaya langsung.
Kebersihan Ruangan dan Lantai	Periksa apakah ruangan lembap, gelap, berdebu, atau berjamur. Jaga agar ruangan bebas dari debu, kotoran, berjamur, dan lembap.

Kesehatan Rumah	Periksa lingkungan sekitar untuk udara bersih, air bersih, drainase, kebersihan, dan cahaya. Contohnya termasuk membuang sampah atau pakaian dari area tersebut, membuang genangan air (atau memastikan air mengalir menjauh dari area tersebut), dan memastikan udara dan air bersih dan bebas bau serta cukup cahaya.
Kebisingan	Kaji tingkat kebisingan di kamar klien dan area sekitarnya. Usahakan untuk menjaga tingkat kebisingan seminimal mungkin, dan hindari berbisik-bisik di luar pintu.
Tempat Tidur dan Perlengkapan Tidur	Periksa tempat tidur dan perlengkapannya untuk melihat apakah ada kelembapan, kerutan, dan kotoran, serta periksa ketinggian tempat tidur. Jaga agar tempat tidur tetap kering, bebas kerutan, dan pada ketinggian terendah untuk memastikan kenyamanan klien.
Kebersihan Diri	Usahakan agar klien tetap kering dan bersih setiap saat. Pemeriksaan kulit klien secara berkala diperlukan untuk menjaga kelembaban kulit yang memadai.
Variasi	Cobalah untuk menciptakan variasi di ruangan dan dengan klien. Ini dapat dilakukan dengan kartu, bunga, gambar, buku, atau teka-teki. Dorong teman dan saudara untuk melibatkan klien dalam semacam percakapan yang merangsang.
Berkomunikasi dengan Harapan dan Nasihat	Hindari berbicara tanpa alasan atau memberikan nasihat yang tidak berdasar. Teruslah berbicara kepada klien sebagai pribadi, dan teruslah merangsang pikirannya. Hindari pembicaraan yang bersifat pribadi.
Pola Makanan	Kaji pola makan klien. Catat jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi klien pada setiap waktu makan atau camilan.
Jenis Makanan	Lanjutkan dengan penilaian pola makan untuk memasukkan jenis makanan dan minuman yang disukai atau tidak disukai klien. Usahakan untuk memastikan bahwa klien selalu memiliki makanan atau minuman yang disukainya.
Manajemen Sederhana	Manajemen perawatan kecil memastikan kesinambungan perawatan. Dokumentasi rencana perawatan dan semua evaluasi akan memastikan orang lain memberikan perawatan yang sama kepada klien saat Anda tidak ada.
Observasi Klien	Amati semua hal tentang klien Anda. Catat semua pengamatan. Pengamatan harus berdasarkan fakta dan bukan sekadar pendapat. Terus amati lingkungan sekitar

klien, dan buat perubahan dalam rencana perawatan bila diperlukan.

Sumber: (Alligood, 2014b)

2. Jean Watson: Theory of Human Caring

Teori tentang *Human Caring* dikembangkan oleh Jean Watson antara tahun 1975 dan 1979 saat mengajar di Universitas Colorado yang merupakan *Grand Theory*. Teori ini muncul dari pandangannya tentang keperawatan, yang dipadukan dan diinformasikan oleh studi doktoral dalam psikologi pendidikan, klinis, dan sosial. Teori ini merupakan upaya untuk memberikan makna dan fokus pada keperawatan sebagai disiplin ilmu yang baru muncul dan profesi kesehatan yang unik yang memiliki nilai, pengetahuan, dan praktiknya sendiri yang unik, serta etika dan misinya sendiri bagi masyarakat (Smith & Parker, 2015).

Dalam teorinya, Watson mengaitkan penekanannya pada kualitas interpersonal dan transpersonal dari keselarasan, empati, dan kehangatan. Watson menunjukkan bahwa perawat bukan untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain, melainkan untuk memahami orang lain. Watson menggambarkan inti keperawatan sebagai aspek-aspek keperawatan yang mempotensiasi proses dan hubungan penyembuhan terapeutik. Watson menyebut kepedulian sebagai prinsip atau standar etika yang digunakan untuk mengukur intervensi penyembuhan klien. Intervensi teknis yang umumnya ditujukan untuk penyembuhan harus dibingkai ulang sebagai tindakan dengan kesadaran kepedulian dan diselesaikan dengan cara yang menghormati orang tersebut secara keseluruhan sebagai roh yang berwujud (Alligood, 2014a).

Konsep metaparadigma dari perspektif teori Watson adalah sebagai berikut: (Alligood, 2014b)

a. Kemanusiaan (*Personhood*)

Orang dipandang secara holistik di mana tubuh, pikiran, dan jiwa saling terkait, setiap bagian merupakan refleksi dari keseluruhan. Orang adalah *gestalt* yang hidup dan berkembang yang memiliki tiga bidang keberadaan yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa yang dipengaruhi oleh konsep diri. Pikiran dan emosi adalah titik awal dan akses ke dunia subjektif. Diri adalah pusat subjektif yang hidup di dalam keseluruhan tubuh, pikiran, sensasi, keinginan, ingatan, dan riwayat hidup. Watson menyakan bahwa kepribadian dan kehidupan didasarkan pada konsep manusia sebagai roh yang berwujud dan tidak terbatas dari segi ruang dan waktu, dan sepenuhnya berpartisipasi dalam penyembuhan. Kehidupan manusia didefinisikan sebagai keberadaan di dunia, yang berkesinambungan dalam ruang dan waktu.

b. Keperawatan (*Transpersonal Caring-Healing*)

Keperawatan terdiri dari pengetahuan, pemikiran, nilai, filosofi, komitmen, dan tindakan, dengan sedikit semangat. Perawat berfokus untuk memahami kesehatan, penyakit, dan pengalaman manusia, meningkatkan dan memulihkan kesehatan, dan mencegah penyakit yang didasarkan pada 10 faktor kunci yang disebut sebagai faktor *carative* dan proses *caritas*. Setiap faktor *carative* dan proses *caritas* menggambarkan proses perawatan tentang bagaimana klien mencapai atau mempertahankan kesehatan atau meninggal dengan damai.

c. Kesehatan

Kesehatan didefinisikan sebagai kesatuan dan harmoni dalam tubuh, pikiran, dan jiwa, harmoni antara diri dan orang lain, antara diri dan alam, dan keterbukaan terhadap kemungkinan. Penyakit bisa saja adalah kekacauan subjektif atau ketidakseimbangan diri atau jiwa. Kesehatan dan penyakit merupakan fenomena yang tidak dapat selalu dilihat dalam sebuah kontinum. Proses penyakit juga dapat diakibatkan oleh faktor genetik, konstitusional, dan memanifestasikan dirinya ketika muncul ketidakharmonisan, sehingga menciptakan lebih banyak ketidakseimbangan.

d. Lingkungan (*Healing Space*)

Watson menyatakan bahwa lingkungan berperan dalam penyembuhan yang didesain berdasarkan lingkungan sekitar. Perhatian terhadap ruang penyembuhan menggeser fasilitas perawatan kesehatan dari sekadar tempat bagi tubuh untuk dirawat, tetapi juga menjadi tempat di mana didapatkannya keutuhan pikiran, tubuh, dan jiwa dengan memperhatikan lingkungan mental, fisik, sosial, dan spiritual yang mendukung dan melindungi. Ruang penyembuhan dapat dimanfaatkan dalam membantu orang lain melewati penyakit dan rasa sakit, serta menekankan hubungan antara lingkungan dan manusia.

Konsep utama Watson mencakup 10 faktor *carative* dan proses *caritas* yang berfungsi sebagai dasar dan kerangka kerja bagi ilmu dan praktik keperawatan. Faktor *carative* asli yang didasarkan pada filsafat, ilmu, seni, dan kepedulian berevolusi menjadi teori *Human Caring*. *Caritas* berarti menghargai, mengapresiasi, dan memberi perhatian khusus. *Carative* yaitu dimensi keperawatan yang lebih dalam dan luas yang menggabungkan kepedulian dengan cinta. Hubungan antara cinta dan kepedulian ini menyiratkan penyembuhan batin untuk diri sendiri dan orang lain (Smith & Parker, 2015).

Tabel 1.2. Konsep Utama dan Definisi Faktor *Carative*

No	Konsep Utama dan Definisi Faktor <i>Carative</i>
1.	<i>The formation of a humanistic-altruistic system of values.</i> Nilai-nilai humanistik dan altruistik dipelajari sejak dini, tetapi dapat sangat dipengaruhi oleh pendidik perawat. Faktor ini dapat didefinisikan sebagai kepuasan melalui pemberian dan perluasan rasa diri.
2.	<i>The Instillation of faith–hope.</i> Faktor ini, yang menggabungkan nilai-nilai humanistik dan altruistik, memfasilitasi promosi perawatan keperawatan holistik dan kesehatan positif dalam populasi klien. Faktor ini juga menggambarkan peran perawat dalam mengembangkan hubungan perawat-klien yang efektif dan dalam mempromosikan kesejahteraan dengan membantu klien mengadopsi perilaku mencari kesehatan.
3.	<i>The Cultivation of Sensitivity to Self and Others.</i> Pengenalan perasaan mengarah pada aktualisasi diri melalui penerimaan diri bagi perawat dan klien. Ketika perawat mengakui kepekaan dan perasaan mereka, mereka menjadi lebih tulus, autentik, dan peka terhadap orang lain (klien).
4.	<i>Development of a Helping-Trust Relationship.</i> Pengembangan hubungan saling membantu dan percaya antara perawat dengan klien sangat penting untuk perawatan transpersonal. Hubungan saling percaya mendorong dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif. Ini melibatkan keselarasan, empati, kehangatan yang tidak posesif, dan komunikasi yang efektif. Empati adalah kemampuan untuk mengalami dan dengan demikian memahami persepsi dan perasaan orang lain dan mengomunikasikan pemahaman tersebut. Kehangatan yang tidak posesif ditunjukkan oleh: volume bicara yang sedang, postur tubuh yang terbuka dan rileks, dan ekspresi wajah yang sesuai.
5.	<i>The Promotion and Acceptance of the Expression of Positive and Negative Feelings.</i> Perasaan merupakan pengalaman yang berisiko bagi perawat dan klien. Perawat harus siap menghadapi perasaan positif atau negatif. Perawat harus memahami perbedaan pemahaman intelektual dan emosional.
6.	<i>The Systematic Use of the Scientific Problem-Solving Method for Decision Making.</i> Penggunaan proses keperawatan membawa pendekatan pemecahan masalah ilmiah pada keperawatan, menghilangkan citra tradisional perawat sebagai pembantu dokter. Proses keperawatan mirip dengan proses penelitian karena bersifat sistematis dan terorganisasi.
7.	<i>The Promotion of Interpersonal Teaching-Learning.</i> Faktor ini merupakan konsep penting dalam keperawatan karena memisahkan perawatan dari penyembuhan. Hal ini memungkinkan klien untuk mendapatkan informasi dan mengalihkan tanggung jawab atas kesejahteraan dan kesehatan kepada klien. Perawat memfasilitasi proses ini dengan teknik belajar-mengajar yang dirancang untuk memungkinkan klien memberikan perawatan diri,

menentukan kebutuhan pribadi, dan memberikan kesempatan bagi pertumbuhan pribadi mereka.

8. *The Provision for a Supportive, Protective, and Corrective Mental, Physical, Sociocultural, and Spiritual Environment.* Perawat harus mengenali pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap kesehatan dan penyakit individu. Konsep yang relevan dengan lingkungan internal meliputi kesejahteraan mental dan spiritual serta keyakinan sosiokultural individu. Selain variabel epidemiologi, variabel eksternal lainnya meliputi kenyamanan, privasi, keamanan, dan lingkungan yang bersih dan estetik juga harus dikenali oleh perawat.
 9. *The Assistance with Gratification of Human Needs.* Perawat mengenali kebutuhan biofisik, psikofisik, psikososial, dan intrapersonal dari diri sendiri dan klien. Klien harus memenuhi kebutuhan tingkat rendah sebelum berusaha mencapai kebutuhan tingkat tinggi. Makanan, eliminasi, dan ventilasi adalah contoh kebutuhan biofisik tingkat rendah, sedangkan aktivitas, ketidakaktifan, dan seksualitas dianggap sebagai kebutuhan psikofisik tingkat rendah. Prestasi dan afiliasi adalah kebutuhan psikososial tingkat tinggi. Aktualisasi diri adalah kebutuhan intrapersonal-interpersonal tingkat tinggi.
 10. *The Allowance for Existential-Phenomenological Forces.* Fenomenologi menggambarkan data situasi langsung yang membantu orang memahami fenomena yang dimaksud. Psikologi eksistensial adalah ilmu tentang eksistensi manusia yang menggunakan analisis fenomenologis. Watson menganggap faktor ini sulit dipahami. Faktor ini dimasukkan untuk memberikan pengalaman yang menggugah pikiran, yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan orang lain. Watson percaya bahwa perawat memiliki tanggung jawab untuk melampaui 10 faktor karatif dan memfasilitasi perkembangan klien di bidang promosi kesehatan melalui tindakan kesehatan preventif. Sasaran ini dicapai dengan mengajarkan klien perubahan pribadi untuk meningkatkan kesehatan, memberikan dukungan situasional, mengajarkan metode pemecahan masalah, dan mengenali keterampilan mengatasi masalah dan adaptasi terhadap kehilangan.
-

Sumber: (Alligood, 2014a)

3. Patricia Benner: From Novice to Expert

Teori *From Novice to Expert* merupakan *Grand Theory* oleh Patricia Benner (1984) yang memberikan pandangan filosofis lain tentang keperawatan dengan penekanan pada hakikat praktik keperawatan, khususnya bagaimana pengetahuan praktik diperoleh dan bagaimana pengetahuan itu berkembang seiring waktu. Ini dihasilkan dari penelitian interpretatifnya tentang

perkembangan perawat dari pemula menjadi ahli dan kesadaran akan pentingnya kepedulian dalam keperawatan. Karya Benner telah digunakan untuk memandu pemeriksaan inovasi dan perubahan praktik keperawatan. Benner menilai pendidikan keperawatan untuk rekomendasi peningkatan kualitas. Karyanya memandu perawatan klien, dan pengembangan pengetahuan keperawatan (Alligood, 2014b).

Konsep metaparadigma dari perspektif Benner adalah sebagai berikut: (Alligood, 2014a)

a. Keperawatan

Keperawatan digambarkan sebagai hubungan yang penuh perhatian, sebuah kondisi yang memungkinkan adanya hubungan dan perhatian. Keperawatan adalah hal yang utama karena kepedulian menciptakan kemungkinan untuk memberi dan menerima bantuan. Keperawatan dipandang sebagai praktik kepedulian yang ilmunya dipandu oleh seni, moral dan etika, kepedulian, dan tanggung jawab.

b. Orang

Benner menggunakan deskripsi fenomenologis Heidegger tentang orang, yang mereka gambarkan sebagai seseorang adalah makhluk yang menafsirkan dirinya sendiri, yaitu orang tersebut tidak datang ke dunia yang telah ditentukan sebelumnya tetapi didefinisikan dalam perjalanan hidup. Benner mengonseptualisasikan empat aspek utama pemahaman berikut yang harus dihadapi oleh orang, yaitu peran situasi, peran tubuh, peran perhatian pribadi, peran temporalitas.

c. Kesehatan

Benner berfokus pada pengalaman hidup menjadi sehat dan sakit. Kesehatan didefinisikan sebagai apa yang dapat dinilai, sedangkan kesejahteraan adalah pengalaman manusia akan kesehatan atau keutuhan. Kesejahteraan dan sakit dipahami sebagai cara yang berbeda untuk berada di dunia. Kesehatan digambarkan bukan hanya tidak adanya penyakit dan sakit. Sakit merupakan pengalaman manusia akan kehilangan atau disfungsi, sedangkan penyakit adalah apa yang dapat dinilai pada tingkat fisik.

d. Situasi

Benner menggunakan istilah situasi daripada lingkungan, karena situasi menyampaikan lingkungan sosial dengan definisi dan makna sosial. Benner menggunakan istilah fenomenologis yang disebut situasional dan makna situasional, yang didefinisikan oleh interaksi, interpretasi, dan pemahaman orang yang terlibat terhadap situasi tersebut. Interpretasi pribadi terhadap situasi dibatasi oleh cara individu berada di dalamnya. Ini berarti bahwa masa

lalu, masa kini, dan masa depan setiap orang, yang mencakup makna, kebiasaan, dan perspektif pribadinya sendiri, memengaruhi situasi saat ini.

Dalam konsep yang dikembangkan, Benner juga mengembangkan *Critical Thinking in Nursing Practice with Benner's Philosophy*. Benner mengidentifikasi enam aspek penilaian klinis dan perilaku terampil yang dapat dilihat sebagai aspek interpretatif dari pemikiran kritis (Alligood, 2014b).

Tabel 1.3. Critical Thinking in Nursing Practice with Benner's Philosophy

Aspek Penilaian Klinis dan Perilaku Terampil	Definisi
<i>Reasoning in transition</i>	Penalaran praktis dalam situasi klinis yang sedang berlangsung
<i>Skilled know-how</i>	Kinerja cerdas yang diwujudkan, yang melibatkan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana melakukannya
<i>Response-based practice</i>	Menyesuaikan intervensi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan klien yang dinamis
<i>Agency</i>	Perasaan dan kemampuan seseorang untuk bertindak atau mempengaruhi suatu situasi
<i>Perceptual acuity and involvement</i>	Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan suatu situasi dan fokus pada isu-isu penting dengan melibatkan masalah dan orang terkait
<i>Links between clinical and ethical reasoning</i>	Memahami bahwa praktik klinis yang baik tidak dapat dipisahkan dari gagasan etika tentang hasil yang baik bagi klien dan keluarga

Sumber: (Alligood, 2014b)

4. Dorothy Johnson: Behavioral System Model

Behavioral System Model dicetuskan dan dikembangkan oleh Dorothy Johnson saat menjadi profesor keperawatan di University of California, Los Angeles yang merupakan kategori *Grand Theory*. Teori Johnson ini untuk menyajikan pandangan klien sebagai sistem terbuka yang hidup. Klien dilihat sebagai kumpulan subsistem perilaku yang saling berhubungan untuk membentuk sistem perilaku. Oleh karena itu, perilaku adalah sistem, bukan individu. Sistem perilaku ini dicirikan oleh perilaku yang berulang, teratur, dapat diprediksi, dan diarahkan pada tujuan yang selalu berusaha mencapai keseimbangan (Alligood, 2014b).

Johnson menyatakan bahwa kontribusi khusus keperawatan terhadap kesejahteraan klien sebagai upaya untuk membina fungsi perilaku yang efisien dan efektif pada seseorang, baik untuk mencegah penyakit maupun selama dan setelah sakit. Johnson berpendapat bahwa keperawatan berkontribusi dengan memfasilitasi fungsi perilaku yang efektif pada klien sebelum, selama, dan setelah sakit. Salah satu asumsi dasar Johnson mencakup konsep keteraturan. Serangkaian unit yang berinteraksi yang membentuk keseluruhan yang dimaksudkan untuk melakukan beberapa fungsi. Johnson mengonseptualisasikan orang sebagai sistem perilaku di mana perilaku individu secara keseluruhan menjadi fokusnya yaitu pada apa yang dilakukan individu dan mengapa individu tersebut melakukannya. Salah satu kekuatan teori yang dikembangkan Johnson adalah integrasi konsep yang konsisten yang mendefinisikan sistem perilaku yang diambil dari teori Sistem Umum. Beberapa konsep ini meliputi holisme, pencarian tujuan, hubungan timbal balik/saling ketergantungan, stabilitas, ketidakstabilan, subsistem, keteraturan, struktur, fungsi, energi, umpan balik, dan adaptasi (Alligood, 2014a).

Konsep metaparadigma dari perspektif teori Johnson adalah sebagai berikut: (Alligood, 2014a)

a. Keperawatan

Johnson mendeskripsikan bahwa tujuan keperawatan adalah untuk mempertahankan serta memulihkan keseimbangan dan stabilitas sistem perilaku seseorang. Ia berpendapat bahwa keperawatan merupakan kekuatan eksternal untuk menjaga integrasi perilaku klien ke tingkat yang optimal dengan menerapkan mekanisme pengaturan/kontrol sementara terhadap klien. Sebagai seni dan sains, keperawatan memberikan bantuan eksternal baik sebelum maupun selama gangguan keseimbangan sistem, sehingga memerlukan pengetahuan tentang keteraturan, ketidakaturan, dan kontrol. Aktivitas keperawatan tidak bergantung pada otoritas medis, tetapi bersifat melengkapi kedokteran.

b. Orang

Orang merupakan sistem perilaku dengan pola, repetitif, dan cara berperilaku yang bertujuan menghubungkan orang tersebut dengan lingkungan. Johnson berpendapat bahwa faktor biologis bawaan memengaruhi pola dan motivasi perilaku. Ia juga mengakui bahwa pengalaman sebelumnya, pembelajaran, dan rangsangan fisik dan sosial juga memengaruhi perilaku. Johnson menyatakan bahwa perawat harus memiliki kemampuan untuk memandang seseorang sebagai sistem perilaku, mengamati kumpulan subsistem perilaku, dan memiliki pengetahuan tentang faktor fisiologis, psikologis, dan sosiokultural

yang beroperasi di luar mereka. Orang-orang terus berupaya untuk mempertahankan keseimbangan dan kondisi stabil sistem perilaku dengan penyesuaian dan adaptasi yang secara otomatis terhadap kekuatan alami yang memengaruhi mereka. Johnson juga menyadari bahwa orang-orang secara aktif mencari pengalaman baru yang mungkin mengganggu keseimbangan untuk sementara waktu.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi dinamis yang sulit dipahami dan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kesehatan tercermin dari organisasi, interaksi, saling ketergantungan, dan integrasi subsistem dari sistem perilaku. Seorang individu berusaha mencapai keseimbangan dalam sistem ini, yang akan mengarah pada perilaku fungsional. Kurangnya keseimbangan akan menyebabkan kesehatan yang buruk, sehingga ketika mengevaluasi kesehatan maka seseorang berfokus pada sistem perilaku, keseimbangan, dan stabilitas.

d. Lingkungan

Johnson memandang lingkungan terdiri dari semua faktor yang bukan bagian dari sistem perilaku individu, tetapi memengaruhi sistem tersebut. Perawat dapat memanipulasi beberapa aspek lingkungan sehingga tujuan kesehatan atau keseimbangan sistem perilaku dapat tercapai bagi klien. Perilaku dapat diprediksi dan dipertahankan karena telah berfungsi secara efisien dan efektif hampir sepanjang waktu dalam mengelola hubungan orang tersebut dengan lingkungan. Perilaku tersebut berubah ketika hal ini tidak lagi terjadi, atau ketika orang tersebut menginginkan tingkat fungsi yang lebih optimal. Sistem perilaku berusaha mempertahankan keseimbangan sebagai respons terhadap faktor lingkungan dengan menyesuaikan dan beradaptasi dengan kekuatan yang memengaruhinya.

5. Martha E. Rogers: Unitary Human Beings

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Rogers pada tahun 1970 yang merupakan *Grand Theory*. Gagasannya bersifat revolusioner dan menantang keperawatan untuk mendekati perawat dari sudut pandang dunia yang holistik dan dinamis. Dalam teorinya, manusia dikonseptualisasikan sebagai medan energi yang dinamis dan terus berkembang, bukan sebagai makhluk homeostatis. Manusia dan lingkungan terus-menerus bertukar energi, dan tidak terdapat batasan atau hambatan yang menghambat aliran energi tersebut. Manusia secara terbuka berpartisipasi dalam transformasi energi dengan lingkungan yang menciptakan perubahan bersama. Manusia yang utuh layak medan energi yang tidak dapat direduksi, tidak dapat dibagi, dan memiliki dimensi yang berbeda-beda. Proses kehidupan manusia yang utuh merupakan

proses yang utuh dan berkelanjutan serta terus mengalami perubahan secara dinamis dan kreatif (Alligood, 2014b).

Konseptual dalam paradigmanya tahun 1983, Rogers membagi empat blok layaknya bangunan untuk teorinya, yaitu: *energy field, universe of open systems, pattern, and four-dimensionality* (Alligood, 2014a).

a. *Energi Field* (Medan Energi)

Medan energi merupakan unit fundamental dari makhluk hidup dan tak hidup yang sifatnya tidak terbatas. Secara khusus manusia dan lingkungan adalah medan energi di mana manusia didefinisikan sebagai medan energi yang tidak dapat direduksi, tidak dapat dibagi, yang diidentifikasi oleh pola dan karakteristik yang nyata, serta tidak dapat diprediksi dari pengetahuan tentang bagian-bagiannya. Medan lingkungan didefinisikan sebagai medan energi yang tidak dapat direduksi, yang diidentifikasi oleh pola dan integral dengan medan manusia. Setiap medan lingkungan spesifik untuk medan manusia yang diberikan. Meskipun tidak selalu dapat diukur, medan energi memiliki kemampuan inheren untuk menciptakan perubahan, baik manusia dan lingkungan berubah secara terus-menerus, kreatif, dan integral.

b. *Universe of Open Systems* (Semesta Sistem Terbuka)

Konsep semesta sistem terbuka menyatakan bahwa medan energi tidak terbatas, terbuka, dan integral satu sama lain. Medan manusia dan lingkungan berada dalam proses berkelanjutan dan merupakan sistem terbuka.

c. *Pattern* (Pola)

Pola merupakan karakteristik pembeda medan energi dan dianggap sebagai gelombang tunggal. Sifat pola berubah secara terus-menerus dan inovatif, dan perubahan ini memberikan identitas pada medan energi. Setiap pola medan manusia bersifat unik dan integral dengan medan lingkungan.

d. *Pandimensionality* (Pandimensionalitas)

Rogers mendefinisikan pandimensionalitas sebagai domain nonlinier yang pada dasarnya merupakan realitas tanpa ruang dan waktu. Istilah pandimensional menyediakan domain tanpa batas. Istilah ini paling tepat mengekspresikan gagasan tentang keseluruhan yang terpadu.

Konsep metaparadigma dari perspektif teori Rogers adalah sebagai berikut: (Alligood, 2014a)

a. Keperawatan

Keperawatan adalah ilmu sekaligus seni. Keperawatan menurut Rogers berfokus pada perhatian terhadap manusia dan dunia tempat mereka tinggal yang mencakup manusia dan lingkungan mereka. Keutuhan manusia dan lingkungan beroperasi dari alam semesta multidimensi sistem terbuka,

mengarah ke paradigma baru dan memulai identitas keperawatan sebagai ilmu. Tujuan keperawatan adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Seni keperawatan adalah penggunaan kreatif ilmu keperawatan untuk perbaikan manusia. Praktik profesional dalam keperawatan berusaha untuk meningkatkan interaksi simfoni antara bidang manusia dan lingkungan, untuk memperkuat integritas bidang manusia, dan untuk mengarahkan kembali pola medan manusia dan lingkungan untuk mewujudkan potensi kesehatan yang maksimal.

b. Orang

Rogers mendefinisikan orang sebagai sistem terbuka dalam proses berkelanjutan dengan sistem lingkungan secara integralitas. Ia mendefinisikan orang sebagai kesatuan medan energi yang tidak dapat direduksi dan dibagi. Dalam teorinya, orang dan lingkungannya dianggap sebagai medan energi yang secara integral satu sama lain dan terus-menerus kreatif dalam evolusi mereka.

c. Kesehatan

Rogers menggunakan istilah kesehatan pasif untuk melambangkan kesejahteraan dan tidak adanya penyakit dan penyakit berat. Konsepnya terhadap kesehatan positif menyiratkan arah dalam membantu orang dengan peluang untuk konsistensi ritmis. Ia berpendapat bahwa kesejahteraan adalah istilah yang jauh lebih baik karena istilah kesehatan sangat ambigu. Kesehatan dan penyakit adalah gambaran dari pola dapat menunjukkan perilaku yang bernilai tinggi dan bernilai rendah. Peristiwa yang terwujud dalam proses kehidupan menunjukkan sejauh mana manusia mencapai kesehatan maksimal menurut beberapa sistem nilai.

d. Lingkungan

Rogers mendefinisikan lingkungan sebagai medan energi pandimensional yang tidak dapat direduksi yang diidentifikasi oleh pola dan mewujudkan karakteristik yang berbeda dari bagian-bagiannya. Setiap medan lingkungan bersifat khusus untuk medan manusia yang diberikan. Keduanya berubah secara terus-menerus dan kreatif. Medan lingkungan tidak terbatas, dan perubahan terus-menerus bersifat inovatif, tidak dapat diprediksi, dan dicirikan oleh meningkatnya keanekaragaman. Medan lingkungan dan manusia diidentifikasi oleh pola gelombang yang mewujudkan perubahan bersama yang berkelanjutan.

6. Dorothea E. Orem: Self-Care Deficit Nursing Theory

Orem pertama kali mengembangkan teorinya melalui karya-karyanya yang dimulai pada tahun 1950an yang merupakan salah satu *Grand Theory*

keperawatan. Orem berupaya mengembangkan struktur teoritis yang akan berfungsi sebagai kerangka kerja pengorganisasian untuk badan pengetahuan keperawatan. Sumber utama gagasan Orem tentang keperawatan adalah pengalamannya dalam keperawatan. Melalui refleksi pada situasi praktik keperawatan, ia mampu mengidentifikasi objek atau fokus keperawatan yang tepat. Sejak awal, Orem menyadari bahwa jika keperawatan ingin maju sebagai bidang pengetahuan dan sebagai bidang praktik, diperlukan badan pengetahuan keperawatan yang terstruktur dan terorganisir (Alligood, 2014a).

Dalam teorinya, Orem menyatakan bahwa keperawatan termasuk dalam kelompok layanan kesehatan yang diselenggarakan untuk memberikan perawatan langsung kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk berbagai bentuk perawatan langsung karena kondisi kesehatan mereka. Seperti layanan kesehatan langsung lainnya, keperawatan memiliki ciri-ciri sosial dan interpersonal yang mencirikan hubungan saling membantu antara mereka yang membutuhkan perawatan dan mereka yang memberikan perawatan yang dibutuhkan. Perbedaannya yaitu terletak pada layanan kesehatan keperawatan dengan pelayanan kesehatan lain lain adalah layanan bantuan yang diberikan masing-masing. *Self-Care Deficit Theory* yang dikembangkan Orem memberikan konseptualisasi layanan bantuan yang berbeda yang diberikan oleh keperawatan (Alligood, 2014a).

Praktik keperawatan yang berorientasi pada teori Orem merupakan pendekatan kepedulian yang menggunakan pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan khusus (sains) untuk merancang dan menghasilkan asuhan keperawatan. Pengetahuan empiris berakar pada pengalaman dan membahas kejadian tertentu dan kondisi terkait yang relevan bagi kesehatan dan kesejahteraan. Pengetahuan empirislah yang mendukung pengamatan, interpretasi makna pengamatan tersebut, dan korelasi makna dengan tindakan yang mungkin dilakukan (Alligood, 2014b).

Konsep metaparadigma dari perspektif teori Orem adalah sebagai berikut: (Comley, 1994)

a. Keperawatan

Keperawatan adalah layanan bantuan, seni dan teknologi. Mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan seseorang untuk merawat diri sendiri dan membantu orang tersebut mempertahankan perawatan diri tersebut pada tingkat terapeutik adalah domain unik keperawatan.

b. Orang

Orang merupakan keseluruhan yang terintegrasi, suatu kesatuan yang berfungsi secara biologis, simbolik dan sosial. Seseorang mempunyai kapasitas untuk mengetahui dirinya sendiri dan untuk terlibat dalam tindakan yang disengaja

c. Lingkungan

Dalam teorinya Orem menamainya lingkungan perkembangan yaitu sekumpulan kondisi psikososial dan/atau fisik yang mendorong penetapan dan pencapaian tujuan yang tepat, meningkatkan kreativitas dan konsep diri, mengubah sikap dan nilai, serta mendorong pertumbuhan fisik.

d. Kesehatan

Konsep kesehatan Orem adalah holistik dan sebagai proses yang dinamis. Orem menggambarkan kesehatan sebagai perkembangan terpadu yang progresif dari manusia sebagai kesatuan individu yang bergerak menuju tingkat integrasi yang lebih tinggi.

7. Betty Neuman: System Model Theory

System Model Theory Neuman pertama kali dikembangkan pada tahun 1970 yang ditujukan untuk membantu mahasiswa mempertimbangkan kebutuhan klien secara holistik yang merupakan *Grand Theory*. Model Neuman mengidentifikasi struktur dasar sumber daya energi, variabel, batas sistem, dan lingkungan sebagai sub-bagian inti dari sistem. Di bagian inti diagram, sumber daya energi diidentifikasi. Pertukaran energi yang konstan terjadi antara sistem klien dan lingkungan. Klien mempertahankan dan menambah stabilitas sistem dengan menggunakan energi, yang dianggap sebagai kekuatan positif yang tersedia bagi sistem. Dengan demikian, stabilitas tidak statis tetapi adaptif dan bersifat perkembangan karena sistem klien dianggap sebagai sistem terbuka dalam keadaan perubahan yang konstan. Serangkaian cincin pelindung mengelilingi struktur pusat dan melindungi sistem dari stresor lingkungan. Setiap komponen sistem berpotongan dengan lima variabel (fisiologis, psikologis, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual). Kelima variabel ini berinteraksi secara sinergis dan holistik dalam semua bagian sistem klien (Alligood, 2014b).

Konsep metaparadigma dari perspektif teori Neuman adalah sebagai berikut:

a. Orang

Orang dipandang sebagai klien atau sistem klien yang terdiri dari fitur bawaan yang tertanam dalam struktur tertentu. Seseorang, keluarga, komunitas, atau masalah sosial merupakan gabungan variabel (fisiologis, psikologis, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual) yang terdiri dari struktur inti atau

faktor kelangsungan hidup esensial dan cincin pertahanan konsentris di sekitarnya. Sistem klien mengembangkan serangkaian pertahanan yang digunakan sebagai perlindungan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang disebut garis pertahanan. Garis pertahanan normal dapat diartikan sebagai tingkat kesehatan klien yang biasa (Hannood & Dhamoon, 2023)

b. Keperawatan

Neuman percaya bahwa keperawatan berkaitan dengan keseluruhan pribadi seseorang. Ia memandang keperawatan sebagai profesi unik yang berkaitan dengan semua variabel yang memengaruhi respons individu terhadap stres. Persepsi perawat memengaruhi perawatan yang diberikan, oleh karena itu persepsi pengasuh dan klien harus dinilai (Alligood, 2014a).

c. Kesehatan

Neuman memandang kesehatan sebagai rangkaian kesehatan hingga penyakit yang sifatnya dinamis dan terus berubah. Neuman menyatakan bahwa kesehatan atau stabilitas yang optimal jika kebutuhan sistem secara keseluruhan telah terpenuhi. Kondisi kesehatan yang menurun merupakan hasil dari kebutuhan sistemik yang tidak terpenuhi (Alligood, 2014a).

d. Lingkungan

Lingkungan merupakan semua faktor internal dan eksternal yang memengaruhi sistem klien. Stresor yang bersumber secara intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal signifikan terhadap konsep lingkungan dan dijelaskan sebagai kekuatan lingkungan yang berinteraksi dengan dan berpotensi mengubah stabilitas sistem. Neuman mengidentifikasi tiga jenis lingkungan yaitu lingkungan internal bersifat intrapersonal, dengan semua interaksi yang terkandung dalam diri klien. Lingkungan eksternal bersifat interpersonal atau ekstrapersonal, dengan semua faktor yang timbul dari luar klien. Lingkungan yang diciptakan dikembangkan secara tidak sadar dan digunakan oleh klien untuk mendukung penanganan yang protektif (Jukes & Spencer, 2007).

8. Imogene M. King: Theory of Goal Attainment

Teori King yang masuk dalam kategori *Grand Theory* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah fokus keperawatan. King menyatakan bahwa ranah keperawatan melibatkan manusia, keluarga, dan komunitas sebagai kerangka kerja tempat perawat melakukan transaksi di berbagai lingkungan dengan kesehatan sebagai sasaran. Keterkaitan antara interaksi dan kesehatan adalah perilaku, atau tindakan manusia. Perawat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengamati dan menginterpretasikan perilaku dan

melakukan intervensi dalam ranah perilaku untuk membantu individu dan kelompok mengatasi kesehatan, penyakit, dan krisis (Alligood, 2014b).

Dalam teori *Goal Attainment* menekankan interaksi antara perawat dengan klien. Perawat dan klien yang saling hadir, berinteraksi dengan tujuan, melakukan transaksi dalam situasi keperawatan berdasarkan persepsi masing-masing individu, komunikasi yang memiliki tujuan bernilai. Perawat dan klien membentuk sistem interpersonal di mana masing-masing memengaruhi yang lain dan keduanya dipengaruhi oleh faktor situasional di lingkungan. Teori ini mencakup konsep persepsi, komunikasi, interaksi, transaksi, diri, peran, pertumbuhan dan perkembangan, stres/stresor, penanggulangan, waktu, dan ruang personal. King mengidentifikasi bahwa persepsi, komunikasi, dan interaksi merupakan elemen penting dalam transaksi. Proses keperawatan tradisional sebagai sistem tindakan yang saling terkait (Alligood, 2014b).

Konsep metaparadigma dari perspektif teori King adalah sebagai berikut: (Rojas, Contrera, Velásquez, Grandon, & Palacios, 2023)

a. Kesehatan

Kesehatan merupakan pengalaman dinamis penyesuaian berkelanjutan terhadap pemicu stres internal dan eksternal yang dapat dicapai melalui penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan sehari-hari.

b. Keperawatan

King memandang keperawatan sebagai perilaku yang dapat diamati ditemukan dalam sistem kesehatan masyarakat.

c. Orang

King memandang orang sebagai makhluk yang unik, spiritual, dan holistik dengan nilai intrinsik, dengan kapasitas untuk berpikir dan membuat keputusan rasional dalam sebagian besar situasi, dan dengan kemampuan untuk melestarikan budaya mereka. Setiap individu berbeda dalam kebutuhan, keinginan, dan tujuan mereka.

d. Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat terjadinya interaksi manusia, pemahaman terhadap interaksi tersebut amatlah penting bagi keperawatan.

9. Sister Callista Roy: Adaptation Model

Suster Callista Roy merupakan murid dari Dorothy E. Johnson yang mengembangkan *Adaptation Model* pada tahun 1964 yang merupakan salah satu *Grand Theory* keperawatan (Alligood, 2014b). Model Adaptasi yang dikembangkan oleh Roy menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk menangani kebutuhan adaptif individu, keluarga, dan kelompok. Manusia terus-

menerus menanggapi berbagai rangsangan lingkungan internal dan eksternal. Stimulus adalah entitas apa pun yang memicu respons yang berfungsi sebagai titik interaksi antara orang tersebut dengan lingkungan. Stimulus lingkungan mengancam atau meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi. Keperawatan memainkan peran penting dalam membantu individu yang sakit atau sehat untuk menanggapi berbagai pemicu stres baru, bergerak menuju kesejahteraan yang optimal, dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui adaptasi (Roy, 1988).

Roy mengkategorikan jenis rangsangan ini menjadi tiga yaitu fokal, kontekstual, atau residual. Jenis rangsangan fokal didefinisikan sebagai rangsangan internal atau eksternal yang paling langsung menantang adaptasi orang tersebut yang berisi fenomena yang paling menarik perhatian seseorang. Rangsangan kontekstual adalah semua rangsangan lain yang ada dalam suatu situasi yang memperkuat efek rangsangan fokal. Rangsangan residual adalah fenomena lain yang muncul dari lingkungan internal atau eksternal seseorang yang dapat memengaruhi rangsangan fokal tetapi efeknya tidak jelas. Ketiga jenis rangsangan tersebut bekerja bersama dan memengaruhi tingkat adaptasi, yang merupakan kemampuan seseorang untuk merespons secara positif dalam suatu situasi (Alligood, 2014b).

Konsep metaparadigma dari perspektif teori Roy adalah sebagai berikut: (Masters, 2014)

a. Orang

Menurut Roy manusia adalah sebuah sistem holistik serta adaptif. Manusia digambarkan sebagai satu kesatuan dengan bagian-bagian yang berfungsi sebagai kesatuan untuk suatu tujuan. Manusia mencakup individu atau dalam kelompok, termasuk keluarga, organisasi, komunitas, dan secara keseluruhan masyarakat. Manusia memiliki kapasitas berpikir dan merasakan sehingga mereka dapat menyesuaikan diri secara efektif terhadap perubahan lingkungan.

b. Lingkungan

Lingkungan merupakan seluruh keadaan dan pengaruh yang mempengaruhi perkembangan serta perilaku seseorang atau kelompok. Lingkungan yang berubah dapat merangsang orang untuk membuat respons adaptif yang melibatkan faktor internal dan eksternal. Setiap perubahan lingkungan menuntut peningkatan energi untuk beradaptasi dengan situasi tersebut.

c. Kesehatan

Kesehatan adalah kondisi dan proses menjadi pribadi yang terintegrasi dan utuh. Kesehatan adalah refleksi dari adaptasi, yaitu interaksi antara orang

dengan lingkungan. Adaptasi merupakan proses untuk meningkatkan integritas antara variabel fisiologis, psikologis, dan sosial. Integritas menyiratkan kondisi yang tidak terganggu yang mengarah pada kelengkapan atau kesatuan.

d. Keperawatan

Keperawatan merupakan profesi kesehatan yang fokus pada proses dan pola kehidupan manusia serta menekankan peningkatan kesehatan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Keperawatan adalah ilmu dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan adaptif dan meningkatkan transformasi antara orang dan lingkungan.

10. Katie Eriksson: Theory of Caritative Caring

Sejak tahun 1970-an, Eriksson secara sistematis memperdalam pemikirannya tentang *Caring* melalui pengembangan model ideal dan pengembangan ilmu *caring* yang otonom dan berorientasi pada kemanusiaan, ini menjadi dasar lahirnya teori *Grand Theory "Caritative Caring"* (Alligood, 2014a). Inti dalam teori *caritative caring* terdiri dari pemikiran tentang cinta, belas kasihan, dan kasih sayang yang menjadi objek dasar pengetahuan dalam ilmu *caring* untuk meringankan penderitaan dan meningkatkan serta melindungi kesehatan dan kehidupan. *Caring* juga berarti penyembuhan, berbagi, dan peduli terhadap sesama untuk menunjukkan kebaikan dan kasih sayang yang menjadi sumber dari semua kepedulian sejati. Kasih sayang dapat dipahami sebagai kepekaan terhadap penderitaan, yang berarti kemauan dan upaya untuk meringankan penderitaan sesama (Bergbom, Nâden, & Nyström, 2022)

Eriksson berpendapat bahwa perawatan dan kepedulian adalah seni dan ilmu pengetahuan dengan menggunakan model Otak-Tangan-Hati, yaitu sebuah simbol untuk perawatan dan kepedulian yang digunakan selama ratusan tahun. *Caring* yang sejati berlandaskan pada rasa kasih sayang, di mana kepedulian *caregiver* kepada orang lain merupakan struktur dasar. Iman, harapan, dan cinta merupakan inti dari caring (Bergbom et al., 2022). *Caritative* merupakan perasaan cinta dan kasih sayang tanpa syarat yang merupakan motif mendasar ilmu *caring*. *Caring* adalah upaya untuk memediasi iman, harapan, dan cinta melalui perawatan (Alligood, 2014a).

Konsep metaparadigma dari perspektif teori Eriksson adalah sebagai berikut: (Eriksson, 1989)

a. Kesehatan

Eriksson menyatakan bahwa memiliki kesehatan berarti memiliki perasaan keutuhan, integrasi, pertumbuhan dan kebebasan batin (Eriksson, 1989). Eriksson mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi yang prima, kesegaran, dan

kesejahteraan. Kesehatan menyiratkan keutuhan dalam tubuh, jiwa, dan roh. Kesehatan berarti sebagai konsep murni keutuhan dan kesucian. kesehatan dipahami sebagai gerakan menuju keutuhan dan kesucian yang lebih dalam. Ketika potensi kesehatan batin manusia tersentuh, sebuah gerakan terjadi yang menjadi terlihat dalam dimensi kesehatan yang berbeda (Alligood, 2014a).

b. Orang

Eriksson mengistilahkan orang dengan bahasa *human being*. Ia berasumsi bahwa manusia adalah kesatuan tubuh, jiwa dan roh. Pandangan holistik ini mencakup martabat dan kesucian manusia. Dengan demikian, kepedulian berarti menyembuhkan dan mendukung gerakan menuju integrasi dan keutuhan (Eriksson, 1989). Ia menekankan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk religius, tetapi tidak semua manusia mengakui dimensi ini. Manusia dilihat sebagai makhluk yang terus berubah dan karena itu tidak pernah dalam keadaan penyelesaian penuh (Alligood, 2014a).

c. Nursing

Eriksson memberikan pandangan holistik dalam perawatan profesional yang berarti kerja sama, misalnya dalam kerja tim dan konsultasi dalam kedokteran, perawatan kepedulian dan penyembuhan jiwa (Eriksson, 1989). Seorang perawat memancarkan *claritas*, atau kekuatan dan cahaya keindahan. Perawatan adalah sesuatu yang alami yang dibentuk oleh gagasan tentang keibuan, yang menyiratkan pembersihan dan pemeliharaan, serta cinta yang spontan dan tanpa syarat (Alligood, 2014a).

d. Lingkungan

Eriksson memandang lingkungan secara holistik. Ia menyebutkan lingkungan sebagai Etos yaitu keadaan alami rumah atau perasaan seseorang merasakan kenyamanan seperti di rumah. Dalam teorinya ia menyatakan bahwa Perawat memberikan perawatan holistik, dengan mempertimbangkan konteks fisik, psikologis, sosial, dan spiritual klien, untuk memfasilitasi penyembuhan (Alligood, 2014a).

11. Madeleine M. Leininger: Culture Care Theory of Diversity and Universality

Teori Leininger merupakan *Grand Theory* yang pada awalnya Ia kembangkan pada tahun 1950an. Leininger memiliki pandangan holistik tentang keperawatan yang menggabungkan beberapa konsep antropologis dengan komponen ilmu keperawatan yang akan berfokus pada manusia di dunia multikultural (Alligood, 2014b). McFarland & Alamah (2019) menyatakan bahwa tujuan dari teori Leininger untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan budaya yang berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan orang atau

membantu mereka menghadapi cacat, kematian, atau kematian dengan menggunakan tiga cara pengambilan keputusan dan tindakan perawatan berbasis budaya. Leininger (2006) dalam karya Alligood (2014b) menyatakan bahwa tujuan dari teori *Culture Care* adalah untuk menyediakan kepedulian keperawatan yang kongruen secara budaya, yang mengacu pada pengetahuan, tindakan, dan keputusan berbasis budaya yang digunakan dengan cara yang peka, tepat, dan bermakna menyesuaikan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan cara hidup klien demi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Tiga cara pengambilan keputusan dan tindakan perawatan berbasis budaya menurut Leininger yaitu: (McFarland & Alamah, 2018)

a. Pelestarian dan/atau Pemeliharaan Perawatan Berbasis Budaya

Tindakan atau keputusan profesional yang bersifat membantu, mendukung, memfasilitasi, atau memberdayakan budaya untuk mempertahankan, melestarikan, atau memelihara keyakinan dan nilai-nilai perawatan yang bermanfaat atau untuk menghadapi penyakit, kecacatan, kematian, dan ajal.

b. Akomodasi dan/atau Negosiasi Perawatan Berbasis Budaya

Tindakan atau keputusan perawatan penyedia layanan yang bersifat membantu, mengakomodasi, memfasilitasi untuk beradaptasi atau bernegosiasi dengan orang lain untuk perawatan yang sesuai dengan budaya, aman, dan efektif bagi kesehatan, kesejahteraan, atau untuk mengatasi penyakit, cedera, kecacatan, dan kematian.

c. Penataan Kembali Perawatan Berbasis Budaya

Tindakan profesional yang bersifat membantu, mendukung, memfasilitasi, atau memungkinkan dalam pengambilan keputusan bersama yang akan membantu orang-orang mengatur ulang, mengubah, memodifikasi, atau menata kembali cara hidup mereka untuk mencapai pola, praktik, atau hasil perawatan kesehatan yang lebih baik.

Konsep metaparadigma dari perspektif teori Leininger adalah sebagai berikut: (Alligood, 2014a)

a. Keperawatan

Leininger berpendapat bahwa keperawatan pada hakikat terfokus, sentral, dan pemersatu. Keperawatan transkultural adalah disiplin dan profesi perawatan humanistik dan ilmiah dengan tujuan utama untuk melayani individu, kelompok, komunitas, masyarakat, dan institusi. Perawatan berbasis budaya sangat penting untuk kesejahteraan, kesehatan, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup, dan untuk menghadapi cacat atau kematian. Perawatan berbasis budaya adalah metode yang komprehensif dan holistik untuk

mengetahui, menjelaskan, menafsirkan, dan memprediksi fenomena dan untuk memandu pengambilan keputusan dan tindakan keperawatan.

b. Orang

Leininger berasumsi bahwa Setiap budaya manusia memiliki pengetahuan dan praktik perawatan generik dan biasanya pengetahuan dan praktik perawatan profesional bervariasi secara lintas budaya dan individual. Nilai budaya, kepercayaan, dan praktik perawatan seseorang dipengaruhi oleh kecenderungan yang tertanam dalam pandangan dunia, bahasa, filsafat, agama (spiritualitas), kekerabatan, sosial, politik, hukum, pendidikan, ekonomi, teknologi, etnohistoris, dan konteks lingkungan budaya.

c. Kesehatan

Leininger berasumsi bahwa kesehatan dan kesejahteraan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat didapatkan melalui perawatan yang berlandaskan budaya dalam konteks lingkungan mereka. Perawatan yang bermanfaat dan selaras dengan budaya hanya dapat terjadi jika nilai, ekspresi, atau pola perawatan diketahui dan digunakan secara eksplisit untuk perawatan yang tepat, aman, dan bermakna.

d. Lingkungan

Leininger memandang lingkungan menggunakan pandangan budaya. Ia menyatakan bahwa konflik budaya merupakan cerminan dari kurangnya pengetahuan perawatan berbasis budaya untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan budaya, bertanggung jawab, aman, dan peka. Oleh karena itu metode penelitian kualitatif etnonursing memberikan cara penting untuk menemukan dan menafsirkan secara akurat data perawatan berbasis budaya yang tertanam, kompleks, dan beragam secara etnik dan etik di lingkungan masyarakat.

12. Katharine Kolcaba: Theory of Comfort

Middle Range Theory "Comfort Theory" (Teori Kenyamanan) dikembangkan Kolcaba pada tahun 1994 saat ia menjalani program studi doktoral di Case Western Reserve University. Dalam teorinya dia menyatakan bahwa kenyamanan adalah kata benda atau kata sifat dan hasil dari perawatan berkualitas yang disengaja, berfokus pada klien/keluarga. Kolcaba berasumsi bahwa kenyamanan adalah kebutuhan dasar, orang mengalami kenyamanan secara holistik, tindakan menghibur diri sendiri bisa sehat atau tidak sehat, dan meningkatkan kenyamanan dengan cara yang sehat mengarah pada produktivitas yang lebih besar (Smith & Parker, 2015).

Kolcaba menyebutkan bahwa terdapat tiga tipe kenyamanan, yaitu: (Kolcaba & Fisher, 1996)

- a. Keadaan terpenuhinya kebutuhan kenyamanan tertentu yang Ia sebut sebagai *Relief*
- b. Keadaan tenang atau puas yang Ia sebut sebagai *Ease*, dan
- c. Keadaan di mana seseorang dapat bangkit dari masalah atau rasa sakit, yang Ia sebut sebagai *Transcendence*.

Selain itu Kolcaba juga menyebutkan bahwa terdapat empat konteks kenyamanan, yaitu: (Kolcaba & Fisher, 1996)

- a. Fisik

Kenyamanan fisik berkaitan dengan sensasi tubuh, mekanisme homeostatis, fungsi kekebalan tubuh, dan kenyamanan fisik lainnya.

- b. Psikospiritual

Kenyamanan ini berkaitan dengan kesadaran internal tentang diri sendiri, termasuk harga diri, identitas, seksualitas, makna hidup seseorang, dan hubungan yang dipahami seseorang dengan tatanan atau makhluk yang lebih tinggi.

- c. Sosiokultural

Kenyamanan ini berkaitan dengan latar belakang eksternal pengalaman manusia seperti suhu, cahaya, suara, bau, warna, perabotan, lanskap, dan sebagainya.

- d. Lingkungan

Kenyamanan ini berkaitan dengan hubungan interpersonal, keluarga, dan kemasyarakatan seperti keuangan, pengajaran, tenaga perawatan kesehatan, dan sebagainya. Selain itu kenyamanan ini juga berkaitan dengan tradisi keluarga, ritual, dan praktik keagamaan.

Ada beberapa asumsi penting Kolcaba dalam teorinya, yaitu: (Alligood, 2014a)

- a. Manusia memiliki respons holistik terhadap stimulus yang kompleks
- b. Kenyamanan merupakan hasil holistik yang berkaitan erat dengan ilmu keperawatan
- c. Kenyamanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi atau telah dipenuhi oleh orang-orang. Kenyamanan merupakan upaya aktif
- d. Kenyamanan yang ditingkatkan memperkuat klien untuk terlibat dalam perilaku pencarian kesehatan sesuai pilihan mereka
- e. Klien yang diberdayakan untuk terlibat secara aktif dalam perilaku pencarian kesehatan merasa puas dengan perawatan kesehatan yang mereka terima
- f. Integritas institusional didasarkan pada sistem nilai yang berorientasi pada penerima perawatan yang sama pentingnya adalah orientasi pada pendekatan holistik dan promosi kesehatan

Konsep metaparadigma dari perspektif teori Leininger adalah sebagai berikut: (Alligood, 2014a)

a. Keperawatan

Kolcaba menyatakan bahwa perawatan merupakan penilaian yang disengaja terhadap kebutuhan kenyamanan, perancangan intervensi kenyamanan untuk mengatasi kebutuhan tersebut, dan penilaian ulang tingkat kenyamanan setelah penerapan dibandingkan dengan kondisi awal. Penilaian dan penilaian ulang dapat bersifat intuitif atau subjektif atau keduanya.

b. Klien

Klien merupakan penerima perawatan yang dapat berupa individu, keluarga, lembaga, atau masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan.

c. Kesehatan

Kesehatan adalah fungsi optimal dari klien, keluarga, penyedia layanan kesehatan, atau masyarakat sebagaimana didefinisikan oleh klien atau kelompok.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah aspek apa pun dari klien, keluarga, atau lingkungan institusi yang dapat dimanipulasi oleh perawat, orang terkasih, atau institusi untuk meningkatkan kenyamanan.

13. Kristen M. Swanson: Theory of Caring

Theory of Caring oleh Swanson dikembangkan pada tahun 1991 yang dimentori langsung oleh Jean Watson. Teori ini merupakan salah satu dari beberapa kategori *Middle Range Theory*. Ada beberapa teori tentang *Caring* yang dikembangkan sebelumnya, seperti teori Jean Watson dan teori Katie Eriksson. Dalam teorinya, Swanson menyatakan bahwa *Caring* merupakan cara mengasuh dengan membangun bersama berhubungan yang berharga dengan seseorang, sehingga seseorang merasa memiliki komitmen dan tanggung jawab pribadi. Swanson mendefinisikan kebersamaan sebagai kehadiran secara emosional dengan orang lain, berusaha memahami suatu peristiwa sebagaimana peristiwa itu memiliki makna dalam kehidupan orang lain. Ia menyatakan bahwa kebersamaan lebih dari sekadar mengetahui maupun memahami kesulitan orang lain. Akan tetapi hal ini menjadi terbuka secara emosional terhadap realitas orang lain. Pesan yang disampaikan melalui kebersamaan adalah bahwa pengalaman orang lain penting bagi orang yang peduli (Swanson, 1991).

Theory of Caring Swanson menguraikan lima proses kepedulian yaitu, *Knowing, Being With, Doing For, Enabling, dan Maintaining Belief* (Swanson, 1993).

a. *Maintaining Belief* (Mempertahankan Kepercayaan)

Mempertahankan keyakinan berarti mempertahankan iman pada kapasitas orang lain untuk melewati suatu peristiwa atau transisi dan menghadapi masa depan dengan penuh makna, percaya pada kapasitas orang lain dan menghargai mereka, mempertahankan sikap penuh harapan, menawarkan optimisme yang realistis, membantu menemukan makna, dan mendukung orang yang dirawat dalam situasi apapun.

b. *Knowing* (Tahu)

Mengetahui adalah berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dalam kehidupan orang lain, menghindari asumsi, berfokus pada orang yang dirawat, mencari isyarat, menilai dengan cermat, dan melibatkan baik orang yang merawat maupun yang dirawat dalam proses mengetahui.

c. *Being With* (Hadir Bersama)

Bersama berarti hadir secara emosional kepada orang lain. Ini termasuk berada bersama orang lain secara langsung, menunjukkan ketersediaan, dan berbagi perasaan tanpa membebani orang yang dirawat.

d. *Doing For* (Melakukan Sesuatu)

Melakukan sesuatu berarti melakukan sesuatu untuk orang lain seperti membantu mengidentifikasi apa yang akan dilakukan seseorang secara mandiri jika memungkinkan, termasuk mengantisipasi kebutuhan, memberi hiburan, bertindak secara terampil dan kompeten, serta melindungi orang yang dirawat sambil menjaga martabatnya.

e. *Enabling* (Memungkinkan)

Memungkinkan adalah memfasilitasi perjalanan orang lain melalui transisi kehidupan dan kejadian yang tidak dikenal dengan memfokuskan pada kejadian tersebut, menginformasikan, menjelaskan, mendukung, memvalidasi perasaan, menghasilkan alternatif, memikirkan berbagai hal, dan memberikan umpan balik.

Konsep metaparadigma dari perspektif teori Swanson adalah sebagai berikut: (Swanson, 1993)

a. Keperawatan

Swanson mendefinisikan keperawatan sebagai perawatan yang terinformasi untuk kesejahteraan orang lain. Ia menegaskan bahwa disiplin keperawatan diinformasikan oleh pengetahuan empiris dari keperawatan dan disiplin terkait lainnya, serta pengetahuan etika, pribadi, dan estetika yang berasal dari humaniora, pengalaman klinis, dan nilai serta harapan pribadi dan masyarakat.

b. Orang

Swanson mendefinisikan orang sebagai makhluk unik. Pengalaman hidup setiap orang dapat dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks, mulai dari

warisan genetik, anugerah spiritual dan kapasitas untuk menjalankan kehendak bebas. Oleh karena itu, orang membentuk dan dibentuk oleh lingkungan tempat mereka tinggal. Swanson memandang orang sebagai makhluk yang dinamis, tumbuh, merefleksikan diri, rindu untuk terhubung dengan orang lain, dan memiliki aspek spiritual.

c. Kesehatan

Menurut Swanson kesehatan dan kesejahteraan adalah menjalani pengalaman subjektif yang penuh makna dari keutuhan yang melibatkan rasa integrasi dan menjadi di mana semua aspek keberadaan bebas untuk diekspresikan. Aspek-aspek keberadaan mencakup spiritualitas, pikiran, perasaan, kecerdasan, kreativitas, keterkaitan, feminitas, maskulinitas, dan seksualitas kita. Dengan demikian, Swanson melihat membangun kembali kesejahteraan sebagai proses penyembuhan yang kompleks yang mencakup melepaskan rasa sakit batin, membangun makna baru, memulihkan integrasi, dan muncul rasa keutuhan yang ditingkatkan.

d. Lingkungan

Swanson mendefinisikan lingkungan berdasarkan situasi. Ia berpendapat bahwa lingkungan adalah setiap konteks yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh klien. Swanson menyatakan bahwa terdapat banyak jenis pengaruh terhadap lingkungan, seperti budaya, sosial, biofisik, politik, dan ekonomi.

C. Pedoman Memilih Teori dalam Praktik Keperawatan

Alligood (2014b) telah mengembangkan pedoman bagaimana memilih kerangka kerja untuk praktik keperawatan yang terdiri dari 9 langkah. Ini menjadi salah satu acuan perawat dalam memilih teori untuk diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien.

1. Pertimbangkan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang secara pribadi tentang keperawatan.
2. Kembangkan pernyataan filosofi tentang orang, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan.
3. Survei makna orang, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan dalam kerangka kerja keperawatan.
4. Identifikasi dua atau tiga kerangka kerja yang paling sesuai dengan nilai dan definisi yang diyakini.
5. Tinjau asumsi kerangka kerja yang telah dipilih.
6. Terapkan kerangka kerja dalam praktik keperawatan (cobalah dalam situasi praktik yang sebenarnya).

7. Bandingkan kerangka kerja dengan memperhatikan fokus klien, tindakan keperawatan, dan hasil klien.
8. Tinjau literatur keperawatan yang ditulis oleh orang-orang yang menggunakan kerangka kerja dalam praktik mereka.
9. Pilih kerangka kerja dan mulailah mengembangkan penggunaannya dalam praktik keperawatan.

D. Latihan Soal

1. Berdasarkan tingkat abstraksinya, manakah teori keperawatan yang paling abstrak dari keempat tingkatan tersebut?
A. *Meta Grand Middle Theory*
B. *Grand Theory*
C. *Meta Theory*
D. *Middle Range Theory*
E. *Practice Theory*
2. Manakah tingkatan teori keperawatan dibawah ini yang paling mudah untuk diaplikasikan?
A. *Meta Grand Middle Theory*
B. *Grand Theory*
C. *Meta Theory*
D. *Middle Range Theory*
E. *Practice Theory*
3. Manakah teori keperawatan paling pertama dikembangkan yang melahirkan teori-teori keperawatan berikutnya?
A. Theory of Human Caring
B. Environmental Theory
C. Behavioral System Model
D. System Model Theory
E. Theory of Comfort
4. Manakah teori dibawah ini yang masuk dalam kategori *Meta Theory*?
A. *Theory of Human Caring*
B. *Environmental Theory*
C. *Behavioral System Model*
D. *System Model Theory*

- E. *Theory of Comfort*
5. Manakah dibawah ini yang masuk kategori *Practice Theory*?
- A. *Theory of Human Caring*
 - B. *Environmental Theory*
 - C. *Behavioral System Model*
 - D. *System Model Theory*
 - E. *Theory of Comfort*
6. Manakah metaparadigma yang paling benar dalam teori keperawatan?
- A. Orang, keperawatan, kesehatan, dan keluarga
 - B. Orang, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan
 - C. Orang, klien, keluarga, dan kesehatan
 - D. Klien, keluarga, lingkungan, dan kesehatan
 - E. Orang, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan
7. Katharine Kolcaba dalam teorinya menyebutkan bahwa terdapat tiga tipe kenyamanan yaitu *Relief*, *Ease*, dan *Transcendence*. Manakah makna yang paling tepat dari *Ease*?
- A. Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tertentu
 - B. Dapat bangkit dari masalah atau rasa sakit
 - C. Keadaan tenang atau puas
 - D. Keadaan senang tetapi sedang bersedih
 - E. Keadaan berduka
8. Katharine Kolcaba dalam teorinya menyebutkan bahwa terdapat tiga tipe kenyamanan yaitu *Relief*, *Ease*, dan *Transcendence*. Manakah makna yang paling tepat dari *Transcendence*?
- A. Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tertentu
 - B. Dapat bangkit dari masalah atau rasa sakit
 - C. Keadaan tenang atau puas
 - D. Keadaan senang tetapi sedang bersedih
 - E. Keadaan berduka
9. Katharine Kolcaba dalam teorinya menyebutkan bahwa terdapat tiga tipe kenyamanan yaitu *Relief*, *Ease*, dan *Transcendence*. Manakah makna yang paling tepat dari *Relief*?
- A. Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tertentu
 - B. Dapat bangkit dari masalah atau rasa sakit

- C. Keadaan tenang atau puas
 - D. Keadaan senang tetapi sedang bersedih
 - E. Keadaan berduka
10. Manakah teori dibawah ini yang menyatakan bahwa "Manusia dikonseptualisasikan sebagai medan energi yang dinamis dan terus berkembang, bukan sebagai makhluk homeostatis. Manusia dan lingkungan terus-menerus bertukar energi, dan tidak terdapat batasan atau hambatan yang menghambat aliran energi tersebut. Manusia secara terbuka berpartisipasi dalam transformasi energi dengan lingkungan yang menciptakan perubahan bersama".
- A. *Self-Care Deficit* oleh Orem
 - B. *Theory of Human Caring* oleh Watson
 - C. *Unitary Human Being* oleh Rogers
 - D. *From Novice to Expert* oleh Benner
 - E. *Theory of Caritative Caring* oleh Eriksson

Latihan Kasus

Berikut adalah sebuah skenario latihan kasus untuk memahami pengaplikasian teori keperawatan.

Kasus

Seorang perawat laki-laki usia 40 tahun bekerja di ruang Penyakit Dalam sebagai kepala ruang. Selama bekerja Ia melihat kurangnya rasa peduli perawat terhadap klien maupun keluarga. Setelah melakukan tindakan dan dokumentasi, Ia melihat perawat hanya sibuk bercerita dengan teman *Shift*. Beberapa keluarga klien menyampaikan keluhan bahwa perawat di Ruangannya bekerja cuek dan kurang rasa peduli. Ia memiliki keinginan untuk melakukan perubahan dengan mengaplikasikan salah satu teori keperawatan untuk meningkatkan kepedulian perawat terhadap klien maupun keluarga.

Tugas Mahasiswa

Berdasarkan kasus di atas

1. Pilihlah salah satu teori yang sesuai
2. Buat alasan mengapa memilih teori tersebut
3. Pilih kasus spesifik klien
4. Buat kerangka kerja berdasarkan pedoman Alligood (2014b) secara terperinci

Kunci Jawaban Soal Latihan

1. Kunci Jawaban: c. *Meta Theory*

Pembahasan: *Meta theory* merujuk pada area studi komponen filosofis, teoritis, dan empiris serta hubungan mereka dalam struktur pengetahuan, sehingga tingkat abstraksinya sangatlah tinggi dan sulit dipahami.

2. Kunci Jawaban: e. *Practice Theory*

Pembahasan: Teori ini lebih spesifik sehingga menghasilkan arahan khusus untuk praktik. Teori ini mengandung konsep paling sedikit dan merujuk pada fenomena spesifik yang mudah didefinisikan dan diaplikasikan.

3. Kunci Jawaban: b. *Environmental Theory*

Pembahasan: *Environmental Theory* merupakan teori yang dikembangkan oleh Florence Nightingale yang merupakan teori pertama ilmu Keperawatan di dunia.

4. Kunci Jawaban: b. *Environmental Theory*

Pembahasan: *Environmental Theory* merupakan teori pertama ilmu Keperawatan di dunia oleh Florence Nightingale. Teori ini berisi bahasa yang sangat filosofis, teoritis, serta empiris sehingga tingkat abstraksinya sangatlah tinggi.

5. Kunci Jawaban: e. *Theory of Comfort*

Pembahasan: *Theory of Comfort* dikembangkan oleh Kolcaba yang berisi tentang bagaimana perawat memberikan kenyamanan kepada klien maupun keluarga. Dalam teori ini dijelaskan secara praktis dan spesifik konsep-konsep didalamnya seperti kategori kenyamanan yang didefinisikan secara praktis, sehingga teori ini mudah untuk diaplikasikan.

6. Kunci Jawaban: e. Orang, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan

Pembahasan: dalam ilmu keperawatan terdapat empat metaparadigma yang menjadi dasar dalam teori keperawatan pada awalnya dikembangkan oleh Florence Nightingale. Ini menjadi Body of Knowledge (Tubuh Pengetahuan) dalam praktik keperawatan.

7. Kunci Jawaban: c. Keadaan tenang dan puas

Pembahasan: dalam bahasa Indonesia *Ease* berarti kemudahan. Dalam teori yang dikembangkan oleh Kolcaba, *Ease* diartikan sebagai ketentraman, perasaan tenang atau puas. Oleh karena itu jawaban paling tepat adalah c.

8. Kunci Jawaban: b. Dapat bangkit dari masalah atau rasa sakit

Pembahasan: *Transcendence* dalam teori Kolcaba diartikan sebagai kemampuan seseorang mengatasi masalah dan rasa ketidaknyamanan. Oleh karena itu jawaban paling tepat adalah b.

9. Kunci Jawaban: a. Terpenuhinya kebutuhan dan kenyamanan tertentu

Pembahasan: *Relief* dalam bahasa Indonesia berarti perasaan lega. Dalam teori Kolcaba, *Relief* dimaknai sebagai rasa lega seseorang karena terpenuhinya kebutuhan dan kenyamanan. Oleh karena itu jawaban paling tepat adalah a.

10. Kunci Jawaban: c. *Unitary Human Being* oleh Rogers

Pembahasan: Dalam teorinya Rogers berasumsi bahwa manusia sebagai medan energi yang dinamis dan terus berkembang. Manusia dan lingkungan terus-menerus bertukar energi, dan tidak terdapat batasan atau hambatan yang menghambat aliran energi tersebut. Oleh karena itu jawaban paling tepat adalah e.

E. Rangkuman Soal

1. Teori keperawatan didefinisikan sebagai penataan ide yang kreatif dan cermat yang memproyeksikan pandangan tentatif, terarah, dan sistematis terhadap suatu fenomena. Melalui penyelidikan sistematis, baik dalam penelitian maupun praktik keperawatan, perawat mampu mengembangkan pengetahuan yang relevan untuk meningkatkan perawatan klien
2. Teori keperawatan dikembangkan pertama kali oleh Florence Nightingale dengan teorinya tentang *Environmental Theory* yang melahirkan berbagai teori keperawatan setelahnya.
3. Terdapat empat tingkatan dalam teori keperawatan berdasarkan tingkat abstraksinya, yaitu: *Meta Theory* (sangat abstrak), *Grand Theory* (masih sangat abstrak, tetapi tidak lebih abstrak dari *Meta Theory*), *Middle Range Theory* (cukup abstrak, tetapi tidak lebih abstrak dari *Grand Theory* maupun *Meta Theory*), dan *Practice Theory* (lebih spesifik dan praktis, sehingga mudah diaplikasikan).
4. Ada banyak teori keperawatan, sehingga seorang perawat praktisi maupun peneliti dapat memilih teori yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi. Dalam memilih dan mengaplikasikan sebuah teori keperawatan harus menggunakan pedoman yang sesuai, agar pengaplikasian teori dapat dilakukan dengan baik dan optimal.

F. Glosarium

Environmental: lingkungan

Meta Theory: Teori yang mendefinisikan dan membangun konsep teoritis dan menggunakan bahasa filosofis

Grand Theory: teori besar yang menjelaskan fenomena secara keseluruhan

Middle Range Theory: teori yang berisi konsep dan preposisi yang cukup spesifik dan cukup mudah diterapkan

Practice Theory: teori praktik yang berisi konsep yang secara spesifik dan terkhusus sehingga sangat mudah diterapkan

Critical Thinking: kemampuan seseorang dalam berpikir kritis terhadap sesuatu tertentu

Personhood: kemanusiaan yang menunjukkan kesatuan secara holistik

Transpersonal Caring-Healing: adalah konsep kepedulian yang berfokus pada perasaan orang lain

Caring: rasa peduli kepada seseorang

Caritative: proses merawat seseorang dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang

Carative: Faktor yang mewujudkan perilaku peduli

Caritas: rasa cinta dan kasih sayang tanpa syarat

Healing Space: lingkungan yang menjadi ruang penyembuhan seseorang

G. Daftar Pustaka

Alligood, M. R. (2014a). *Nursing Theorists and Their Work*. In *Contemporary Nurse* (8th ed.). United States: Elsevier Inc.

Alligood, M. R. (2014b). *Nursing Theory: Utilization & Application*. In *Accident and Emergency Nursing* (5th ed.). United States: Elsevier Inc.

Bergbom, I., Nåden, D., & Nyström, L. (2022). Katie Eriksson's caring theories. Part 1. The caritative caring theory, the multidimensional health theory and the theory of human suffering. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 36(3), 782–790. <https://doi.org/10.1111/scs.13036>

Chinn, P. L., & Kramer, M. K. (2010). *Integrated Theory & Knowledge Development in Nursing* (8th ed.). Elsevier.

Comley, A. L. (1994). A comparative analysis of Orem's self-care model and Peplau's interpersonal theory. *Journal of Advanced Nursing*, 20(4), 755–760. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1994.20040755.x>

Eriksson, K. (1989). Caring paradigms. A study of the origins and the development of caring paradigms among nursing students. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 3(4), 169–176. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.1989.tb00288.x>

Hannood, S., & Dhamoon, A. S. (2023). *Nursing Neuman Systems Model*. In StatPearls. StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560658/>

- Higgins, P. A., & Moore, S. M. (2000). Levels of theoretical thinking in nursing. *Nursing Outlook*, 48(4), 179–183. <https://doi.org/10.1067/mno.2000.105248>
- Jukes, M., & Spencer, P. (2007). Model for Practice Neuman's System Model. In *Person- Centred Practices A holistic and integrated approach* (pp. 32–50). London: Quay Books. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/256686465_Neuman's_Systems_Model
- Kolcaba, K. Y., & Fisher, E. M. (1996). A holistic perspective on comfort care as an advance directive. *Critical Care Nursing Quarterly*, 18(4), 66–76. <https://doi.org/10.1097/00002727-199602000-00009>
- Masters, K. (2014). *Nursing Theories: A Framework for Professional Practice* (2nd ed.). Wall Street: Jones & Bartlett Publishers.
- McEwen, M., & Wills, E. M. (2014). *Theoretical Basis for Nursing* (4th ed.). China: Wolters Kluwer Health.
- McFarland, M. R., & Alamah, H. B. W. (2018). *Leininger's Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research & Practice* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- McFarland, M. R., & Alamah, H. B. W. (2019). Leininger's Theory of Culture Care Diversity and Universality: An Overview With a Historical Retrospective and a View Toward the Future. *Journal of Transcultural Nursing: Official Journal of the Transcultural Nursing Society*, 30(6), 540–557. <https://doi.org/10.1177/1043659619867134>
- Reed, P. G. (2017). *The Spiral Path of Nursing Knowledge* (2nd ed.; P. G. S. Reed Nelma B. Crawford, ed.). New York: Springer Publishing. <https://doi.org/10.1891/9780826149923.0001>
- Rojas, F. R., Contrera, M. V., Velásquez, J. V., Grandon, K. R., & Palacios, Y. G. (2023). Critical analysis of Imogene King's theory of goal attainment. *Revista de Enfermagem Referencia*, 6(2), 1–5. <https://doi.org/10.12707/RVI23.17.29335>
- Roy, S. C. (1988). An Explication of the Philosophical Assumptions of the Roy Adaptation Model. *Nursing Science Quarterly*, 1(1), 26–34. <https://doi.org/10.1177/089431848800100108>

- Smith, M. C., & Parker, M. E. (2015). *Nursing Theories & Nursing Practice* (4th ed.). Philadelphia: F. A. Davis Company.
- Swanson, K. M. (1991). Empirical Development Of a Middle Range Theory of Caring. *Nursing Research*, 40(3). <https://doi.org/10.1097/00006199-199105000-00008>
- Swanson, K. M. (1993). Nursing as informed caring for the well-being of others. *Image--the Journal of Nursing Scholarship*, 25(4), 352–357. <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1993.tb00271.x>
- Walker, L. O., & Avant, K. C. (2014). *Strategies For Theory Construction In Nursing* (5th ed.). Edinburgh: Pearson Education Limited.

BAB 2

FALSAFAH DAN PARADIGMA KEPERAWATAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami dan mengintegrasikan falsafah serta paradigma keperawatan sebagai dasar dalam memberikan pelayanan keperawatan yang holistik dan berpusat pada pasien dalam berbagai konteks klinis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar falsafah dan paradigma keperawatan serta mengaplikasikan konsep tersebut dalam praktik keperawatan secara komprehensif dan berlandaskan etika profesional.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan definisi dan ruang lingkup falsafah keperawatan.
- Menguraikan prinsip-prinsip utama falsafah keperawatan.
- Mendeskripsikan paradigma keperawatan serta komponen-komponennya.
- Menghubungkan falsafah dan paradigma keperawatan dalam praktik klinis.
- Mengidentifikasi peran falsafah dan paradigma keperawatan dalam pengambilan keputusan klinis.

Pendahuluan

Falsafah dan paradigma keperawatan adalah landasan fundamental yang menjadi pedoman dalam praktik keperawatan. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua konsep ini membantu perawat dalam memberikan asuhan yang holistik dan bermakna bagi pasien. Falsafah keperawatan mencerminkan nilai-nilai inti dan keyakinan yang dianut oleh perawat mengenai manusia, kesehatan, lingkungan, dan profesi keperawatan itu sendiri. Paradigma keperawatan, di sisi lain, berisi kerangka berpikir yang menentukan pendekatan praktis dalam melaksanakan tindakan keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien secara komprehensif. Buku ajar ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai falsafah dan paradigma keperawatan agar mahasiswa keperawatan mampu memahami dan menerapkan dalam praktik klinis.

A. Definisi dan Ruang Lingkup Falsafah Keperawatan

Falsafah keperawatan merupakan suatu sistem nilai dan keyakinan yang secara mendasar menjadi pedoman dalam praktik profesional keperawatan. Sistem nilai ini membentuk suatu kerangka berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seorang perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, dan komunitas. Sebagai sebuah falsafah, keperawatan tidak hanya bersifat teknis dan prosedural, melainkan mencakup dimensi yang jauh lebih luas, seperti pemahaman tentang hakikat manusia, kesehatan, lingkungan, serta hubungan antar unsur tersebut dalam konteks pelayanan kesehatan.

Falsafah keperawatan didasarkan pada pandangan tentang manusia sebagai makhluk yang kompleks dan utuh, dikenal dengan istilah biopsikososial dan spiritual. Konsep ini menegaskan bahwa manusia bukan hanya terdiri atas aspek fisik atau biologis semata, tetapi juga memiliki dimensi psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dalam menjalankan perannya, perawat perlu memahami bahwa setiap pasien yang dirawat bukan hanya hadir dengan masalah fisik semata, tetapi juga memiliki perasaan, pikiran, kepercayaan, nilai, hubungan sosial, serta spiritualitas yang penting untuk diperhatikan dalam proses perawatan. Misalnya, seseorang yang sakit secara fisik dapat mengalami gangguan emosional seperti kecemasan atau depresi, yang pada akhirnya mempengaruhi proses penyembuhannya. Dengan demikian, pemahaman falsafah ini mendorong perawat untuk tidak sekedar merawat penyakit, tetapi juga merawat manusia secara keseluruhan dengan segala dimensi yang melekat padanya.

Selanjutnya, falsafah keperawatan juga mencakup pandangan tentang kesehatan sebagai suatu proses yang dinamis dan terus menerus berubah sepanjang kehidupan manusia. Kesehatan bukan lagi dipandang sebagai sebuah kondisi tetap atau statis, tetapi merupakan suatu spektrum yang terus bergerak dan berkembang sesuai dengan kondisi biopsikososial dan spiritual seseorang. Dalam perspektif ini, kesehatan dianggap sebagai keseimbangan dinamis yang secara terus-menerus dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dengan memahami bahwa kesehatan adalah dinamis, maka tugas perawat bukan hanya menangani pasien ketika sakit, tetapi juga membantu individu mempertahankan kondisi sehat, mencegah penyakit, serta mendampingi dalam masa pemulihan hingga mencapai kondisi kesehatan yang optimal.

Aspek lingkungan dalam falsafah keperawatan juga mendapat perhatian khusus sebagai faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan pasien. Lingkungan di sini mencakup segala sesuatu yang berada di luar individu, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dapat mempengaruhi kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, lingkungan fisik seperti kebersihan,

udara, air, makanan, serta kondisi fasilitas kesehatan yang memadai berperan penting dalam mempercepat proses penyembuhan. Selain itu, lingkungan sosial yang mencakup dukungan keluarga, hubungan sosial yang sehat, serta lingkungan psikologis yang positif sangat menentukan proses pemulihan pasien. Dengan demikian, seorang perawat harus memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasien, baik secara fisik maupun psikososial, untuk mendukung proses penyembuhan.

Lebih jauh, ruang lingkup falsafah keperawatan meliputi pemahaman terhadap nilai-nilai etika dalam praktik keperawatan. Nilai etika menjadi landasan moral yang mendasari setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh seorang perawat. Nilai-nilai tersebut mencakup penghormatan terhadap martabat pasien, menjaga kerahasiaan informasi pasien, bertindak secara adil, serta memberikan pelayanan secara optimal dan aman kepada pasien tanpa diskriminasi. Pemahaman terhadap nilai etika ini penting untuk membentuk perawat yang profesional, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh pasien maupun keluarga.

Selain nilai etika, falsafah keperawatan juga mengedepankan pentingnya empati dalam proses perawatan. Empati merupakan kemampuan seorang perawat untuk merasakan dan memahami secara mendalam perasaan serta kondisi yang dialami pasien. Dengan empati, seorang perawat dapat lebih memahami kebutuhan pasien, baik kebutuhan fisik maupun psikologis, serta dapat meresponsnya secara tepat. Empati juga memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan pasien, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pasien dan kualitas perawatan.

Selanjutnya, komunikasi efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari falsafah keperawatan. Komunikasi yang baik sangat penting dalam menciptakan hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien, keluarga, maupun tim kesehatan lainnya. Melalui komunikasi yang efektif, perawat dapat menyampaikan informasi yang jelas, memberikan edukasi kesehatan, mengurangi kecemasan pasien, serta memastikan kolaborasi yang baik dalam proses perawatan. Komunikasi efektif ini juga menjadi kunci dalam mengidentifikasi masalah pasien secara akurat, sehingga perencanaan dan implementasi intervensi keperawatan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan pasien.

Terakhir, falsafah keperawatan menegaskan pentingnya integritas profesional, yaitu konsistensi antara nilai, sikap, tindakan, dan komitmen seorang perawat dalam menjalankan tugasnya. Integritas profesional ditunjukkan melalui sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta dedikasi tinggi dalam menjalankan praktik keperawatan. Integritas ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan pasien dan masyarakat terhadap profesi keperawatan.

Dengan demikian, falsafah keperawatan bukan hanya sekedar teori atau konsep abstrak semata, tetapi merupakan inti sari dari nilai-nilai profesional yang menjadi pedoman bagi perawat dalam memberikan pelayanan yang holistik,

manusiawi, dan berkualitas tinggi kepada pasien. Melalui pemahaman yang mendalam tentang falsafah ini, diharapkan setiap perawat dapat menjalankan perannya secara optimal, demi mencapai hasil perawatan yang terbaik bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

B. Prinsip-prinsip Utama Falsafah Keperawatan

Dalam falsafah keperawatan, terdapat sejumlah prinsip utama yang menjadi fondasi sekaligus pedoman moral dan etis dalam menjalankan praktik profesional. Prinsip-prinsip ini memberikan arah yang jelas tentang bagaimana perawat harus bersikap dan bertindak dalam setiap situasi klinis maupun non-klinis untuk menjamin bahwa asuhan keperawatan yang diberikan senantiasa berkualitas tinggi, manusiawi, serta berorientasi pada kebutuhan pasien secara utuh.

Prinsip pertama yang mendasari falsafah keperawatan adalah penghormatan terhadap martabat pasien. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pasien, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, atau latar belakang budaya, harus diperlakukan secara hormat dan manusiawi. Perawat wajib menghormati setiap keputusan yang diambil oleh pasien, terutama yang menyangkut proses perawatan dirinya sendiri, sepanjang keputusan tersebut berdasarkan informasi yang lengkap dan jelas. Misalnya, pasien memiliki hak untuk mengetahui informasi lengkap tentang kondisinya, tindakan medis yang akan dilakukan, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang diambilnya. Dengan demikian, seorang perawat harus mampu menghargai hak otonomi pasien dan memandang pasien sebagai individu yang memiliki nilai intrinsik, bukan sekedar objek perawatan semata.

Prinsip kedua adalah advokasi pasien, yang berarti bahwa perawat harus mampu bertindak sebagai pembela atau pendukung hak-hak pasien, terutama dalam situasi di mana pasien tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk menyuarakan kebutuhannya sendiri. Sebagai advokat, perawat bertugas memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat, aman, dan adil. Misalnya, seorang pasien lansia atau pasien yang mengalami gangguan kognitif mungkin tidak dapat menyampaikan keinginannya secara jelas kepada tenaga medis atau keluarganya. Dalam kondisi ini, perawat berperan penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh tim medis atau keluarga benar-benar mencerminkan kebutuhan, preferensi, serta kepentingan terbaik pasien. Advokasi juga mencakup memastikan bahwa pasien mendapatkan perlindungan terhadap risiko tindakan medis yang merugikan atau kesalahan dalam perawatan yang dapat mengancam keselamatan pasien.

Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah asuhan keperawatan holistik, yang menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan integratif dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, asuhan holistik berarti bahwa perawat harus mampu mengenali dan merespons kebutuhan pasien dari berbagai

dimensi kehidupan yang dimilikinya, yaitu fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Perawat tidak hanya berfokus pada pengobatan gejala atau kondisi medis tertentu saja, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang turut mempengaruhi kesehatan pasien. Sebagai contoh, seorang pasien yang menjalani operasi tidak hanya membutuhkan perawatan luka pasca operasi, tetapi juga dukungan emosional, edukasi kesehatan, dukungan spiritual, serta bantuan dalam memenuhi kebutuhan sosial seperti hubungan interpersonal dan dukungan keluarga. Dengan pendekatan holistik, perawat dapat memastikan bahwa kebutuhan pasien dipenuhi secara komprehensif, sehingga pasien merasa lebih dihargai, nyaman, serta termotivasi dalam menjalani proses pemulihan.

Prinsip keempat adalah tanggung jawab profesional, yang mengacu pada kewajiban perawat untuk bertindak sesuai dengan standar praktik keperawatan yang telah ditetapkan serta menunjukkan integritas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan keperawatan yang dilakukannya. Tanggung jawab profesional ini meliputi kewajiban moral dan hukum seorang perawat untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik yang aman, efektif, dan berdasarkan bukti ilmiah (evidence-based practice). Seorang perawat yang bertanggung jawab harus memiliki kesadaran akan batasan kompetensinya, selalu berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui pendidikan berkelanjutan, serta terbuka terhadap kritik atau saran konstruktif demi meningkatkan kualitas pelayanannya. Selain itu, tanggung jawab profesional juga mencakup kewajiban untuk melaporkan dan memperbaiki kesalahan dalam praktik, menjaga kerahasiaan informasi pasien, serta melaksanakan dokumentasi perawatan secara tepat dan lengkap. Dengan demikian, tanggung jawab profesional menjamin bahwa setiap tindakan keperawatan dilaksanakan dengan standar tinggi yang pada akhirnya meningkatkan keselamatan, kualitas, dan hasil perawatan pasien secara keseluruhan.

C. Paradigma Keperawatan dan Komponennya

Paradigma keperawatan merupakan sebuah kerangka konsep atau pola pikir yang menjadi dasar bagi seorang perawat dalam memahami, menganalisis, dan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Paradigma ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seorang perawat memahami berbagai aspek yang terkait erat dengan proses keperawatan, serta bagaimana ia harus bersikap dan bertindak dalam memberikan pelayanan kesehatan. Paradigma keperawatan secara luas diakui terdiri dari empat komponen atau konsep utama, yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan itu sendiri. Keempat komponen tersebut saling berinteraksi secara dinamis dan berkelanjutan, membentuk landasan yang kuat dalam praktik keperawatan.

Komponen pertama dalam paradigma keperawatan adalah manusia, yang dipandang sebagai penerima utama dari asuhan keperawatan. Dalam paradigma ini,

manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang sakit atau pasien semata, tetapi secara lebih luas mencakup individu, keluarga, kelompok, bahkan komunitas. Perspektif ini menegaskan bahwa manusia memiliki kompleksitas yang tinggi, meliputi aspek biopsikososial dan spiritual. Manusia sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual memiliki kebutuhan fisik seperti makanan, air, udara, serta istirahat; kebutuhan psikologis seperti rasa aman, dihargai, dicintai, serta kebutuhan aktualisasi diri; kebutuhan sosial dalam bentuk interaksi, dukungan sosial, dan rasa keterikatan dengan orang lain; serta kebutuhan spiritual dalam bentuk keyakinan, makna hidup, dan hubungan dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, perawat harus mampu memahami manusia secara holistik, bukan hanya sekedar menangani masalah fisik atau penyakit, melainkan juga memperhatikan aspek emosional, sosial, dan spiritual yang turut mempengaruhi kondisi kesehatan pasien.

Komponen kedua dari paradigma keperawatan adalah lingkungan, yang terdiri dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kesehatan manusia. Lingkungan internal meliputi aspek-aspek yang berasal dari dalam diri individu, seperti status emosional, genetik, pola pikir, motivasi, atau kondisi fisiologisnya. Lingkungan eksternal meliputi kondisi fisik seperti kualitas udara, kebersihan, suhu, cahaya, kebisingan, serta lingkungan sosial seperti dukungan keluarga, hubungan interpersonal, komunitas, budaya, ekonomi, dan politik. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kesehatan dan proses pemulihan pasien. Sebagai contoh, lingkungan fisik yang bersih dan nyaman akan mempercepat proses penyembuhan pasien, sedangkan lingkungan sosial yang suportif akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan emosional dan spiritual pasien. Dalam hal ini, perawat harus memiliki kemampuan untuk mengelola lingkungan pasien agar tercipta suasana yang kondusif untuk proses penyembuhan dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Komponen ketiga adalah kesehatan, yang dalam paradigma keperawatan dipandang sebagai sebuah kontinum atau rentang yang bergerak secara dinamis antara kondisi sehat hingga sakit. Artinya, kesehatan bukan merupakan suatu kondisi yang statis atau tetap, tetapi selalu berubah-ubah tergantung pada interaksi antara manusia dengan lingkungannya serta berbagai faktor lainnya. Kesehatan mencerminkan kemampuan individu dalam menjalankan fungsi sehari-hari secara optimal, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Paradigma ini menegaskan bahwa tujuan utama asuhan keperawatan bukan hanya mengobati atau mengatasi kondisi sakit saja, tetapi juga memelihara kesehatan, mencegah timbulnya penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Perawat harus mampu mengidentifikasi posisi pasien pada kontinum kesehatan ini, sehingga intervensi keperawatan yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai dengan

kebutuhan pasien, baik untuk pemeliharaan kesehatan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, hingga pemulihan dari penyakit.

Komponen keempat dan terakhir dari paradigma keperawatan adalah keperawatan itu sendiri, yang mencakup berbagai tindakan atau intervensi yang dilakukan perawat untuk membantu pasien dalam mencapai kondisi sehat yang optimal. Intervensi keperawatan mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atau komunitas. Peran perawat tidak terbatas pada pemberian tindakan medis atau intervensi teknis semata, melainkan juga meliputi edukasi kesehatan, konseling, advokasi, pendampingan emosional, serta kolaborasi interprofesional dengan tenaga kesehatan lainnya. Keperawatan berorientasi pada peningkatan kemampuan pasien untuk merawat dirinya sendiri (self-care), pemberdayaan pasien agar dapat beradaptasi terhadap kondisi kesehatannya, serta membantu pasien mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimal sesuai dengan kondisi dan potensinya. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, perawat menggunakan pendekatan berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice) agar tindakan yang diberikan benar-benar efektif dan aman bagi pasien.

Interaksi dinamis antara empat komponen tersebut—manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan—menjadi inti utama dalam paradigma keperawatan. Sebagai contoh, ketika seorang pasien mengalami sakit kronis, maka aspek lingkungan yang meliputi dukungan keluarga dan komunitas akan berpengaruh terhadap kemampuan pasien beradaptasi terhadap kondisi sakitnya. Begitu pula, kondisi kesehatan pasien yang berada dalam spektrum tertentu akan menentukan intervensi yang dilakukan oleh perawat. Dalam hal ini, perawat harus memahami secara utuh hubungan yang erat antar keempat komponen tersebut, sehingga pendekatan dalam memberikan asuhan keperawatan menjadi tepat dan efektif.

Dengan demikian, paradigma keperawatan yang meliputi manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan memberikan landasan kokoh bagi praktik keperawatan yang holistik, manusiawi, dan komprehensif. Pemahaman yang baik terhadap keempat konsep tersebut akan memungkinkan perawat untuk memberikan pelayanan yang tepat, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan nyata pasien. Hal ini secara nyata akan meningkatkan hasil perawatan dan kualitas hidup pasien, serta menciptakan hubungan terapeutik yang positif antara perawat dan pasien.

D. Hubungan antara Falsafah dan Paradigma dalam Praktik Klinis

Dalam praktik klinis keperawatan, falsafah dan paradigma merupakan dua elemen yang saling terkait erat serta saling melengkapi. Hubungan di antara keduanya sangat penting karena bersama-sama keduanya membentuk landasan teoretis maupun praktis bagi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi, manusiawi, dan sesuai dengan standar profesional. Pemahaman

tentang bagaimana falsafah dan paradigma ini berhubungan membantu perawat dalam mengambil keputusan klinis yang tepat dan konsisten dengan prinsip-prinsip keperawatan.

Falsafah keperawatan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan suatu sistem nilai dan keyakinan mendasar yang menjadi dasar bagi perilaku, sikap, dan tindakan seorang perawat. Falsafah mencakup keyakinan tentang hakikat manusia, kesehatan, lingkungan, serta peran dan tanggung jawab perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Dengan kata lain, falsafah menyediakan kerangka nilai yang menjadi dasar moral dan etis dalam praktik keperawatan. Nilai-nilai ini termasuk penghormatan terhadap martabat manusia, empati, integritas profesional, serta komitmen terhadap advokasi pasien. Sebagai contoh, nilai penghormatan terhadap martabat manusia menegaskan bahwa setiap tindakan keperawatan harus selalu menghargai hak, privasi, dan otonomi pasien. Dengan berpegang pada falsafah ini, perawat memahami bahwa pasien adalah individu yang utuh dengan berbagai aspek kehidupan yang perlu diperhatikan secara holistik.

Di sisi lain, paradigma keperawatan memberikan kerangka konseptual atau praktis yang digunakan oleh perawat untuk menerapkan nilai-nilai falsafah tersebut dalam praktik sehari-hari. Paradigma terdiri dari empat komponen utama yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Komponen-komponen ini memberikan struktur yang jelas tentang bagaimana perawat memandang pasien, memahami kondisi kesehatannya, mengelola lingkungan, serta melakukan intervensi keperawatan yang efektif. Paradigma keperawatan berfungsi sebagai alat praktis yang membantu perawat dalam menentukan cara terbaik untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah keperawatan secara konkret dan nyata di lingkungan klinis.

Hubungan yang paling jelas antara falsafah dan paradigma keperawatan terlihat dalam cara perawat mengimplementasikan nilai-nilai falsafah dalam asuhan keperawatan melalui paradigma tersebut. Misalnya, dalam falsafah keperawatan terdapat nilai penghormatan terhadap martabat pasien dan pemberian asuhan yang holistik. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam praktik klinis, perawat menggunakan paradigma keperawatan yang menempatkan manusia sebagai individu dengan berbagai aspek kehidupan (fisik, psikologis, sosial, spiritual) yang harus dipahami secara menyeluruh. Paradigma keperawatan membantu perawat untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien secara holistik, menentukan intervensi yang sesuai, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses penyembuhan.

Sebagai ilustrasi, seorang perawat yang menangani pasien dengan penyakit kronis menggunakan falsafah keperawatan untuk memahami bahwa pasien tersebut bukan hanya individu yang sakit secara fisik, tetapi juga memiliki berbagai aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang mempengaruhi kondisinya. Dengan

menggunakan paradigma keperawatan, perawat kemudian mampu mengidentifikasi secara jelas bagaimana lingkungan sosial, seperti dukungan keluarga atau komunitas, mempengaruhi kondisi kesehatan pasien. Berdasarkan pemahaman tersebut, perawat dapat merencanakan dan melaksanakan intervensi yang tidak hanya bertujuan mengatasi gejala fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, paradigma memberikan cara praktis bagi perawat untuk menerjemahkan nilai-nilai falsafah keperawatan menjadi tindakan nyata yang bermanfaat secara langsung bagi pasien.

Selain itu, hubungan antara falsafah dan paradigma keperawatan juga terlihat jelas dalam proses pengambilan keputusan klinis. Nilai-nilai falsafah keperawatan seperti advokasi pasien dan tanggung jawab profesional berperan penting dalam membimbing perawat ketika menghadapi dilema etika dalam praktiknya. Paradigma keperawatan kemudian menjadi alat yang membantu perawat dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam pengambilan keputusan, seperti kondisi pasien, lingkungan yang mempengaruhi kesehatan pasien, serta intervensi terbaik yang harus dilakukan. Oleh karena itu, paradigma membantu memastikan bahwa keputusan klinis yang diambil selalu konsisten dengan nilai-nilai falsafah keperawatan.

Dengan demikian, falsafah dan paradigma keperawatan memiliki hubungan timbal balik yang kuat dalam praktik klinis. Falsafah menyediakan nilai-nilai inti yang mendasari semua tindakan dan keputusan seorang perawat, sementara paradigma memberikan kerangka kerja yang memungkinkan nilai-nilai tersebut diaplikasikan secara efektif dalam kehidupan nyata di lingkungan klinis. Pemahaman yang baik tentang hubungan ini sangat penting bagi perawat untuk dapat memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, holistik, manusiawi, serta sesuai dengan standar etik dan profesional yang berlaku. Hubungan yang harmonis antara falsafah dan paradigma keperawatan memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan oleh perawat tidak hanya efektif dalam meningkatkan kondisi fisik pasien, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

E. Peran Falsafah dan Paradigma dalam Pengambilan Keputusan Klinis

Dalam praktik keperawatan, pengambilan keputusan klinis merupakan aspek sentral yang menuntut seorang perawat untuk berpikir secara kritis, bertindak berdasarkan bukti ilmiah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral yang berlaku. Keputusan yang diambil dalam konteks ini tidak hanya berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien, tetapi juga berpengaruh pada integritas profesional seorang perawat. Dalam situasi tersebut, falsafah dan paradigma keperawatan memainkan peran krusial dalam membantu perawat mengambil keputusan klinis secara tepat, terarah, serta sejalan dengan standar profesional keperawatan.

Pertama-tama, falsafah keperawatan memberikan pedoman moral dan etika yang menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan klinis. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap martabat pasien, advokasi pasien, integritas profesional, serta tanggung jawab dalam pemberian asuhan holistik. Dalam situasi klinis nyata, seorang perawat sering kali dihadapkan pada dilema etika yang kompleks, seperti menentukan tindakan terbaik ketika ada perbedaan pendapat antara pasien, keluarga, atau tim medis, atau ketika harus memutuskan sejauh mana intervensi harus dilakukan pada pasien dalam kondisi terminal atau kritis. Dalam menghadapi dilema semacam ini, falsafah keperawatan berfungsi sebagai kompas moral yang membantu perawat mempertimbangkan berbagai aspek etis seperti penghormatan terhadap otonomi pasien, keadilan dalam pemberian layanan, serta kewajiban moral perawat untuk senantiasa melindungi hak dan kepentingan terbaik pasien.

Misalnya, ketika seorang pasien lanjut usia yang mengalami demensia menolak intervensi medis tertentu, seorang perawat yang menggunakan falsafah keperawatan akan mempertimbangkan prinsip penghormatan terhadap martabat dan otonomi pasien, meskipun ada tekanan dari keluarga atau tim medis untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam situasi ini, falsafah keperawatan mengarahkan perawat untuk tetap menghargai preferensi pasien sekaligus melakukan upaya edukasi atau komunikasi yang optimal dengan keluarga maupun tim medis guna menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan terbaik pasien. Dengan demikian, keputusan klinis yang diambil tidak semata berdasarkan pertimbangan klinis atau teknis saja, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral dan etika secara mendalam.

Sementara falsafah keperawatan menyediakan dasar nilai moral, paradigma keperawatan memberikan kerangka analisis yang sistematis dan terstruktur dalam proses pengambilan keputusan klinis. Paradigma keperawatan yang mencakup konsep manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan membantu perawat dalam mengidentifikasi secara komprehensif berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pasien. Kerangka analisis ini memungkinkan perawat mengevaluasi kondisi pasien secara holistik, menentukan kebutuhan pasien secara tepat, serta menetapkan prioritas intervensi berdasarkan tingkat urgensi maupun dampaknya terhadap kesejahteraan pasien.

Sebagai contoh, dalam menangani seorang pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes melitus, paradigma keperawatan membantu perawat untuk tidak hanya memfokuskan perhatian pada aspek fisik pasien, seperti kontrol kadar gula darah, tetapi juga mempertimbangkan faktor lingkungan sosial seperti dukungan keluarga, kondisi ekonomi, dan tingkat pengetahuan pasien tentang penyakitnya. Dengan menggunakan paradigma ini, perawat dapat menentukan bahwa prioritas tindakan mungkin tidak hanya pemberian obat-obatan, tetapi juga edukasi pasien

dan keluarganya tentang manajemen diabetes, perubahan gaya hidup, atau intervensi psikologis untuk meningkatkan motivasi pasien dalam pengelolaan penyakitnya.

Dalam situasi klinis darurat sekalipun, paradigma keperawatan memberikan panduan jelas tentang bagaimana intervensi harus dilakukan berdasarkan interaksi komponen-komponennya. Misalnya, pada pasien yang mengalami cedera berat akibat kecelakaan lalu lintas, paradigma keperawatan membantu perawat menentukan bahwa prioritas tindakan harus segera diarahkan pada stabilisasi kondisi fisik pasien (komponen kesehatan), penciptaan lingkungan klinis yang aman dan mendukung pemulihan (komponen lingkungan), serta pendekatan keperawatan yang terkoordinasi dan multidisipliner untuk mendukung kesembuhan pasien secara maksimal.

Gabungan antara falsafah dan paradigma keperawatan memastikan bahwa pengambilan keputusan klinis selalu berpihak pada kepentingan terbaik pasien serta sesuai dengan standar profesional yang tinggi. Proses ini juga memperkuat akuntabilitas dan integritas seorang perawat, karena keputusan klinis yang diambil selalu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, maupun profesional. Dalam jangka panjang, pendekatan ini menciptakan kepercayaan yang tinggi dari pasien, keluarga, maupun masyarakat terhadap kualitas pelayanan keperawatan.

F. Latihan Soal

Soal 1

Rudi (40 tahun) mengalami gagal ginjal kronik dan harus menjalani cuci darah rutin. Selain masalah fisik, Rudi juga mengalami stres, merasa cemas, kehilangan semangat hidup, dan merasa kesepian. Sebagai perawat, pendekatan apa yang paling tepat Anda gunakan berdasarkan falsafah keperawatan?

- A. Fokus pada penanganan fisik semata dengan memonitor tanda vital secara ketat.
- B. Memberikan edukasi kesehatan secara ringkas tentang pentingnya kepatuhan terapi saja.
- C. Melibatkan keluarga untuk mendukung pasien secara emosional dan sosial.
- D. Menghindari pembahasan masalah psikologis pasien karena itu bukan tugas utama perawat.
- E. Memfokuskan asuhan hanya pada aspek spiritual pasien saja.

Kunci Jawaban: C

Rasional: Pendekatan falsafah keperawatan bersifat holistik, sehingga selain perawatan fisik, aspek psikologis, sosial, dan spiritual juga harus dipenuhi, termasuk melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan.

Soal 2

Seorang perawat dihadapkan pada situasi di mana seorang pasien lansia dengan gangguan demensia menolak pemberian infus meskipun kondisinya sedang mengalami dehidrasi berat. Keluarga memaksa tindakan dilakukan tanpa persetujuan pasien. Apa tindakan paling tepat yang dilakukan oleh perawat berdasarkan prinsip advokasi dalam falsafah keperawatan?

- A. Menyetujui permintaan keluarga tanpa mempertimbangkan pendapat pasien.
- B. Mengabaikan permintaan keluarga karena pasien adalah prioritas utama.
- C. Menjelaskan pentingnya tindakan tersebut kepada pasien dan keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama.
- D. Memaksa pasien secara fisik untuk menerima tindakan medis tersebut.
- E. Melaporkan ke polisi karena keluarga tidak mendukung pasien.

Kunci Jawaban: C

Rasional: Prinsip advokasi dalam falsafah keperawatan menuntut perawat untuk melindungi hak pasien, namun juga perlu adanya komunikasi dan edukasi kepada keluarga agar keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan terbaik pasien.

Soal 3

Seorang pasien mengalami diabetes tipe 2 yang sulit terkontrol karena pola makan yang buruk dan kurangnya dukungan keluarga. Berdasarkan paradigma keperawatan, pendekatan mana yang paling tepat dalam menentukan prioritas asuhan?

- A. Berfokus hanya pada pengobatan farmakologis untuk menurunkan gula darah pasien.
- B. Mengabaikan aspek dukungan keluarga karena dianggap tidak penting.
- C. Memberikan edukasi tentang diabetes kepada pasien sekaligus melibatkan keluarga untuk memberikan dukungan sosial.
- D. Meminta pasien menyelesaikan masalah sosialnya sendiri.
- E. Menyarankan pasien untuk berobat ke tenaga kesehatan lain yang lebih ahli.

Kunci Jawaban: C

Rasional: Berdasarkan paradigma keperawatan, kondisi kesehatan pasien dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Melibatkan keluarga sebagai bentuk lingkungan sosial yang mendukung penting dalam mencapai hasil perawatan optimal.

Soal 4

Seorang perawat menghadapi pasien yang marah karena merasa tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai tindakan operasi yang akan dijalani. Apa yang seharusnya dilakukan oleh perawat berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat pasien dalam falsafah keperawatan?

- A. Menyalahkan pasien karena tidak bertanya sebelumnya.

- B. Mengabaikan keluhan pasien karena merasa sudah cukup memberikan informasi.
- C. Menjelaskan kembali secara rinci informasi mengenai tindakan operasi yang akan dilakukan secara terbuka dan jelas.
- D. Mengarahkan pasien untuk bertanya kepada dokter secara langsung.
- E. Mengalihkan perhatian pasien dengan topik lain agar tidak merasa cemas.

Kunci Jawaban: C

Rasional: Prinsip penghormatan terhadap martabat pasien berarti perawat harus menghargai hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan mengenai kondisi serta tindakan medis yang akan diterima.

Soal 5

Perawat Ani menyadari bahwa seorang pasien mengalami cedera fisik akibat kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mengalami trauma psikologis. Berdasarkan paradigma keperawatan, tindakan prioritas Ani adalah:

- A. Memastikan stabilisasi kondisi fisik terlebih dahulu sambil memperhatikan kondisi psikologis pasien secara bersamaan.
- B. Mengabaikan kondisi psikologis karena cedera fisik lebih penting.
- C. Berfokus hanya pada pemberian obat-obatan untuk mengatasi rasa nyeri fisik.
- D. Menyerahkan kondisi psikologis sepenuhnya kepada psikolog karena bukan tugas utama perawat.
- E. Menginstruksikan keluarga untuk mengurus sendiri masalah psikologis pasien.

Kunci Jawaban: A

Rasional: Paradigma keperawatan menuntut perawat untuk memberikan perawatan secara holistik. Kondisi fisik perlu segera diatasi, namun kondisi psikologis juga tidak boleh diabaikan. Keduanya harus diperhatikan secara simultan.

G. Rangkuman Materi

Falsafah keperawatan merupakan sistem nilai dan keyakinan dasar yang menjadi pedoman utama bagi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan secara holistik. Falsafah ini menekankan pentingnya memandang manusia secara utuh sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual, sehingga perawat tidak hanya fokus pada aspek fisik pasien tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan spiritualnya. Kesehatan dilihat sebagai kondisi dinamis yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, sehingga tugas perawat melibatkan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pendampingan pemulihan. Lingkungan, baik fisik maupun sosial, juga merupakan aspek penting yang harus dikelola perawat untuk mendukung proses penyembuhan pasien.

Prinsip-prinsip utama dalam falsafah keperawatan, seperti penghormatan terhadap martabat pasien, advokasi pasien, asuhan holistik, dan tanggung jawab profesional, memberikan pedoman etis yang jelas bagi praktik keperawatan. Prinsip-

prinsip ini memastikan bahwa perawat selalu bertindak dengan menghargai hak pasien, memberikan perlindungan kepada pasien yang rentan, serta bertanggung jawab penuh atas kualitas dan keselamatan pelayanan yang diberikan.

Paradigma keperawatan melengkapi falsafah ini dengan menyediakan kerangka konseptual yang sistematis melalui empat komponennya yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Paradigma ini membantu perawat memahami kondisi pasien secara menyeluruh, menentukan prioritas intervensi secara tepat, serta memastikan pelayanan keperawatan efektif dan sesuai kebutuhan nyata pasien. Hubungan antara falsafah dan paradigma ini sangat erat karena falsafah memberikan nilai-nilai dasar, sedangkan paradigma memberikan struktur yang konkret untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari.

Dalam praktik klinis, falsafah dan paradigma memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan klinis dengan menyediakan panduan moral, etika, serta kerangka analisis yang jelas. Gabungan keduanya memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perawat selalu berpihak pada kepentingan terbaik pasien, mempertimbangkan semua aspek secara holistik, serta memenuhi standar profesional keperawatan. Dengan demikian, integrasi falsafah dan paradigma keperawatan menjadi landasan kuat dalam menciptakan asuhan yang berkualitas tinggi, efektif, manusiawi, serta mampu meningkatkan kepercayaan pasien dan masyarakat terhadap profesi keperawatan.

H. Glosarium

Advokasi Pasien:

Peran perawat dalam membela dan melindungi hak-hak pasien, terutama ketika pasien tidak mampu menyampaikan keinginannya secara jelas.

Asuhan Keperawatan Holistik:

Pendekatan keperawatan yang mempertimbangkan kebutuhan pasien dari semua dimensi kehidupan, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Biopsikososial dan Spiritual:

Pandangan yang melihat manusia sebagai makhluk kompleks yang terdiri dari aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

Empati:

Kemampuan perawat untuk memahami secara mendalam perasaan, pikiran, dan kondisi yang dialami pasien sehingga mampu memberikan asuhan yang tepat sesuai kebutuhan pasien.

Falsafah Keperawatan:

Sistem nilai dan keyakinan mendasar yang menjadi pedoman bagi perawat dalam bersikap, berpikir, dan bertindak dalam praktik profesionalnya.

Integritas Profesional:

Konsistensi antara nilai, sikap, tindakan, dan komitmen seorang perawat dalam menjalankan tugas profesional secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta berdedikasi tinggi.

Komunikasi Efektif:

Proses pertukaran informasi yang jelas, terbuka, dan akurat antara perawat, pasien, keluarga, serta tim kesehatan lainnya, untuk menciptakan hubungan saling percaya dan kolaborasi yang baik.

Kontinum Kesehatan:

Rentang kondisi kesehatan yang dinamis, bergerak secara terus-menerus dari sehat hingga sakit, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Lingkungan Internal dan Eksternal:

Faktor-faktor dari dalam individu (internal: status emosional, genetik, motivasi) serta dari luar individu (eksternal: kondisi fisik, sosial, budaya, ekonomi) yang mempengaruhi kondisi kesehatan.

Manusia (dalam paradigma keperawatan):

Individu, keluarga, kelompok, atau komunitas sebagai penerima utama asuhan keperawatan, yang memiliki kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Nilai Etika:

Prinsip moral yang mendasari tindakan keperawatan, mencakup penghormatan terhadap martabat pasien, menjaga kerahasiaan, bertindak adil, serta memberikan pelayanan optimal tanpa diskriminasi.

Paradigma Keperawatan:

Kerangka konsep atau pola pikir yang digunakan perawat untuk memahami dan menganalisis kondisi pasien secara holistik serta menentukan intervensi keperawatan yang tepat.

Pengambilan Keputusan Klinis:

Proses berpikir kritis dan sistematis perawat dalam menentukan prioritas tindakan yang terbaik untuk pasien, berdasarkan prinsip-prinsip moral, etika, serta kerangka analisis paradigma keperawatan.

Penghormatan Terhadap Martabat Pasien:

Prinsip dalam falsafah keperawatan yang mewajibkan perawat untuk menghormati hak dan otonomi pasien serta memperlakukan pasien secara manusiawi, adil, dan setara.

Tanggung Jawab Profesional:

Kewajiban moral dan hukum perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, berdasarkan bukti ilmiah, serta bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

I. Daftar Pustaka

- Alligood, M. R. (2022). *Nursing theorists and their work* (10th ed.). Elsevier.
- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021). *Kozier & Erb's fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (11th ed.). Pearson Education.
- Butts, J. B., & Rich, K. L. (2019). *Nursing ethics: Across the curriculum and into practice* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Fawcett, J. (2021). *Applying conceptual models of nursing: Quality improvement, research, and practice* (3rd ed.). Springer Publishing Company.
- Masters, K. (2020). *Role development in professional nursing practice* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- McEwen, M., & Wills, E. M. (2018). *Theoretical basis for nursing* (5th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2022). *Fundamentals of nursing* (11th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Smith, M. C., & Parker, M. E. (2021). *Nursing theories and nursing practice* (5th ed.). F.A. Davis Company.
- Tomey, A. M., & Alligood, M. R. (2017). *Nursing theorists and their work* (9th ed.). Mosby.
- Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2019). *Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice* (2nd ed.). Elsevier Health Sciences.

BAB 3

TREN KEPERAWATAN DIMASA YANG AKAN DATANG

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu menunjukkan pemahaman terhadap berbagai tren keperawatan di masa depan serta menerapkan prinsip-prinsip keperawatan modern yang berbasis teknologi, kolaborasi interprofesional, dan praktik berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai tren keperawatan yang akan berkembang di masa depan, serta mempersiapkan diri secara profesional untuk menghadapi tantangan dalam praktik klinis maupun komunitas.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tren utama dalam profesi keperawatan masa depan.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dampak kemajuan teknologi informasi terhadap praktik keperawatan.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep interprofesionalisme dalam berbagai skenario keperawatan.
- Mahasiswa mampu mengevaluasi pentingnya evidence-based practice (EBP) dalam peningkatan kualitas pelayanan keperawatan.
- Mahasiswa mampu menyusun rencana pengembangan diri sebagai seorang perawat profesional yang adaptif terhadap perubahan.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, profesi keperawatan mengalami evolusi signifikan dalam merespons tuntutan kebutuhan kesehatan masyarakat global. Transformasi ini didorong oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi kesehatan, perubahan demografis populasi, tantangan penyakit kronis, serta peningkatan harapan hidup masyarakat. Ke depan, perawat akan dituntut tidak hanya memiliki kemampuan klinis yang kuat, tetapi juga keahlian di bidang teknologi informasi, interprofesionalisme, dan pendekatan holistik berbasis bukti. Tren keperawatan yang

akan datang menuntut perawat untuk terus berkembang secara profesional, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan kesehatan baru yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman tentang tren ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa keperawatan sebagai bekal dalam menghadapi realitas praktik di masa depan.

A. Teknologi dalam Keperawatan

Seiring kemajuan teknologi, dunia keperawatan pun mengalami perubahan signifikan dalam praktik sehari-hari. Teknologi modern membantu perawat dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, akurat, cepat, dan efisien. Dalam hal ini, teknologi seperti telemedicine, electronic health records (EHR), wearable devices, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi semakin penting dan banyak dimanfaatkan. Oleh karena itu, perawat perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilannya dalam menggunakan teknologi tersebut agar mampu memberikan asuhan keperawatan terbaik kepada pasien.

1. Telemedicine

Telemedicine merupakan layanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, memungkinkan konsultasi dan perawatan tanpa harus bertatap muka secara fisik.

Detail Pemanfaatan dalam Keperawatan:

- a. Konsultasi jarak jauh: Perawat dapat berkomunikasi dengan pasien atau tim medis lainnya tanpa hambatan geografis.
- b. Monitoring pasien kronis: Memungkinkan pemantauan kondisi pasien seperti diabetes atau penyakit jantung secara terus-menerus.
- c. Pendidikan pasien: Menyediakan informasi, bimbingan, serta edukasi kesehatan yang mudah diakses pasien.
- d. Kolaborasi Interprofesional: Memudahkan diskusi antara perawat, dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya tentang kondisi pasien secara real-time.

2. Electronic Health Records (EHR)

EHR adalah sistem informasi elektronik yang mengintegrasikan data rekam medis pasien secara digital, terstandar, dan dapat diakses secara real-time.

Detail Pemanfaatan dalam Keperawatan:

- a. Akses cepat data pasien: Perawat dapat mengakses riwayat medis pasien, diagnosis sebelumnya, alergi, dan pengobatan yang sedang dijalani dengan cepat dan tepat.
- b. Pengurangan kesalahan medis: Mengurangi risiko kesalahan pemberian obat, diagnosis yang salah, atau duplikasi tes laboratorium.
- c. Integrasi data antar-unit pelayanan: Memfasilitasi kelancaran transisi pasien antar unit pelayanan atau fasilitas kesehatan lain.
- d. Analisis dan evaluasi kualitas pelayanan: Memudahkan audit internal untuk evaluasi kinerja tim keperawatan dan layanan yang diberikan kepada pasien.

3. Wearable Devices

Wearable devices adalah perangkat elektronik yang dapat dipakai pada tubuh pasien untuk memonitor berbagai parameter kesehatan secara langsung dan berkelanjutan.

Detail Pemanfaatan dalam Keperawatan:

- a. Monitoring kesehatan secara real-time: Mengukur tanda vital seperti denyut jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, dan kadar gula darah secara real-time.
- b. Deteksi dini gangguan kesehatan: Memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan kondisi pasien yang membutuhkan intervensi segera.
- c. Peningkatan partisipasi pasien: Pasien lebih aktif memonitor kondisi kesehatannya, sehingga mendukung perawat dalam merancang perawatan yang lebih personal.
- d. Pengumpulan data kesehatan secara komprehensif: Memungkinkan perawat mengumpulkan data kesehatan pasien yang akurat, objektif, dan mudah dianalisis.

4. Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan

AI merujuk pada penggunaan algoritma canggih untuk menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendukung pengambilan keputusan klinis.

Detail Pemanfaatan dalam Keperawatan:

- a. Analisis prediktif kondisi pasien: AI dapat memprediksi risiko komplikasi seperti sepsis, gagal jantung, atau deteriorasi klinis sebelum kondisi pasien memburuk.
- b. Dukungan pengambilan keputusan klinis: Membantu perawat dalam membuat keputusan perawatan berdasarkan data pasien secara otomatis dan akurat.
- c. Automasi dokumentasi keperawatan: Membantu pengisian dokumentasi secara efisien, akurat, dan konsisten, sehingga perawat lebih fokus pada asuhan langsung pasien.
- d. Chatbots kesehatan: Memungkinkan pasien mendapatkan informasi atau nasihat kesehatan secara cepat melalui aplikasi berbasis AI, sehingga mengurangi beban kerja perawat dalam menjawab pertanyaan rutin.

B. Keperawatan Berbasis Bukti (EBP)

Keperawatan Berbasis Bukti (EBP) adalah pendekatan sistematis dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik hasil penelitian terbaru, keahlian klinis perawat, serta preferensi atau nilai pasien. EBP merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa intervensi keperawatan yang diberikan kepada pasien efektif, aman, dan menghasilkan hasil kesehatan yang optimal.

Dalam konteks perkembangan keperawatan masa depan, implementasi EBP akan menjadi standar yang diwajibkan dalam setiap pelayanan klinis. Perawat tidak

hanya diharapkan mampu memberikan pelayanan dasar, tetapi juga harus terampil dalam memahami, menilai, serta mengaplikasikan bukti penelitian terbaru dalam praktik klinis sehari-hari.

1. Pengertian Keperawatan Berbasis Bukti (EBP)

EBP adalah proses integrasi antara penelitian terbaik, keahlian klinis, dan nilai pasien dalam pengambilan keputusan klinis demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

- a. Penelitian terbaik: hasil penelitian yang telah diuji secara ilmiah dan relevan terhadap kondisi klinis yang dihadapi.
- b. Keahlian klinis: pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan perawat dalam mengenali kondisi pasien serta merancang intervensi secara efektif.
- c. Nilai atau preferensi pasien: kebutuhan, pilihan, nilai-nilai pribadi, serta latar belakang budaya pasien yang harus dihormati dalam proses perawatan.

2. Langkah-Langkah Implementasi EBP dalam Praktik Keperawatan

Implementasi EBP dilakukan melalui beberapa langkah sistematis:

- a. Merumuskan pertanyaan klinis (PICO):
 - 1) Patient (populasi/pasien): menentukan siapa atau populasi apa yang menjadi fokus.
 - 2) Intervention (intervensi): menentukan intervensi yang ingin dilakukan.
 - 3) Comparison (perbandingan): menentukan intervensi pembandingan, jika ada.
 - 4) Outcome (hasil): menentukan hasil yang ingin dicapai.
- b. Mencari bukti ilmiah terbaik:
 - 1) Mengakses jurnal penelitian terpercaya seperti Scopus, PubMed, ProQuest, ScienceDirect.
 - 2) Memilih bukti dengan kualitas metodologi penelitian yang baik (misal: systematic review, randomized controlled trial).
- c. Menilai bukti ilmiah secara kritis:
 - 1) Mengevaluasi kualitas, validitas, reliabilitas, dan relevansi bukti terhadap kasus klinis.
 - 2) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari studi yang ada.
- d. Mengintegrasikan bukti dalam praktik klinis:
 - 1) Menggunakan hasil penelitian untuk merancang intervensi perawatan yang efektif dan efisien.
 - 2) Menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan khusus pasien dan kondisi klinis.
- e. Mengevaluasi efektivitas intervensi yang diterapkan:
 - 1) Mengamati hasil intervensi melalui indikator klinis (seperti tanda vital, tingkat kesembuhan, kepuasan pasien).
 - 2) Menggunakan hasil evaluasi sebagai masukan untuk memperbaiki intervensi selanjutnya.

3. Manfaat Implementasi EBP dalam Keperawatan

EBP memiliki banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan
 - 1) Perawatan menjadi lebih efektif karena didasarkan pada bukti ilmiah yang sudah teruji.
 - 2) Mengurangi kesalahan atau praktik keperawatan yang tidak efektif.
- b. Efisiensi waktu dan biaya
 - 1) Meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak perlu dengan menerapkan intervensi yang terbukti efektif.
 - 2) Mengurangi biaya perawatan dengan mencegah komplikasi atau intervensi berulang yang tidak efektif.
- c. Meningkatkan keselamatan pasien
 - 1) Menurunkan risiko kesalahan medis seperti infeksi nosokomial, medication error, atau komplikasi klinis lainnya.
 - 2) Mengurangi risiko efek samping dari tindakan yang kurang efektif.
- d. Meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalisme perawat
 - 1) Menjadikan perawat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah.
 - 2) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan.

4. Hambatan dalam Implementasi EBP

Walaupun EBP memiliki manfaat besar, penerapannya dalam praktik klinis juga menghadapi beberapa hambatan yang harus diatasi, seperti:

- a. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan perawat dalam mengakses dan mengevaluasi literatur penelitian.
- b. Terbatasnya waktu yang dimiliki perawat untuk membaca dan menelaah hasil penelitian terkini.
- c. Resistensi terhadap perubahan praktik lama yang sudah terbiasa dilakukan.
- d. Kurangnya dukungan institusional dalam menyediakan akses terhadap sumber daya penelitian terbaru.

5. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi EBP dalam Keperawatan

Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

- a. Pelatihan atau workshop EBP secara rutin bagi perawat.
- b. Meningkatkan akses terhadap sumber informasi seperti jurnal dan database ilmiah yang terpercaya.
- c. Dukungan penuh dari manajemen dan pemimpin klinis untuk menciptakan budaya EBP di lingkungan kerja.

- d. Pembentukan tim khusus atau EBP Champions di institusi yang bertugas membimbing dan memfasilitasi penerapan EBP secara berkelanjutan.

C. Interprofesionalisme dan Kolaborasi

Dalam konteks perkembangan dunia kesehatan modern, pendekatan interprofesional dan kolaborasi menjadi elemen yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pelayanan kesehatan. Interprofesionalisme merupakan pendekatan kerja sama lintas profesi yang melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti perawat, dokter, ahli gizi, apoteker, fisioterapis, psikolog, dan profesi kesehatan lainnya untuk secara aktif dan terintegrasi dalam perawatan pasien. Di masa depan, perawat akan semakin berperan sentral dalam tim interprofesional tersebut, memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat komprehensif, holistik, serta menghasilkan hasil kesehatan yang optimal bagi pasien.

Dalam tim interprofesional, perawat memiliki posisi unik karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien secara intensif. Interaksi yang erat ini memberikan perawat kesempatan untuk secara mendalam memahami kondisi pasien, termasuk perubahan-perubahan yang dialami, kebutuhan spesifik, preferensi pasien, hingga nilai-nilai pribadi pasien yang penting dalam merencanakan dan melaksanakan perawatan. Oleh karena itu, perawat menjadi "jembatan komunikasi" antara pasien dengan profesi kesehatan lainnya, memastikan bahwa setiap aspek perawatan terpadu dengan baik.

Kolaborasi interprofesional menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi pasien. Penyakit kronis, kondisi komorbiditas, dan berbagai tantangan dalam kesehatan mental memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup berbagai keahlian profesional. Sebagai contoh, dalam menangani pasien diabetes, perawat perlu bekerja sama dengan dokter dalam menentukan terapi farmakologis, dengan ahli gizi dalam merancang diet khusus, dengan fisioterapis dalam mengembangkan program aktivitas fisik, serta dengan apoteker untuk edukasi dan manajemen obat. Kolaborasi tersebut bukan sekadar interaksi yang bersifat administratif, tetapi merupakan integrasi pemikiran, pengetahuan, dan keterampilan dari masing-masing profesi untuk menentukan intervensi yang terbaik.

Dalam praktik kolaborasi interprofesional, setiap anggota tim kesehatan tidak hanya bertanggung jawab untuk menjalankan peran masing-masing, tetapi juga harus saling memahami dan menghormati kompetensi serta batasan keahlian dari profesi lain. Pemahaman mendalam tentang peran masing-masing profesi membantu mencegah kesalahpahaman, konflik, atau tumpang tindih tanggung jawab yang bisa berdampak negatif pada pasien. Dengan demikian, perawat perlu terus meningkatkan kemampuan komunikasi, mendengarkan aktif, dan

keterampilan interpersonal untuk memudahkan kolaborasi yang efektif dengan rekan sejawat lintas profesi.

Manfaat utama dari kolaborasi interprofesional ini sangat nyata dalam meningkatkan hasil kesehatan pasien. Pendekatan ini secara nyata dapat mengurangi kesalahan medis, meningkatkan keselamatan pasien, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Melalui kolaborasi, keputusan klinis dibuat dengan lebih baik dan terinformasi secara lengkap, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya komplikasi maupun perawatan ulang. Pasien juga akan merasa lebih diperhatikan karena setiap keputusan perawatan mencerminkan perspektif holistik dari berbagai aspek kesehatan yang relevan.

Selain itu, kolaborasi interprofesional memiliki peran penting dalam meningkatkan kepuasan kerja bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat. Ketika perawat terlibat dalam tim kolaboratif yang solid, mereka mendapatkan dukungan profesional yang lebih kuat, pengakuan terhadap kontribusinya, serta kesempatan untuk belajar dan berkembang secara profesional dari interaksi dengan profesi lainnya. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan motivasi perawat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Untuk memastikan kolaborasi interprofesional ini berhasil diterapkan secara optimal di masa depan, lembaga pendidikan kesehatan juga harus menyesuaikan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada interprofesionalisme sejak dini. Mahasiswa keperawatan dan profesi kesehatan lainnya perlu diperkenalkan dengan prinsip kolaborasi interprofesional sejak awal masa pendidikan, misalnya melalui praktik interprofesional langsung di lingkungan klinis, simulasi bersama antar mahasiswa lintas profesi, serta pelatihan tentang komunikasi efektif dalam tim. Dengan demikian, para calon tenaga kesehatan, termasuk perawat, memiliki kesiapan yang baik untuk menghadapi tantangan kolaborasi ketika memasuki dunia kerja nyata.

Dengan memperkuat interprofesionalisme dan kolaborasi dalam dunia keperawatan, diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan kesehatan yang lebih terpadu, efektif, efisien, dan berorientasi pada pasien. Hal ini bukan hanya sekadar memenuhi tuntutan perkembangan ilmu dan praktik kesehatan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai humanistik yang mendasar dalam pelayanan kesehatan modern, yaitu kerjasama, penghargaan terhadap berbagai perspektif profesi, serta komitmen bersama untuk mencapai hasil kesehatan terbaik bagi pasien.

D. Pendekatan Holistik dalam Asuhan Keperawatan

Pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan merupakan filosofi perawatan yang semakin penting dan relevan dalam praktik keperawatan masa kini maupun masa depan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks, terdiri dari berbagai aspek yang saling terkait, termasuk

aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk tidak hanya terfokus pada penanganan gejala fisik atau penyakit pasien saja, tetapi juga secara mendalam memperhatikan seluruh kebutuhan pasien dalam berbagai dimensi kehidupannya.

Pendekatan holistik menganggap bahwa aspek fisik pasien hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan diri pasien. Seorang pasien yang mengalami penyakit atau gangguan kesehatan sering kali juga merasakan tekanan psikologis seperti kecemasan, stres, depresi, hingga ketakutan. Kondisi ini juga biasanya mempengaruhi aspek sosial pasien, misalnya dalam hubungan interpersonal, peran keluarga, serta hubungan dalam lingkungan masyarakatnya. Tidak jarang pula, pasien menghadapi pergulatan spiritual seperti pencarian makna hidup, penerimaan terhadap penyakit, hingga rasa kehilangan harapan.

Dalam pendekatan holistik, perawat harus mampu melihat pasien secara utuh sebagai seorang individu dengan latar belakang unik yang mencakup keyakinan, nilai-nilai pribadi, keluarga, dan budaya tempat pasien berasal. Dengan memahami keseluruhan latar belakang tersebut, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang tidak hanya efektif secara klinis tetapi juga sangat bermakna bagi pasien. Asuhan keperawatan holistik menempatkan hubungan terapeutik antara perawat dan pasien sebagai kunci dalam mencapai hasil kesehatan yang optimal, di mana perawat memberikan empati, perhatian, penghormatan, dan dukungan secara terus-menerus.

Pendekatan holistik dalam keperawatan juga menuntut perawat untuk peka terhadap kebutuhan psikologis pasien. Banyak pasien yang mengalami penderitaan secara psikologis akibat penyakit yang dideritanya, seperti rasa takut terhadap ketidakpastian prognosis, kecemasan akibat perubahan peran sosial, atau frustrasi karena keterbatasan fisik. Perawat perlu menyediakan ruang dialog dan pendampingan psikologis yang intensif kepada pasien, sehingga pasien merasa nyaman untuk mengekspresikan perasaannya. Pendampingan psikologis ini bisa dilakukan melalui pendekatan komunikasi terapeutik, mendengarkan aktif, memberikan afirmasi positif, serta edukasi kesehatan yang membantu pasien untuk mengelola stres atau emosi negatifnya dengan lebih baik.

Selain itu, pendekatan holistik juga menuntut perawat untuk memperhatikan aspek sosial dari pasien. Seorang pasien bukanlah individu yang hidup terisolasi, melainkan bagian dari sebuah sistem sosial yang kompleks, seperti keluarga dan komunitas. Penyakit atau gangguan kesehatan pada seorang individu juga secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan keluarganya, seperti perubahan peran keluarga, tekanan ekonomi, hingga beban emosional bagi anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, perawat harus mampu memberikan asuhan yang melibatkan keluarga, baik melalui edukasi tentang cara merawat

anggota keluarga yang sakit maupun dukungan sosial dalam menghadapi tantangan kesehatan yang sedang dialami oleh pasien dan keluarganya.

Aspek spiritual juga menjadi bagian integral dalam pendekatan holistik di mana perawat dituntut untuk peka dan menghormati keyakinan spiritual atau agama pasien. Kebutuhan spiritual yang tidak terpenuhi bisa menambah beban emosional dan psikologis pasien, yang pada akhirnya memperlambat proses penyembuhan. Dalam hal ini, perawat harus mampu melakukan pendekatan secara empatik, misalnya dengan membantu pasien menemukan makna positif dari pengalaman sakit yang dialami, mendukung aktivitas spiritual pasien seperti doa, meditasi, atau ibadah sesuai keyakinannya, serta bekerja sama dengan pemuka agama atau pembimbing spiritual jika diperlukan.

Dengan menerapkan pendekatan holistik secara konsisten, perawat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil akhir perawatan pasien. Asuhan keperawatan yang menyeluruh ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pasien tetapi juga membantu mempercepat proses penyembuhan secara fisik, mengurangi lama rawat inap, dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Pasien yang merasa diperhatikan secara utuh akan lebih kooperatif, optimis, serta memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam mengikuti berbagai intervensi yang diberikan.

Dalam upaya mewujudkan pendekatan holistik ini secara optimal, pendidikan keperawatan masa depan juga perlu menanamkan nilai-nilai holistik secara kuat sejak tahap awal pendidikan. Mahasiswa keperawatan perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang pengelolaan psikologis, sosial, dan spiritual pasien selain pelatihan klinis. Kurikulum pendidikan harus mendorong calon perawat untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, empati, komunikasi terapeutik, serta kepekaan budaya dan spiritual, yang akan membantu mereka lebih efektif dalam mengaplikasikan pendekatan holistik dalam praktik keperawatan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan merupakan representasi dari perawatan keperawatan yang berorientasi manusia seutuhnya. Dengan semakin berkembangnya kesadaran tentang pentingnya perawatan yang komprehensif, perawat masa depan dituntut untuk menjadi pelopor dalam penerapan prinsip-prinsip holistik ini. Pendekatan ini bukan hanya sekadar tuntutan profesional, tetapi juga mencerminkan komitmen etis dan humanistik perawat dalam memberikan layanan kesehatan terbaik yang menghormati dan menghargai martabat manusia secara utuh.

E. Peran Perawat dalam Pencegahan dan Promosi Kesehatan

Dalam paradigma pelayanan kesehatan masa kini, fokus perawatan tidak lagi terbatas pada tindakan kuratif atau pengobatan penyakit, tetapi juga sangat menekankan pada pencegahan penyakit serta promosi kesehatan secara aktif.

Dalam konteks ini, perawat memiliki peran yang sangat vital, strategis, dan sentral. Sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, perawat memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik, mengarahkan, serta memotivasi masyarakat agar mengadopsi gaya hidup sehat dan melakukan tindakan preventif secara konsisten.

Pencegahan penyakit dan promosi kesehatan adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan masyarakat sebelum terjadi gangguan kesehatan yang serius. Dalam hal ini, perawat memiliki peran sebagai pendidik kesehatan, pemberi konseling, serta advokat kesehatan yang mampu mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam komunitas. Melalui berbagai program edukasi kesehatan, perawat membantu masyarakat memahami risiko kesehatan yang mereka hadapi, mengidentifikasi faktor-faktor risiko potensial, serta menerapkan perilaku pencegahan penyakit yang efektif.

Peran perawat dalam pencegahan penyakit tidak terbatas pada edukasi formal saja, melainkan juga melalui pendekatan informal yang dilakukan di berbagai lingkungan seperti klinik komunitas, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, sekolah, tempat kerja, hingga di rumah-rumah warga. Dalam aktivitas sehari-hari, perawat mengajarkan tentang pentingnya imunisasi, pola makan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, pengendalian stres, hingga pola tidur yang sehat. Melalui pendekatan edukatif ini, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan kesadaran diri yang tinggi terhadap kesehatan mereka sendiri dan keluarga, sehingga dapat mengambil tindakan preventif sebelum munculnya penyakit.

Selain edukasi, perawat juga memainkan peran penting dalam proses advokasi kesehatan. Advokasi dalam konteks ini berarti bahwa perawat membantu masyarakat atau individu dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan serta membantu mereka mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya informasi kesehatan, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, atau kesulitan ekonomi. Sebagai advokat kesehatan, perawat juga bertanggung jawab dalam mendorong kebijakan publik yang mendukung terciptanya lingkungan hidup sehat, baik melalui kolaborasi dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam promosi kesehatan, peran perawat menjadi semakin luas, tidak hanya sekedar memberikan informasi tetapi juga memotivasi perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih positif. Promosi kesehatan lebih bersifat menyeluruh dan melibatkan pendekatan multidimensi, termasuk pendekatan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Perawat dituntut untuk memahami konteks sosial-budaya dari masyarakat tempat mereka bertugas, agar pesan-pesan kesehatan yang disampaikan dapat diterima dan dipraktikkan dengan baik. Perawat juga perlu

menggunakan metode komunikasi yang efektif, empati, serta pendekatan personal yang dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada mereka.

Perawat juga memiliki peran dalam pengelolaan risiko kesehatan di masyarakat, terutama dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyakit tertentu, seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, atau individu dengan penyakit kronis. Perawat merancang intervensi yang spesifik dan terarah bagi kelompok-kelompok ini, seperti screening rutin, program imunisasi tambahan, pengawasan gizi, atau konseling kesehatan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran perawat sangat penting untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang rentan mendapat perhatian khusus agar tetap sehat dan produktif.

Dalam konteks kesehatan komunitas, perawat juga memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat. Ini berarti perawat tidak hanya memberikan edukasi kesehatan secara pasif, tetapi juga aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka sendiri. Perawat membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan mandiri dalam menjaga kesehatannya, seperti keterampilan dalam mengelola penyakit kronis, cara menjaga kebersihan lingkungan, hingga kemampuan mengelola kesehatan mental secara mandiri. Dengan demikian, perawat membantu menciptakan komunitas yang mandiri, sehat, dan berdaya.

Pendidikan keperawatan masa depan harus semakin menguatkan kompetensi perawat dalam hal edukasi dan promosi kesehatan ini. Kurikulum pendidikan keperawatan perlu menekankan pelatihan tentang keterampilan komunikasi efektif, teknik edukasi masyarakat, strategi promosi kesehatan berbasis bukti, hingga pengelolaan program kesehatan komunitas secara lebih terstruktur dan sistematis. Dengan kompetensi ini, perawat akan lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya kesehatan preventif, peran perawat dalam edukasi dan promosi kesehatan akan semakin signifikan dan tidak tergantikan. Melalui perannya yang strategis ini, perawat membantu masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, mencegah penyakit, dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara keseluruhan. Kesehatan preventif adalah kunci dari sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien di masa depan, dan perawat merupakan ujung tombak dalam upaya tersebut.

F. Latihan Soal

Soal 1 (Teknologi dalam Keperawatan - Telemedicine)

Seorang pasien diabetes berusia 65 tahun tinggal di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Ia memerlukan konsultasi rutin mengenai pengaturan pola makan, pemantauan glukosa darah, serta evaluasi pengobatan. Sebagai perawat, pendekatan teknologi manakah yang paling tepat digunakan dalam situasi tersebut?

- A. Electronic Health Records (EHR)
- B. Wearable Devices
- C. Telemedicine (Benar)
- D. Artificial Intelligence (AI)
- E. Chatbot kesehatan berbasis AI

Kunci jawaban: c. Telemedicine

Rasional:

Telemedicine memungkinkan perawat untuk melakukan konsultasi jarak jauh tanpa hambatan geografis, tepat untuk pasien yang sulit dijangkau secara fisik sehingga konsultasi rutin tetap terlaksana.

Soal 2 (Keperawatan Berbasis Bukti - Langkah Implementasi EBP)

Seorang perawat ingin menerapkan Evidence-Based Practice (EBP) dalam manajemen nyeri pada pasien pasca operasi. Langkah awal yang paling tepat untuk dilakukan perawat dalam implementasi EBP adalah:

- A. Mengakses jurnal penelitian terbaru
- B. Mengevaluasi efektivitas intervensi yang sudah diterapkan
- C. Menentukan pertanyaan klinis menggunakan format PICO (Benar)
- D. Mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik langsung
- E. Membuat keputusan berdasarkan pengalaman klinis saja

Kunci jawaban: c. Menentukan pertanyaan klinis menggunakan format PICO

Rasional:

Langkah awal dalam EBP adalah merumuskan pertanyaan klinis secara spesifik menggunakan format PICO, sebelum melakukan pencarian bukti penelitian.

Soal 3 (Interprofesionalisme dan Kolaborasi)

Seorang pasien stroke membutuhkan perawatan yang komprehensif meliputi terapi fisik, terapi farmakologi, nutrisi, dan edukasi mandiri di rumah. Sebagai perawat, sikap apa yang paling utama untuk mendukung kolaborasi interprofesional dalam situasi tersebut?

- A. Berfokus hanya pada intervensi keperawatan sendiri
- B. Mengambil alih peran profesi lain dalam tim
- C. Menjalin komunikasi terbuka dengan semua anggota tim kesehatan (Benar)

- D. Menghindari diskusi agar tidak terjadi konflik
- E. Menyerahkan seluruh keputusan kepada dokter yang merawat

Kunci jawaban: c. Menjalin komunikasi terbuka dengan semua anggota tim kesehatan

Rasional:

Komunikasi terbuka dan efektif antarprofesi kesehatan adalah inti dari keberhasilan kolaborasi interprofesional, memastikan setiap aspek perawatan terpadu dengan baik.

Soal 4 (Pendekatan Holistik dalam Asuhan Keperawatan)

Ibu A (48 tahun) mengalami kanker payudara stadium lanjut. Ia menunjukkan tanda-tanda depresi, menarik diri dari lingkungan, dan mempertanyakan tujuan hidupnya. Sebagai perawat, pendekatan keperawatan apa yang paling tepat untuk dilakukan dalam situasi tersebut?

- A. Fokus hanya pada intervensi fisik untuk mengurangi nyeri
- B. Mengabaikan aspek spiritual karena bukan tugas perawat
- C. Memberikan edukasi kesehatan tanpa melibatkan keluarga
- D. Melakukan pendampingan psikologis dan spiritual secara intensif (Benar)
- E. Menghindari diskusi emosional agar tidak memperburuk kondisinya

Kunci jawaban: d. Melakukan pendampingan psikologis dan spiritual secara intensif

Rasional:

Pendekatan holistik menuntut perawat memberikan pendampingan psikologis dan spiritual, selain perawatan fisik, agar pasien mendapatkan perawatan yang menyeluruh dan bermakna.

Soal 5 (Peran Perawat dalam Pencegahan dan Promosi Kesehatan)

Di sebuah desa terpencil, angka kejadian hipertensi sangat tinggi akibat pola makan yang tidak sehat dan rendahnya aktivitas fisik. Sebagai seorang perawat komunitas, tindakan apa yang paling tepat untuk mencegah peningkatan kasus hipertensi di masyarakat?

- A. Hanya mengobati warga yang sudah sakit
- B. Melakukan edukasi massal tentang pentingnya pola makan sehat dan aktivitas fisik teratur (Benar)
- C. Menyerahkan sepenuhnya edukasi kesehatan kepada dokter
- D. Memberikan pengobatan rutin tanpa edukasi kesehatan tambahan
- E. Menunggu warga datang sendiri ke fasilitas kesehatan jika sudah sakit

Kunci jawaban: b. Melakukan edukasi massal tentang pentingnya pola makan sehat dan aktivitas fisik teratur

Rasional:

Perawat memiliki peran utama dalam edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan tindakan pencegahan sebelum munculnya penyakit.

G. Rangkuman Materi

Perkembangan dunia keperawatan di masa depan akan ditandai oleh kemajuan signifikan dalam pemanfaatan teknologi modern, penerapan keperawatan berbasis bukti (EBP), peningkatan kolaborasi interprofesional, penerapan pendekatan holistik, serta penguatan peran perawat dalam pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.

Pemanfaatan teknologi seperti telemedicine, Electronic Health Records (EHR), wearable devices, dan Artificial Intelligence (AI) memungkinkan perawat memberikan pelayanan yang lebih efektif, akurat, efisien, serta meningkatkan kualitas interaksi dengan pasien. Perawat perlu terus meningkatkan keterampilan teknologinya untuk memaksimalkan manfaat dari inovasi ini dalam praktik klinis sehari-hari.

Implementasi Keperawatan Berbasis Bukti (EBP) menjadi standar penting dalam praktik klinis, yang memastikan bahwa keputusan klinis dibuat berdasarkan integrasi bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, serta preferensi pasien. Walaupun ada beberapa hambatan dalam implementasinya, namun strategi seperti pelatihan rutin, dukungan institusional, serta pembentukan tim khusus dapat membantu perawat mengatasi tantangan tersebut.

Selanjutnya, kolaborasi interprofesional menjadi kunci dalam peningkatan hasil perawatan pasien. Perawat akan memainkan peran sentral dalam kerja sama dengan berbagai profesi kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, apoteker, fisioterapis, dan psikolog. Kolaborasi yang efektif akan menghasilkan keputusan klinis yang lebih baik, pelayanan yang terpadu, meningkatkan keselamatan pasien, serta memberikan lingkungan kerja yang positif bagi tenaga kesehatan.

Pendekatan holistik dalam keperawatan semakin penting sebagai filosofi perawatan yang melihat pasien sebagai individu yang utuh dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan memahami pasien secara menyeluruh, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih empatik, bermakna, dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien serta mempercepat pemulihan.

Terakhir, peran perawat dalam pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di masyarakat akan semakin vital. Perawat tidak hanya memberikan edukasi formal, tetapi juga berperan sebagai advokat kesehatan serta agen pemberdayaan masyarakat, mendorong perubahan perilaku positif menuju hidup sehat. Dengan semakin kuatnya kesadaran global akan pentingnya tindakan preventif, peran

strategis perawat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat menjadi tak tergantikan.

Secara keseluruhan, perkembangan ini menuntut perawat untuk terus belajar dan beradaptasi guna memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan standar profesionalisme yang tinggi, berbasis bukti, dan berorientasi pada kebutuhan pasien secara holistik.

H. Glosarium

Artificial Intelligence (AI)

Teknologi yang menggunakan algoritma canggih untuk analisis data dalam jumlah besar guna mendukung pengambilan keputusan klinis yang cepat, tepat, dan otomatis.

Chatbot Kesehatan

Aplikasi berbasis AI yang menyediakan informasi atau nasihat kesehatan secara cepat dan efisien melalui percakapan interaktif secara digital, sehingga mengurangi beban kerja perawat dalam menjawab pertanyaan pasien secara rutin.

Electronic Health Records (EHR)

Sistem rekam medis elektronik yang mengintegrasikan data kesehatan pasien secara digital, terstandar, dan dapat diakses secara real-time oleh tenaga kesehatan untuk memudahkan pelayanan klinis dan evaluasi kualitas pelayanan.

Monitoring Pasien Kronis

Proses pemantauan secara kontinu terhadap kondisi kesehatan pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung, untuk mendeteksi perubahan kondisi dan melakukan intervensi secara tepat waktu.

Telemedicine

Pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, memungkinkan konsultasi dan perawatan tanpa interaksi tatap muka secara langsung, serta memudahkan kolaborasi antarprofesi kesehatan.

Wearable Devices

Perangkat elektronik yang digunakan pada tubuh pasien untuk memonitor parameter kesehatan seperti denyut jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, dan gula darah secara real-time serta berkelanjutan.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan sistematis dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaru, keahlian klinis perawat, serta nilai atau preferensi pasien untuk memastikan intervensi keperawatan yang efektif dan aman.

PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome)

Format sistematis dalam merumuskan pertanyaan klinis, mencakup populasi pasien (Patient), intervensi yang akan diterapkan (Intervention), intervensi pembandingan (Comparison), dan hasil yang diharapkan (Outcome).

Penelitian Terbaik

Bukti ilmiah yang diperoleh dari penelitian yang metodologinya kuat, valid, reliabel, relevan, dan teruji secara ilmiah serta relevan dengan praktik klinis.

Implementasi EBP

Proses penerapan hasil penelitian ilmiah terbaik ke dalam praktik keperawatan sehari-hari, mencakup langkah pencarian bukti, evaluasi kritis, integrasi hasil penelitian, hingga evaluasi efektivitas intervensi.

EBP Champions

Individu atau tim khusus di institusi pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penerapan EBP secara berkelanjutan di lingkungan kerja.

Interprofesionalisme

Pendekatan kerja sama aktif dan integratif antar berbagai profesi kesehatan (seperti perawat, dokter, ahli gizi, apoteker, fisioterapis, dan psikolog) untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal bagi pasien.

Kolaborasi Interprofesional

Interaksi dinamis dan terkoordinasi antara tenaga kesehatan lintas profesi untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana perawatan yang terpadu dan holistik bagi pasien.

Jembatan Komunikasi

Peran perawat sebagai penghubung yang efektif antara pasien dengan profesi kesehatan lainnya, memastikan semua aspek kebutuhan pasien terpenuhi secara menyeluruh melalui komunikasi yang terbuka dan jelas.

Integrasi Pemikiran

Proses menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif berbagai profesi dalam tim interprofesional guna menentukan intervensi yang paling tepat dan efektif bagi pasien.

Pendekatan Holistik

Filosofi perawatan yang memandang pasien secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga perawatan tidak hanya terfokus pada penyakit tetapi juga keseluruhan kebutuhan pasien.

Hubungan Terapeutik

Interaksi yang dibangun oleh perawat dengan pasien secara empatik, suportif, penuh perhatian, dan penghormatan guna mendukung kesembuhan pasien secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual.

Pendampingan Psikologis

Intervensi perawat yang bertujuan memberikan dukungan emosional kepada pasien untuk mengatasi kecemasan, stres, depresi, atau tekanan psikologis lainnya yang timbul akibat kondisi kesehatan yang dialami.

Pencegahan Penyakit

Tindakan proaktif yang dilakukan perawat untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit melalui edukasi, screening, imunisasi, dan modifikasi gaya hidup sehat di masyarakat.

Promosi Kesehatan

Aktivitas edukasi dan advokasi yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat dan mendorong perubahan perilaku secara aktif untuk meningkatkan status kesehatan secara keseluruhan.

Advokasi Kesehatan

Peran perawat dalam membantu masyarakat atau individu mengatasi hambatan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan serta mendukung kebijakan publik yang menciptakan lingkungan sehat.

I. Daftar Pustaka

- Ahmadinia, H., & Eriksson-Backa, K. (2020). E-health services and devices: Availability, merits, and barriers with some examples in Finland. *Finnish Journal of eHealth and eWelfare*, 12(2), 64-77. <https://doi.org/10.23996/fjhw.94116>
- Albahri, A. S., Hamid, R. A., Albahri, O. S., & Zaidan, A. A. (2021). Role of biological data mining and artificial intelligence in healthcare decision-making. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 12(6), 6097-6115. <https://doi.org/10.1007/s12652-020-02341-z>
- Chen, M., Tan, X., Padman, R., & Patel, B. (2021). Understanding healthcare provider preferences for wearable devices. *Journal of Biomedical Informatics*, 120, 103839. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2021.103839>
- Dang, D., & Dearholt, S. L. (2021). *Johns Hopkins evidence-based practice for nurses and healthcare professionals: Model and guidelines (4th ed.)*. Sigma Theta Tau International.
- Delaney, L. J. (2018). Patient-centered care as an approach to improving health care in Australia. *Collegian*, 25(1), 119-123. <https://doi.org/10.1016/j.colegn.2017.04.004>
- Gajarawala, S. N., & Pelkowski, J. N. (2021). Telehealth benefits and barriers. *The Journal for Nurse Practitioners*, 17(2), 218-221. <https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2020.09.013>
- Hastuti, L., & Nuryati, S. (2022). Implementasi kolaborasi interprofesional dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. *Jurnal Keperawatan*, 14(1), 10-19. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v14i1.1695>
- Inan, O. T., Baran Pouyan, M., Javaid, A. Q., Dowling, S., Etemadi, M., Dorier, A., & Clifton, L. (2020). Novel wearable technology for monitoring patient health status. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, 13, 212-225. <https://doi.org/10.1109/rbme.2019.2936138>
- Mackey, A., & Bassendowski, S. (2020). The history of evidence-based practice in nursing education and practice. *Journal of Professional Nursing*, 36(1), 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2019.09.001>

- Rouleau, G., Gagnon, M. P., & Côté, J. (2017). Impacts of information and communication technologies on nursing care: An overview of systematic reviews. *Systematic Reviews*, 6(1), 75. <https://doi.org/10.1186/s13643-017-0456-2>
- Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2021). *Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Stimpfel, A. W., & Dickson, V. V. (2021). Working across boundaries: Interprofessional collaboration among healthcare workers. *Journal of Nursing Management*, 29(3), 450-457. <https://doi.org/10.1111/jonm.13193>
- World Health Organization (WHO). (2018). *WHO guidelines on digital interventions for health system strengthening*. WHO Press.
- Zahroh, R. I., & Sutanto, Y. S. (2020). Pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan pasien kronis. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(2), 143-149. <https://doi.org/10.7454/jki.v23i2.1013>

BAB 4

SEJARAH KEPERAWATAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, serta merefleksikan sejarah perkembangan keperawatan sebagai dasar dalam pembentukan identitas profesional dan peningkatan kualitas praktik keperawatan secara holistik.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan profesi keperawatan dari masa pra-modern hingga masa kontemporer secara kritis dan analitis sebagai dasar identitas profesi dan praktik keperawatan modern.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan sejarah perkembangan keperawatan pada masa pra-modern.
- Menganalisis kontribusi Florence Nightingale dalam pengembangan profesi keperawatan.
- Mengidentifikasi perkembangan keperawatan di Indonesia.
- Menjelaskan tantangan dan perkembangan keperawatan modern.

Pendahuluan

Keperawatan merupakan profesi yang telah mengalami transformasi signifikan sejak zaman dahulu hingga menjadi sebuah disiplin ilmu dan praktik profesional yang dikenal saat ini. Sejarah keperawatan mencerminkan perjalanan yang tidak hanya melibatkan aspek pelayanan kesehatan semata, melainkan juga melibatkan perjuangan, perkembangan pendidikan, dan inovasi dalam sistem kesehatan global. Pemahaman mengenai sejarah keperawatan menjadi dasar penting untuk memahami nilai-nilai profesionalisme, dedikasi, serta perkembangan peran perawat dalam memberikan asuhan yang holistik dan berkualitas kepada individu, keluarga, dan masyarakat.

A. Sejarah Perkembangan Keperawatan pada Masa Pra-Modern

Sejarah perkembangan keperawatan pada masa pra-modern memiliki akar yang sangat panjang, dimulai jauh sebelum adanya sistem perawatan kesehatan modern yang kita kenal saat ini. Pada periode ini, praktik keperawatan muncul di berbagai belahan dunia dengan pendekatan yang unik, dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan sosial yang berkembang pada waktu tersebut. Praktik ini umumnya didominasi oleh perempuan yang menjalankan tugas-tugas domestik serta religius, yang mencerminkan bagaimana perawatan kesehatan pada masa itu sangat erat kaitannya dengan kewajiban sosial dan spiritual masyarakat.

Di Mesir Kuno, misalnya, praktik keperawatan sudah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat. Para perawat menjalankan tugas mereka di kuil-kuil sebagai bagian dari pengabdian kepada para dewa. Praktik ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesembuhan datang dari kekuatan supranatural, sehingga peran perawat juga meliputi aspek spiritual, seperti ritual keagamaan dan doa-doa khusus yang bertujuan untuk mendapatkan kesembuhan. Para perawat di masa Mesir Kuno tidak hanya merawat secara fisik, tetapi juga bertugas dalam memberikan kenyamanan spiritual kepada pasien.

Selanjutnya, peran keperawatan di Yunani kuno juga memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan keperawatan pra-modern. Di masa ini, terutama sejak zaman Hippokrates, keperawatan mulai mengintegrasikan pemahaman filosofis dan ilmiah dasar tentang tubuh manusia dan penyakit. Meski demikian, perawat dalam konteks Yunani kuno umumnya masih merupakan anggota keluarga yang bertanggung jawab untuk merawat pasien di rumah. Tugas mereka meliputi memberikan perawatan dasar, seperti memberikan makanan, menjaga kebersihan tubuh pasien, serta mendampingi pasien dalam proses penyembuhan secara holistik. Dalam budaya Yunani kuno, perawatan juga dipandang sebagai wujud dari kasih sayang dan perhatian antar anggota keluarga, menegaskan bahwa praktik ini erat kaitannya dengan kehidupan sosial.

Dalam budaya Romawi kuno, praktik keperawatan mendapatkan perhatian khusus dengan adanya sistem yang lebih terorganisasi. Bangsa Romawi dikenal dengan sistem kesehatannya yang maju melalui pembangunan rumah sakit sederhana yang dikenal sebagai "valetudinarium", tempat dimana perawat memiliki tugas merawat tentara yang terluka atau sakit. Perawatan pada masa Romawi kuno menampilkan aspek organisasi yang lebih jelas dibandingkan masa-masa

sebelumnya, di mana peran perawat mulai dikenal secara lebih formal dalam struktur pelayanan kesehatan. Meski demikian, pendekatan terhadap perawatan pasien masih relatif sederhana, dengan penekanan kuat pada kebersihan, nutrisi, dan istirahat yang cukup sebagai metode penyembuhan utama.

Sementara itu, di Cina kuno, praktik keperawatan juga berkembang dengan pendekatan yang berbeda namun tetap terintegrasi erat dengan prinsip-prinsip filsafat tradisional seperti Taoisme dan Konfusianisme. Dalam budaya Cina kuno, keperawatan sering dikaitkan dengan konsep keseimbangan energi tubuh yang dikenal sebagai qi. Praktik keperawatan tidak hanya berupa tindakan medis sederhana, tetapi juga mencakup terapi tradisional seperti akupunktur, penggunaan herbal, serta praktik-praktik spiritual yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa pasien. Perawat dalam budaya Cina kuno juga bertugas memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, menandai awal mula munculnya peran perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan masyarakat.

Di berbagai budaya ini, peran perempuan sangat dominan dalam praktik keperawatan, karena tugas ini dianggap sebagai bagian dari kewajiban domestik dan spiritual yang harus dipenuhi oleh wanita dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik keperawatan pada masa pra-modern lebih menitikberatkan aspek spiritualitas, kasih sayang, dan hubungan interpersonal dibandingkan dengan aspek klinis dan teknis. Metode yang digunakan masih sederhana dan berbasis pengalaman empiris yang diwariskan secara turun temurun.

Secara keseluruhan, masa pra-modern dalam sejarah keperawatan menunjukkan bahwa perawatan kesehatan pada waktu itu lebih menekankan pada aspek sosial, spiritual, dan budaya, dengan pendekatan yang cenderung holistik dan sederhana. Sejarah ini menjadi pondasi penting bagi perkembangan keperawatan modern di kemudian hari, yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tetap dipegang teguh dalam profesi keperawatan saat ini.

B. Kontribusi Florence Nightingale dalam Pengembangan Profesi Keperawatan

Florence Nightingale (1820-1910) merupakan tokoh utama dalam sejarah keperawatan modern, yang memberikan kontribusi luar biasa dalam mentransformasi keperawatan dari sekadar aktivitas domestik dan sukarela menjadi suatu profesi yang terstruktur, dihormati, dan didasarkan pada prinsip ilmiah. Nightingale, yang dijuluki sebagai "The Lady with the Lamp" berkat jasanya merawat

tentara Inggris selama Perang Krimea, tidak hanya dikenal karena kepeduliannya terhadap pasien, tetapi juga karena pendekatan sistematisnya terhadap perawatan pasien, yang melibatkan aspek kebersihan, dokumentasi klinis, dan pendidikan formal yang berkelanjutan.

Salah satu kontribusi terbesar Nightingale adalah pengenalan prinsip-prinsip sanitasi dalam perawatan pasien. Sebelum era Nightingale, banyak rumah sakit dan tempat perawatan tidak memahami pentingnya kebersihan lingkungan dalam proses penyembuhan. Kondisi rumah sakit pada masa itu sangat buruk, dengan lingkungan yang kotor, minim ventilasi, dan banyak terjadi infeksi silang. Melalui pengamatan dan analisis yang cermat selama Perang Krimea, Nightingale menyadari bahwa banyak kematian tentara bukan disebabkan oleh luka perang itu sendiri, tetapi oleh infeksi dan kondisi sanitasi yang buruk di rumah sakit. Ia kemudian menekankan pentingnya praktik-praktik higienis, seperti mencuci tangan, membersihkan ruangan secara teratur, menyediakan ventilasi udara yang cukup, dan memastikan pasien mendapatkan nutrisi yang baik. Perubahan sederhana ini ternyata mampu menurunkan angka kematian secara signifikan, suatu pencapaian yang kemudian memperkuat argumennya bahwa lingkungan fisik berperan penting dalam proses penyembuhan.

Selain sanitasi, Nightingale juga sangat menekankan pentingnya dokumentasi klinis yang akurat dan sistematis dalam praktik keperawatan. Ia merupakan pelopor dalam menggunakan statistik medis untuk membuktikan hubungan antara kebersihan lingkungan dengan tingkat kesembuhan pasien. Dengan mengumpulkan data dan membuat catatan pasien yang teratur, Nightingale dapat mengidentifikasi pola penyakit serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesembuhan pasien. Pendekatan ini tidak hanya membantu perbaikan langsung dalam pelayanan kesehatan pada masa itu, tetapi juga menjadi fondasi dalam praktik keperawatan berbasis bukti (evidence-based nursing) yang berkembang hingga saat ini. Dengan demikian, Nightingale bukan hanya praktisi, tetapi juga ilmuwan dan peneliti kesehatan yang menerapkan analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam keperawatan.

Kontribusi lainnya yang sangat penting dari Florence Nightingale adalah pengembangan sistem pendidikan formal bagi perawat. Sebelum masa Nightingale, sebagian besar perawat tidak menerima pelatihan formal dan hanya menjalankan tugas berdasarkan pengalaman yang terbatas atau intuisi pribadi. Menyadari pentingnya pendidikan formal yang terstruktur dan berstandar tinggi, Nightingale mendirikan sekolah keperawatan pertama yang profesional di dunia, yaitu

Nightingale Training School di Rumah Sakit St. Thomas, London, pada tahun 1860. Sekolah ini kemudian menjadi model bagi pendidikan keperawatan profesional di berbagai belahan dunia. Kurikulum yang dikembangkan oleh Nightingale mencakup tidak hanya keterampilan praktis, tetapi juga pengetahuan teori dasar tentang anatomi, fisiologi, prinsip kebersihan, manajemen pasien, dan etika profesional. Ini menjadi langkah revolusioner yang menjadikan keperawatan sebagai profesi yang dihormati, berbasis ilmu pengetahuan, dan dilaksanakan oleh individu yang memiliki kompetensi serta tanggung jawab profesional.

Lebih lanjut, pendekatan Nightingale terhadap profesi keperawatan tidak hanya berorientasi teknis, tetapi juga berorientasi pada nilai moral dan etika tinggi. Ia menanamkan prinsip-prinsip dasar seperti rasa kasih sayang, empati, integritas, disiplin, dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Menurutnya, keperawatan tidak sekadar merawat tubuh fisik, melainkan juga melibatkan perhatian terhadap aspek psikologis, emosional, dan spiritual pasien. Nightingale menegaskan bahwa seorang perawat harus memiliki karakter yang kuat dan moralitas yang tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien.

Dengan seluruh kontribusinya tersebut, Florence Nightingale berhasil mengangkat martabat keperawatan sebagai suatu profesi yang diakui, dihormati, dan memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan global. Konsep-konsep yang diperkenalkannya terus hidup dalam praktik keperawatan modern, menginspirasi jutaan perawat di seluruh dunia dalam menjalankan profesinya dengan standar etika dan profesionalisme tinggi. Legacy Nightingale yang abadi inilah yang membuatnya terus dikenang sebagai ibu keperawatan modern.

C. Perkembangan Keperawatan di Indonesia

Perkembangan keperawatan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada periode awal kolonialisasi, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat lokal sebagian besar terdiri dari tenaga pribumi yang dilatih secara informal. Mereka biasanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar melalui proses magang atau pengalaman langsung dalam pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, keterampilan yang diperoleh melalui metode ini sangat terbatas dan belum memiliki standar yang jelas, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga belum konsisten dan merata.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih profesional dan terorganisir, pemerintah kolonial Belanda mulai mendirikan lembaga pendidikan formal keperawatan yang pertama di Indonesia. Lembaga pendidikan keperawatan formal pertama yang didirikan adalah Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ) yang berlokasi di Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta. Sekolah ini berdiri pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1906, sebagai institusi pendidikan yang secara khusus bertujuan untuk mendidik perawat profesional dengan sistem pendidikan berbasis kurikulum yang terstruktur. CBZ menjadi tonggak penting dalam sejarah keperawatan di Indonesia karena menjadi cikal bakal munculnya pendidikan keperawatan modern di tanah air.

Pada masa kolonial, pendidikan keperawatan memang masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan kolonial, terutama untuk melayani pejabat dan keluarga kolonial Belanda. Perawat yang dididik pada masa tersebut diharapkan memiliki keterampilan dasar seperti perawatan kebersihan, pemberian makanan, perawatan luka sederhana, serta pemberian kenyamanan emosional kepada pasien. Seiring waktu, beberapa rumah sakit lain yang tersebar di kota-kota besar juga mulai mendirikan pendidikan keperawatan serupa, seperti rumah sakit di Surabaya, Semarang, dan Medan. Meski demikian, akses ke pendidikan ini masih sangat terbatas bagi penduduk pribumi, terutama kaum perempuan pribumi yang baru secara bertahap mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan formal.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dunia keperawatan di tanah air mengalami perubahan signifikan yang lebih terstruktur dan berorientasi nasional. Indonesia mulai membangun institusi pendidikan keperawatan dalam jumlah yang lebih besar, baik di tingkat dasar maupun menengah. Era setelah kemerdekaan ini menandai fase penting dalam pengembangan keperawatan karena adanya dorongan kuat dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan bangsa di bidang kesehatan.

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan keperawatan di Indonesia setelah kemerdekaan adalah didirikannya Akademi Keperawatan dan institusi pendidikan keperawatan tingkat tinggi lainnya di berbagai daerah. Institusi-institusi ini bertujuan untuk mencetak tenaga perawat profesional yang memiliki kemampuan klinis lebih tinggi, menguasai teori keperawatan secara ilmiah, dan mampu memberikan pelayanan berbasis bukti (*evidence-based practice*). Pendidikan keperawatan di Indonesia kemudian mengalami perkembangan yang semakin pesat, ditandai dengan munculnya berbagai jenjang pendidikan mulai dari

pendidikan vokasional (D-III), pendidikan profesi (Ners), hingga pendidikan lanjut seperti magister dan doktor keperawatan.

Selain pengembangan institusi pendidikan, perkembangan keperawatan di Indonesia juga ditandai dengan terbentuknya organisasi profesi yang kuat, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Maret 1974, dan memiliki peran sangat strategis dalam mengembangkan profesi keperawatan melalui berbagai kegiatan advokasi, pelatihan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. PPNI secara aktif mendorong adanya regulasi yang jelas untuk profesi perawat, sehingga perawat dapat memiliki payung hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya. Salah satu bentuk konkret perjuangan tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang memberikan pengakuan resmi terhadap profesi perawat di Indonesia dan menegaskan peran serta tanggung jawab perawat secara hukum.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan keperawatan di Indonesia juga semakin kompleks dan dinamis, seiring dengan meningkatnya tantangan kesehatan masyarakat yang semakin bervariasi. Profesi perawat tidak hanya terbatas pada peran klinis, tetapi juga berkembang ke ranah promotif, preventif, rehabilitatif, edukatif, serta penelitian. Profesi ini pun semakin dihargai dan memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, baik di rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), maupun dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, perkembangan keperawatan di Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini menunjukkan suatu transformasi besar yang signifikan. Dari yang awalnya hanya berupa pendidikan informal yang sederhana, berkembang menjadi profesi yang didukung oleh pendidikan formal yang berkualitas, regulasi yang jelas, serta organisasi profesi yang kuat dan solid. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya posisi keperawatan sebagai salah satu profesi vital dalam mendukung sistem kesehatan nasional, serta peran pentingnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

D. Tantangan dan Perkembangan Keperawatan Modern

Dalam era modern saat ini, profesi keperawatan menghadapi berbagai tantangan kompleks yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu tantangan utama adalah tuntutan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Masyarakat global kini lebih kritis dan terinformasi dengan baik, sehingga

mereka memiliki harapan tinggi terhadap profesionalisme perawat, kualitas pelayanan klinis, serta efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, serta kompleksitas peran perawat menjadi tantangan signifikan yang harus dikelola secara efektif oleh institusi maupun individu dalam profesi ini.

Perkembangan teknologi kesehatan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi dunia keperawatan modern. Saat ini, teknologi informasi telah secara signifikan mengubah lanskap pelayanan kesehatan, termasuk keperawatan. Sistem rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) dan telehealth menjadi dua contoh utama penerapan teknologi yang sangat berpengaruh dalam praktik keperawatan. Penggunaan EHR membantu perawat dalam mendokumentasikan data pasien secara cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kontinuitas perawatan. Namun, penerapan teknologi ini juga menuntut perawat memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, adaptasi yang cepat terhadap sistem baru, serta memastikan keamanan data pasien yang bersifat rahasia.

Selain EHR, telehealth telah menjadi komponen penting dalam pelayanan keperawatan modern, terutama dalam menjembatani kesenjangan geografis dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Telehealth memungkinkan perawat melakukan konsultasi kesehatan, pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh, edukasi pasien, serta manajemen penyakit kronis secara efektif tanpa memerlukan tatap muka langsung. Hal ini membuka peluang besar dalam memperluas cakupan pelayanan keperawatan, tetapi juga mengharuskan perawat terus meningkatkan keterampilan komunikasi digital, manajemen teknologi informasi, serta pemahaman etika dalam penggunaan teknologi tersebut.

Selain tantangan teknologi, perawat modern juga menghadapi tantangan berupa semakin kompleksnya peran dan fungsi mereka dalam sistem kesehatan. Perawat kini tidak hanya terlibat dalam perawatan klinis secara langsung, tetapi juga semakin aktif dalam peran yang lebih luas seperti advokasi kesehatan global, penelitian klinis, dan spesialisasi keperawatan yang lebih mendalam. Peran advokasi ini mencakup upaya memperjuangkan kebijakan kesehatan yang lebih adil dan berpihak kepada pasien, mengurangi disparitas kesehatan global, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu kesehatan penting. Perawat modern dituntut memiliki pengetahuan luas tentang kebijakan kesehatan publik, serta keterampilan komunikasi dan negosiasi yang efektif dalam memperjuangkan hak pasien dan komunitas.

Perkembangan spesialisasi keperawatan merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin spesifik dan kompleks. Spesialisasi keperawatan seperti keperawatan kritis (critical care nursing), keperawatan anak

(pediatric nursing), keperawatan gerontologi, keperawatan komunitas, keperawatan jiwa, serta keperawatan onkologi berkembang pesat di banyak negara. Spesialisasi ini menuntut pendidikan lanjutan, pelatihan khusus, dan sertifikasi profesional agar perawat mampu memberikan asuhan keperawatan terbaik sesuai dengan standar yang semakin tinggi. Di samping meningkatkan kualitas pelayanan, spesialisasi juga menciptakan tantangan baru berupa kebutuhan akan tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan khusus yang mampu mendukung pendidikan lanjutan tersebut.

Peran perawat dalam penelitian klinis juga mengalami perkembangan signifikan. Saat ini, banyak perawat terlibat secara aktif dalam berbagai riset klinis yang bertujuan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan berbasis bukti (evidence-based nursing). Partisipasi perawat dalam penelitian klinis sangat penting dalam menemukan intervensi yang efektif, memperbaharui praktik klinis, serta memastikan bahwa pelayanan keperawatan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Tantangan dalam hal ini adalah perawat perlu mengembangkan kemampuan analisis data, metodologi penelitian, serta kemampuan untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik klinis sehari-hari secara efektif.

Di tingkat global, perawat modern juga menghadapi tantangan dalam bentuk perubahan demografi populasi, seperti meningkatnya populasi lansia, peningkatan prevalensi penyakit kronis, dan tantangan kesehatan global seperti pandemi COVID-19 yang menuntut fleksibilitas, kesiapan, serta keterampilan adaptasi tinggi dari perawat. Situasi ini menegaskan perlunya sistem pendidikan keperawatan yang dinamis dan adaptif, pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas profesi yang kuat.

Secara keseluruhan, tantangan keperawatan modern sangatlah kompleks, tetapi juga membuka peluang besar bagi perawat untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Perkembangan teknologi informasi, spesialisasi yang semakin maju, peran aktif dalam penelitian klinis, serta advokasi kesehatan global adalah beberapa aspek kunci yang menandai era baru dalam profesi keperawatan. Oleh karena itu, perawat modern diharapkan terus meningkatkan kompetensi, keterampilan teknologi, serta kemampuan adaptasi agar dapat menghadapi tantangan tersebut secara efektif, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara global.

E. Latihan Soal

Soal 1

Seorang pasien di rumah sakit mengeluh tentang lingkungan yang kotor dan bau tidak sedap di ruang perawatan, menyebabkan pasien merasa tidak nyaman dan khawatir akan risiko infeksi. Perawat memahami pentingnya kebersihan lingkungan sesuai prinsip Florence Nightingale. Apa tindakan utama yang seharusnya dilakukan perawat dalam situasi ini?

- A. Menjelaskan kepada pasien bahwa kebersihan bukan tanggung jawabnya.
- B. Menghubungi keluarga pasien untuk membersihkan ruangan.
- C. Melakukan pembersihan lingkungan secara menyeluruh dan memastikan ventilasi udara baik.
- D. Memberikan masker kepada pasien agar tidak mencium bau.
- E. Mengabaikan keluhan pasien karena bukan keluhan medis langsung.

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Florence Nightingale menekankan pentingnya sanitasi lingkungan dalam proses penyembuhan. Tindakan terbaik adalah melakukan pembersihan menyeluruh dan memastikan ventilasi udara baik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pemulihan pasien.

Soal 2

Seorang perawat sedang bertugas di daerah terpencil yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan. Ia ingin menerapkan teknologi modern untuk memantau pasien dengan penyakit kronis secara jarak jauh. Teknologi apakah yang paling sesuai digunakan dalam situasi ini?

- A. Electronic Health Records (EHR)
- B. Telehealth
- C. Akupunktur jarak jauh
- D. Herbal online
- E. Pendidikan berbasis seminar tatap muka

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Telehealth adalah teknologi yang memungkinkan konsultasi dan pemantauan kesehatan secara jarak jauh. Ini sangat efektif digunakan di daerah terpencil untuk memantau kondisi pasien secara kontinu tanpa harus bertatap muka langsung.

Soal 3

Seorang perawat baru bertugas di sebuah rumah sakit yang menerapkan sistem rekam medis elektronik (EHR). Namun perawat tersebut kesulitan dalam

menggunakan sistem tersebut sehingga pencatatan menjadi lambat. Apa solusi terbaik yang harus dilakukan oleh perawat tersebut?

- A. Menggunakan catatan manual agar lebih cepat.
- B. Meminta bantuan rekannya setiap kali akan melakukan pencatatan.
- C. Mengikuti pelatihan tambahan atau meminta panduan dari bagian IT rumah sakit.
- D. Tidak mencatat untuk sementara waktu hingga terbiasa.
- E. Menggunakan catatan rekam medis pasien yang lama.

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Perawat harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru untuk mendukung efektivitas pelayanan. Mengikuti pelatihan tambahan atau meminta bantuan dari bagian IT akan meningkatkan kemampuan perawat dalam mengelola EHR dengan efisien dan akurat.

Soal 4

Pada masa pra-modern, keperawatan sering dikaitkan erat dengan spiritualitas dan tugas religius. Seorang perawat modern ingin mengintegrasikan konsep perawatan holistik yang dipraktikkan pada masa tersebut ke dalam praktiknya saat ini. Apa bentuk integrasi yang paling tepat untuk dilakukan perawat?

- A. Menyerahkan semua perawatan pasien kepada pemuka agama.
- B. Mengabaikan aspek fisik pasien dan hanya fokus pada spiritual.
- C. Memberikan perhatian terhadap aspek spiritual, emosional, dan fisik secara bersamaan.
- D. Melarang pasien melakukan ritual keagamaan selama perawatan.
- E. Menyuruh keluarga pasien menjalankan perawatan spiritual sendiri.

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Konsep keperawatan holistik mencakup perhatian terhadap fisik, emosional, dan spiritual secara bersama-sama. Integrasi yang tepat adalah memberikan perhatian yang seimbang terhadap semua aspek tersebut demi mendukung pemulihan pasien secara menyeluruh.

Soal 5

Seorang perawat baru di sebuah rumah sakit di Indonesia bertanya tentang sejarah pendidikan keperawatan formal pertama di Indonesia. Perawat senior menjelaskan bahwa pendidikan keperawatan formal pertama di Indonesia adalah di:

- A. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
- B. Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ) di Batavia
- C. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta
- D. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung

E. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Pendidikan formal keperawatan pertama di Indonesia adalah Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ) di Batavia (sekarang Jakarta), didirikan pada masa kolonial Belanda tahun 1906. Institusi ini merupakan tonggak awal pendidikan formal keperawatan di Indonesia.

F. Rangkuman Materi

Perkembangan keperawatan dari masa pra-modern hingga era modern saat ini mencerminkan perjalanan panjang profesi ini dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Pada masa pra-modern, praktik keperawatan lebih dominan dilaksanakan oleh perempuan sebagai tugas domestik dan spiritual, yang mengutamakan pendekatan holistik dengan memadukan aspek sosial, budaya, serta keagamaan. Berbagai budaya kuno, seperti Mesir, Yunani, Romawi, dan Cina memiliki praktik unik yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan keperawatan modern.

Florence Nightingale menjadi figur sentral dalam transisi keperawatan menuju profesi yang lebih terstruktur dan berbasis ilmiah. Kontribusinya mencakup penekanan pada sanitasi, dokumentasi klinis, dan pendidikan formal, serta pengintegrasian nilai moral dan etika dalam praktik keperawatan. Pendekatan ini menjadi dasar bagi pengembangan keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice) dan sistem pendidikan keperawatan profesional yang berkembang secara global.

Di Indonesia, sejarah keperawatan dimulai sejak masa kolonial Belanda melalui pendirian pendidikan formal pertama di Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ) di Batavia. Setelah kemerdekaan, perkembangan keperawatan semakin pesat dengan munculnya berbagai institusi pendidikan tinggi, pembentukan organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), serta adanya regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Hal ini menandai pergeseran besar dari pendidikan informal menuju sistem pendidikan formal yang berkualitas, menegaskan posisi strategis perawat dalam sistem kesehatan nasional.

Saat ini, profesi keperawatan menghadapi tantangan kompleks, termasuk perkembangan teknologi kesehatan, tuntutan pelayanan berkualitas tinggi, dan perluasan peran perawat di berbagai bidang seperti spesialisasi klinis, penelitian, dan advokasi global. Perawat modern dituntut mampu beradaptasi cepat terhadap kemajuan teknologi seperti rekam medis elektronik (EHR) dan telehealth, sekaligus aktif dalam penelitian dan kolaborasi lintas profesi. Oleh karena itu, perawat harus terus meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan adaptasi agar

mampu memberikan kontribusi optimal terhadap kualitas kesehatan masyarakat secara global.

G. Glosarium

Akupunktur

Metode pengobatan tradisional Cina yang menggunakan jarum tipis yang ditusukkan ke titik-titik tertentu di tubuh untuk menyeimbangkan energi tubuh (qi).

Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ):

Institusi pendidikan formal keperawatan pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1906 di Batavia (Jakarta), sebagai tonggak penting dalam sejarah pendidikan keperawatan di Indonesia.

Electronic Health Records (EHR):

Sistem dokumentasi digital yang mencatat data medis pasien secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan.

Evidence-Based Nursing:

Praktik keperawatan yang menggunakan bukti ilmiah terbaik dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perawatan pasien.

Florence Nightingale (1820-1910):

Tokoh penting dalam sejarah keperawatan modern, dikenal karena kontribusinya dalam memperkenalkan prinsip sanitasi, dokumentasi klinis, dan pendidikan formal bagi perawat, sehingga dikenal sebagai ibu keperawatan modern.

Holistik:

Pendekatan perawatan yang melihat pasien secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual dalam proses penyembuhan.

Konfusianisme:

Sistem filsafat tradisional Cina yang menekankan etika sosial, harmoni, dan hubungan interpersonal yang digunakan sebagai dasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik keperawatan tradisional di Cina kuno.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI):

Organisasi profesi perawat di Indonesia yang berdiri pada tahun 1974 dan berperan penting dalam pengembangan, advokasi, serta regulasi profesi keperawatan secara nasional.

Qi:

Konsep dalam pengobatan tradisional Cina yang menggambarkan energi atau kekuatan vital yang mengalir dalam tubuh, berperan dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh.

Sanitasi:

Tindakan menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit dan mempercepat proses penyembuhan, yang diperkenalkan oleh Florence Nightingale dalam praktik keperawatan modern.

Spesialisasi Keperawatan:

Bidang khusus dalam keperawatan yang memerlukan pendidikan lanjutan, pelatihan khusus, dan sertifikasi tertentu, seperti keperawatan kritis, anak, gerontologi, komunitas, jiwa, dan onkologi.

Taoisme:

Filsafat tradisional Cina yang menekankan keseimbangan alam dan harmoni dalam kehidupan, berpengaruh pada praktik keperawatan tradisional yang berfokus pada keseimbangan energi tubuh.

Telehealth:

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, seperti konsultasi kesehatan, edukasi pasien, serta pemantauan kondisi pasien secara virtual.

Valetudinarium:

Rumah sakit sederhana pada zaman Romawi kuno yang digunakan untuk merawat tentara yang terluka atau sakit, menandai perkembangan awal sistem perawatan kesehatan yang lebih terorganisasi.

Zaman Hippokrates:

Periode di Yunani kuno ketika Hippokrates memperkenalkan pemikiran medis yang lebih ilmiah dan filosofis tentang penyakit dan tubuh manusia, menjadi dasar pendekatan perawatan kesehatan secara lebih rasional dan empiris.

H. Daftar Pustaka

- Cherry, B., & Jacob, S. R. (2019). *Contemporary nursing: Issues, trends, & management* (8th ed.). Elsevier Health Sciences.
- D'Antonio, P., Connolly, C., Wall, B. M., Whelan, J. C., & Fairman, J. A. (2019). *Histories of nursing practice*. University of Pennsylvania Press.
- Dossey, B. M. (2019). Florence Nightingale: Mystic, visionary, healer. In B. M. Dossey, L. Keegan, & C. Barrere (Eds.), *Holistic nursing: A handbook for practice* (8th ed., pp. 42-59). Jones & Bartlett Learning.
- Fadilah, N., & Pratiwi, I. D. (2021). Sejarah perkembangan pendidikan keperawatan di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 6(2), 182-191. <https://doi.org/10.30651/jkm.v6i2.7789>
- Hidayat, A. A. A. (2019). *Pengantar konsep dasar keperawatan* (3rd ed.). Salemba Medika.
- Kozier, B., Erb, G., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2020). *Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (11th ed.). Pearson Education.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2020). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (10th ed.). Wolters Kluwer.
- Nursalam, N. (2020). *Metodologi penelitian ilmu keperawatan: Pendekatan praktis* (5th ed.). Salemba Medika.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Smith, M. C., & Parker, M. E. (2019). *Nursing theories and nursing practice* (5th ed.). F.A. Davis Company.
- Wahyuni, E. D., & Fitriani, E. (2021). Tantangan profesi perawat di era revolusi industri 4.0. *Journal of Holistic Nursing Science*, 8(1), 35-44. <https://doi.org/10.31603/nursing.v8i1.3940>
- World Health Organization (WHO). (2020). *State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279>

BAB 5

TREN DAN ISSUE

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan pengetahuan mengenai tren dan isu terkini dalam keperawatan untuk meningkatkan kualitas praktik keperawatan berbasis bukti dalam menghadapi tantangan profesional.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan, serta mengintegrasikan tren dan isu terbaru dalam keperawatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, efektif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan tren utama dalam keperawatan modern serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.
- Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu utama dalam praktik keperawatan kontemporer.
- Mengaplikasikan strategi inovatif untuk mengatasi isu-isu yang muncul dalam praktik keperawatan.
- Mengevaluasi peran advokasi perawat dalam merespon tren dan isu dalam kebijakan kesehatan nasional dan global.

Pendahuluan

Perkembangan keperawatan senantiasa dinamis, dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial dan demografi. Tren dan isu dalam keperawatan mencerminkan tantangan sekaligus peluang baru bagi praktik keperawatan modern. Para perawat dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan ini agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien dan komunitas. Isu-isu seperti meningkatnya prevalensi penyakit kronis,

perkembangan teknologi informasi kesehatan, hingga tantangan etika dalam pelayanan menjadi titik perhatian utama dalam dunia keperawatan saat ini.

Dalam bab ini akan dibahas secara detail mengenai tren-tren terkini serta isu-isu utama yang tengah dihadapi dunia keperawatan, termasuk bagaimana perawat merespons tantangan tersebut melalui peningkatan kompetensi, inovasi praktik, dan advokasi kebijakan kesehatan.

A. Tren Utama dalam Keperawatan Modern

Tren utama dalam keperawatan modern meliputi:

1. Keperawatan Berbasis Teknologi

Dalam era modern, peran teknologi dalam praktik keperawatan telah menjadi esensial, terutama melalui penerapan teknologi informasi kesehatan yang membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan keperawatan. Salah satu teknologi yang menjadi tulang punggung layanan kesehatan modern adalah penggunaan rekam medis elektronik atau Electronic Health Record (EHR). EHR memungkinkan perawat untuk mencatat, menyimpan, serta mengakses data pasien secara real-time dan sistematis. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kesalahan pencatatan, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan klinis.

Selain EHR, telehealth juga telah menjadi tren penting di bidang keperawatan, terutama sejak meningkatnya kebutuhan pelayanan jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Telehealth memungkinkan perawat untuk melakukan konsultasi, pemantauan, edukasi, dan intervensi perawatan kesehatan secara virtual, tanpa batasan geografis. Hal ini khususnya bermanfaat dalam perawatan pasien dengan kondisi kronis yang memerlukan monitoring berkala tanpa harus selalu datang secara fisik ke fasilitas kesehatan.

Perangkat wearable juga semakin banyak digunakan dalam praktik keperawatan modern. Perangkat ini, seperti jam pintar (smartwatch) atau sensor khusus, membantu perawat dalam memonitor kondisi vital pasien secara berkelanjutan seperti denyut jantung, tekanan darah, kadar gula darah, dan aktivitas fisik. Data real-time ini memberikan manfaat signifikan dalam deteksi dini perubahan kondisi pasien serta mendukung intervensi cepat, tepat, dan proaktif.

2. Keperawatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

Tren keperawatan berbasis bukti adalah pendekatan klinis yang secara sistematis menggunakan hasil penelitian terbaik dalam mengambil keputusan dan memberikan intervensi keperawatan. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan setiap tindakan yang dilakukan perawat memiliki dasar ilmiah yang kuat dan telah teruji efektifitasnya. Dengan penerapan keperawatan berbasis bukti, perawat diharapkan tidak lagi sekedar mengikuti tradisi atau kebiasaan

lama yang belum tentu terbukti efektif, tetapi melakukan perawatan berdasarkan hasil penelitian terbaru yang telah divalidasi.

Dalam implementasinya, perawat secara aktif dituntut untuk mampu melakukan telaah kritis terhadap berbagai literatur ilmiah terkini serta mengintegrasikannya dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien. Hal ini mendorong perawat untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik yang terbukti mampu meningkatkan outcome pasien, seperti penurunan komplikasi, peningkatan keselamatan pasien, serta peningkatan kepuasan pasien.

3. Peningkatan Spesialisasi Keperawatan

Seiring berkembangnya kebutuhan layanan kesehatan, spesialisasi di bidang keperawatan juga mengalami perkembangan yang signifikan. Tren ini didorong oleh semakin kompleksnya permasalahan kesehatan, seperti peningkatan penyakit kronis, populasi lanjut usia yang meningkat, serta kebutuhan akan perawatan intensif dan spesifik di berbagai bidang klinis. Salah satu contohnya adalah munculnya perawat spesialis klinis (Clinical Nurse Specialist/CNS) yang berperan dalam mengelola kondisi pasien dengan tingkat kompleksitas tinggi serta melakukan riset klinis dan edukasi lanjutan bagi perawat lainnya.

Perawat anestesi (Certified Registered Nurse Anesthetist/CRNA) juga semakin dibutuhkan untuk mengelola nyeri dan memberikan anestesi yang aman dan efektif dalam berbagai prosedur medis, khususnya di daerah-daerah terpencil atau dengan keterbatasan dokter anestesi. Demikian pula, perawat spesialis gerontologi yang khusus menangani perawatan pasien lanjut usia semakin meningkat kebutuhannya mengingat populasi lansia yang terus bertambah. Spesialisasi ini memungkinkan perawat memiliki kompetensi khusus dalam mengatasi tantangan unik yang dihadapi lansia, seperti penyakit degeneratif, gangguan kognitif, hingga kebutuhan psikososial pasien lanjut usia.

4. Interprofessional Collaboration (IPC)

Interprofessional collaboration (IPC) merupakan pendekatan kerja sama antar berbagai profesi kesehatan yang bertujuan untuk memberikan perawatan holistik yang optimal. Dalam konteks ini, perawat tidak lagi bekerja secara isolasi, tetapi secara aktif berkolaborasi dengan dokter, farmasis, ahli gizi, psikolog, dan profesional kesehatan lainnya dalam tim multidisiplin. Kolaborasi ini sangat penting karena permasalahan kesehatan pasien sering kali kompleks, sehingga

membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dari berbagai sudut pandang keilmuan.

Dalam model IPC, perawat memiliki peran sentral, yakni sebagai koordinator perawatan yang mengintegrasikan berbagai aspek pengobatan, rehabilitasi, edukasi, dan dukungan emosional pasien. Hal ini meningkatkan komunikasi antar anggota tim, meminimalisasi miskomunikasi, dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Dengan IPC, perawat tidak hanya meningkatkan kualitas layanan bagi pasien, tetapi juga memperkuat posisi profesional keperawatan dalam sistem kesehatan modern yang kompleks dan terintegrasi.

B. Isu Utama dalam Keperawatan

Beberapa isu utama yang memerlukan perhatian khusus dalam praktik keperawatan kontemporer adalah:

1. Kekurangan Tenaga Keperawatan

Salah satu tantangan terbesar yang sedang dihadapi dunia keperawatan saat ini adalah kekurangan tenaga keperawatan yang cukup di berbagai negara secara global. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peningkatan jumlah populasi yang lanjut usia, meningkatnya beban penyakit kronis, dan tingginya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang kompleks. Kurangnya jumlah perawat tidak hanya menurunkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga membebani tenaga keperawatan yang ada, sehingga menciptakan siklus kelelahan kerja yang semakin memperparah situasi.

Penyebab kekurangan tenaga keperawatan juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang kurang fokus pada perekrutan dan retensi tenaga keperawatan. Kondisi kerja yang kurang ideal, remunerasi yang tidak sesuai, serta kurangnya penghargaan profesional juga menjadi alasan banyak perawat meninggalkan profesi atau bahkan bermigrasi ke negara-negara lain yang menawarkan kondisi lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis yang mendukung perekrutan tenaga perawat baru, peningkatan kesejahteraan tenaga perawat, serta insentif karir yang memadai guna mengatasi isu ini secara efektif.

2. Beban Kerja Berlebihan (Burnout)

Beban kerja berlebihan atau burnout merupakan isu kritis dalam praktik keperawatan modern yang memerlukan perhatian serius. Beban kerja yang tinggi, jam kerja yang panjang, serta lingkungan kerja yang penuh tekanan secara signifikan meningkatkan risiko stres dan kelelahan emosional pada perawat. Kondisi burnout tidak hanya merugikan perawat secara individual, tetapi juga

berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan kesehatan, menurunkan produktivitas, meningkatkan risiko kesalahan medis, dan bahkan meningkatkan tingkat turnover (keluar masuknya tenaga kerja).

Untuk mengatasi burnout, manajemen kesehatan perlu lebih fokus pada upaya pencegahan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, realistis, dan manusiawi. Hal ini termasuk menyediakan waktu istirahat yang cukup, pelatihan manajemen stres, program dukungan psikologis, dan kebijakan manajemen sumber daya yang lebih baik untuk memastikan keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas tenaga perawat. Di sisi lain, perawat juga perlu diberdayakan melalui edukasi tentang manajemen stres dan keterampilan coping yang efektif agar mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan personal.

3. Tantangan Etika dan Moral

Isu etika dan moral dalam praktik keperawatan semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi kesehatan dan perubahan sosial di masyarakat. Tantangan etika utama meliputi pengambilan keputusan akhir hidup (end-of-life care), di mana perawat sering kali menghadapi dilema etis terkait penghentian atau kelanjutan terapi. Dalam konteks ini, penting bagi perawat untuk memahami secara mendalam tentang hak pasien, konsep martabat manusia, serta batasan legal dan etis dalam mengambil keputusan klinis.

Selain itu, isu informed consent juga semakin menonjol, terutama karena meningkatnya kesadaran hak pasien terhadap informasi dan transparansi prosedur medis. Perawat dituntut memiliki keterampilan komunikasi efektif serta pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip etika klinis agar mampu memberikan edukasi yang memadai kepada pasien, sehingga pasien benar-benar memahami risiko dan manfaat dari setiap tindakan medis yang akan dilakukan.

Perkembangan teknologi seperti rekam medis elektronik juga membawa isu etika baru terkait privasi dan keamanan data pasien. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan informasi, menjaga kerahasiaan data, serta memahami regulasi hukum terkait perlindungan data pasien. Pendidikan etika yang berkelanjutan sangat penting dalam memastikan bahwa perawat mampu menghadapi tantangan-tantangan ini dengan kompeten, profesional, dan bijaksana.

4. Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan

Kesenjangan akses pelayanan kesehatan menjadi isu penting yang berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil, daerah pedesaan, atau komunitas rentan secara sosial ekonomi. Banyak individu yang mengalami hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang optimal karena keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga kesehatan, serta minimnya edukasi kesehatan di daerah tersebut. Dalam situasi ini, perawat memegang peran vital sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, baik dalam aspek preventif, promotif, maupun kuratif.

Perawat dituntut untuk tidak hanya memberikan pelayanan langsung tetapi juga aktif melakukan advokasi bagi peningkatan kebijakan kesehatan yang inklusif dan merata. Selain itu, pendekatan seperti program outreach kesehatan, kunjungan rumah, telehealth, serta intervensi komunitas juga harus diperkuat guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan.

C. Strategi Mengatasi Tren dan Isu dalam Keperawatan

1. Peningkatan Kompetensi Melalui Pendidikan Berkelanjutan

Strategi utama dalam menghadapi tren dan tantangan kontemporer dalam keperawatan adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan melalui pendidikan yang berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan ini bukan hanya menjadi kebutuhan pribadi perawat tetapi juga tuntutan profesional agar mampu memberikan layanan kesehatan terbaik berdasarkan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti pelatihan, lokakarya, seminar, webinar, kursus daring (online course), maupun studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, pendekatan mentoring dan pembinaan profesional juga penting untuk diterapkan di lingkungan kerja. Program ini membantu perawat untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan klinis, serta kompetensi non-teknis seperti keterampilan komunikasi, manajemen stres, kepemimpinan, hingga keterampilan advokasi. Pendidikan ini akan memastikan perawat mampu menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari teknologi informasi, intervensi berbasis bukti, hingga pengelolaan isu etika dan moral dalam praktik keperawatan sehari-hari.

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan berkelanjutan, perawat juga harus didorong untuk aktif mengikuti penelitian klinis atau evidence-based practice, agar mampu menerapkan pengetahuan berbasis bukti secara optimal dalam pelayanan kepada pasien. Dengan cara ini, perawat akan selalu berada dalam posisi yang relevan dan mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia kesehatan.

2. Penerapan Teknologi Secara Bijak

Strategi kedua untuk mengatasi berbagai tren dan isu dalam keperawatan modern adalah penerapan teknologi secara bijak dan terencana. Penggunaan teknologi seperti rekam medis elektronik, telehealth, serta perangkat wearable memang sangat membantu, namun memerlukan pendekatan yang terintegrasi agar tidak menimbulkan masalah baru seperti pelanggaran privasi atau peningkatan beban kerja yang berlebihan bagi perawat.

Pemanfaatan teknologi harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Dalam hal ini, pelatihan tentang penggunaan teknologi kesehatan secara berkala perlu diberikan kepada perawat, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal tanpa merasa terbebani secara berlebihan. Lebih lanjut, penting juga dilakukan evaluasi reguler terhadap teknologi yang diterapkan untuk memastikan bahwa penggunaannya benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, bukan justru menambah beban administratif atau kompleksitas prosedural yang tidak perlu.

Teknologi informasi yang digunakan harus dilengkapi dengan sistem keamanan data yang kuat dan protokol yang jelas, demi menjaga privasi pasien dan etika profesional. Dengan demikian, teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan kesehatan tetapi juga mendukung aspek etis dalam pelayanan keperawatan yang profesional dan bertanggung jawab.

3. Advokasi Kebijakan Kesehatan yang Mendukung Peran Strategis Perawat

Strategi penting lainnya untuk mengatasi tren dan isu dalam keperawatan adalah melalui advokasi kebijakan kesehatan. Perawat harus memainkan peran aktif dalam mengadvokasi kebijakan kesehatan yang memperkuat posisi strategis mereka di dalam komunitas maupun di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan yang perlu didukung meliputi perbaikan kondisi kerja, pengelolaan beban kerja yang manusiawi, kesejahteraan perawat, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan secara merata, terutama bagi daerah terpencil atau populasi rentan.

Advokasi kebijakan kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti organisasi profesi keperawatan, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, serta keterlibatan langsung dalam forum kebijakan di tingkat lokal hingga nasional. Melalui advokasi ini, perawat akan mampu memengaruhi pengambilan keputusan yang strategis demi mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Peran strategis perawat juga harus ditingkatkan melalui keterlibatan aktif dalam tim multidisiplin. Kolaborasi ini memungkinkan perawat memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah kebijakan kesehatan di lingkungan kerja, memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan efektivitas kerja tenaga keperawatan, serta memastikan pasien menerima pelayanan holistik yang optimal.

D. Latihan Soal

Kasus 1 (Keperawatan Berbasis Teknologi)

Anda adalah seorang perawat yang bertugas di klinik kesehatan yang mulai menerapkan telehealth sebagai sarana konsultasi pasien jarak jauh. Ibu Ani (65 tahun) adalah pasien dengan diabetes melitus tipe 2 yang tinggal di daerah terpencil. Dalam menjalankan konsultasi via telehealth, tindakan utama yang harus Anda lakukan adalah:

- A. Memastikan koneksi internet stabil agar komunikasi berjalan efektif
- B. Menyiapkan dokumen fisik riwayat medis untuk dikirim via pos
- C. Mengatur janji temu pasien di klinik secara rutin setiap minggu
- D. Menyarankan pasien agar selalu datang langsung untuk pengobatan
- E. Memberikan edukasi keluarga pasien mengenai pembelian peralatan medis canggih

Kunci Jawaban: A

Rasional:

Koneksi internet stabil merupakan hal penting dalam telehealth, memastikan konsultasi jarak jauh dapat berjalan lancar dan pasien mendapatkan pelayanan yang efektif tanpa perlu datang langsung ke klinik secara rutin.

Kasus 2 (Keperawatan Berbasis Bukti)

Seorang perawat ingin menerapkan prinsip keperawatan berbasis bukti dalam perawatan luka diabetes yang sulit sembuh. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan perawat adalah:

- A. Melanjutkan metode perawatan tradisional yang sudah lama diterapkan
- B. Mengikuti rekomendasi perawatan terbaru berdasarkan jurnal penelitian ilmiah

- C. Menggunakan metode yang paling nyaman bagi perawat secara pribadi
- D. Menerapkan prosedur perawatan yang paling murah dari segi biaya
- E. Menanyakan pasien tentang metode perawatan yang mereka sukai

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Keperawatan berbasis bukti mewajibkan perawat untuk selalu menggunakan hasil penelitian terbaru dan valid sebagai dasar tindakan keperawatan, memastikan intervensi yang diberikan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Kasus 3 (Interprofessional Collaboration - IPC)

Pak Deni (70 tahun) memiliki riwayat hipertensi, diabetes, serta mengalami gangguan nutrisi dan emosional akibat kondisi penyakitnya. Sebagai perawat koordinator perawatan, langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam interprofessional collaboration (IPC) adalah:

- A. Mengatur pertemuan rutin dengan seluruh anggota tim multidisiplin untuk menentukan rencana perawatan
- B. Merujuk pasien ke dokter spesialis diabetes untuk pengobatan utama
- C. Meminta ahli gizi langsung menyiapkan menu makanan pasien tanpa konsultasi
- D. Menginstruksikan farmasis menyiapkan obat tanpa persetujuan dokter
- E. Menjalankan perawatan pasien secara mandiri tanpa melibatkan profesional lain

Kunci Jawaban: A

Rasional:

Perawat dalam IPC berperan sebagai koordinator perawatan yang bertanggung jawab mengintegrasikan masukan dari semua profesional dalam tim multidisiplin untuk menciptakan perawatan holistik yang optimal bagi pasien.

Kasus 4 (Isu Beban Kerja Berlebihan - Burnout)

Anda adalah kepala perawat di ruang IGD sebuah rumah sakit yang menghadapi tingginya beban kerja. Beberapa staf perawat Anda mulai menunjukkan gejala burnout seperti kelelahan dan menurunnya produktivitas kerja. Tindakan prioritas yang sebaiknya Anda ambil adalah:

- A. Mengadakan program pelatihan manajemen stres dan sesi konseling rutin
- B. Memaksa staf bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas secepatnya
- C. Memperketat pengawasan terhadap kinerja staf secara individual
- D. Mengurangi fasilitas istirahat agar staf fokus pada pekerjaan
- E. Memotivasi staf dengan memberikan sanksi bagi yang tidak mencapai target

Kunci Jawaban: A

Rasional:

Pelatihan manajemen stres dan konseling merupakan intervensi paling tepat dalam mencegah dan mengatasi burnout, memastikan perawat memiliki kemampuan coping yang efektif menghadapi tekanan kerja.

Kasus 5 (Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan)

Anda adalah perawat komunitas di daerah terpencil yang menghadapi banyak kendala akses pelayanan kesehatan. Penduduk desa sulit mengakses fasilitas kesehatan karena jarak dan transportasi terbatas. Tindakan keperawatan yang paling efektif dalam situasi ini adalah:

- A. Mengadakan program kunjungan rumah rutin untuk pemeriksaan kesehatan
- B. Mengarahkan semua pasien untuk datang ke kota terdekat setiap bulan
- C. Menyarankan warga membeli sendiri alat medis yang dibutuhkan
- D. Mengurangi intensitas intervensi keperawatan di desa karena sulitnya akses
- E. Menunggu kebijakan pemerintah untuk membangun fasilitas baru

Kunci Jawaban: A

Rasional:

Program kunjungan rumah adalah solusi efektif dalam mengatasi hambatan akses kesehatan, memungkinkan perawat memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat di daerah terpencil.

E. Rangkuman Materi

Tren utama dalam keperawatan modern telah membawa berbagai perubahan signifikan, meliputi keperawatan berbasis teknologi, keperawatan berbasis bukti, spesialisasi keperawatan yang meningkat, serta kolaborasi antarprofesi. Pemanfaatan teknologi seperti Electronic Health Record (EHR), telehealth, dan perangkat wearable secara nyata meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan keperawatan. Pendekatan berbasis bukti menuntut perawat untuk secara aktif menerapkan hasil penelitian terbaru dalam praktik klinis, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif dan aman bagi pasien. Di sisi lain, peningkatan spesialisasi keperawatan menjadi respon terhadap kebutuhan yang semakin kompleks, dengan munculnya perawat spesialis klinis, perawat anestesi, serta perawat gerontologi. Kolaborasi antarprofesi juga menjadi penting dalam memberikan perawatan holistik, meningkatkan efisiensi, komunikasi, serta memperkuat peran strategis perawat dalam tim multidisiplin.

Namun, keperawatan modern juga menghadapi beberapa isu besar yang perlu perhatian khusus, di antaranya adalah kekurangan tenaga keperawatan, beban kerja berlebihan (burnout), tantangan etika dan moral, serta kesenjangan akses pelayanan kesehatan. Kekurangan tenaga perawat secara global menyebabkan kualitas layanan menurun dan beban kerja meningkat, memperparah risiko burnout pada perawat. Tantangan etika juga semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, terutama

dalam isu keputusan akhir hidup dan privasi data pasien. Sementara itu, kesenjangan akses layanan kesehatan masih menjadi masalah serius yang membutuhkan peran aktif perawat dalam advokasi dan intervensi komunitas.

Strategi untuk mengatasi tren dan isu tersebut mencakup peningkatan kompetensi tenaga keperawatan melalui pendidikan berkelanjutan, penerapan teknologi secara bijak dan terintegrasi, serta advokasi kebijakan kesehatan yang mendukung peran strategis perawat. Pendidikan berkelanjutan menjadi landasan utama agar perawat selalu siap menghadapi perubahan dan tantangan yang ada. Penggunaan teknologi harus efektif, efisien, dan tetap memperhatikan aspek etis dan privasi pasien. Selain itu, advokasi kebijakan diperlukan untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif, mendukung kesejahteraan perawat, dan memperluas akses layanan kesehatan secara inklusif dan merata. Dengan penerapan strategi ini secara komprehensif, perawat akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat posisi profesional mereka dalam sistem kesehatan modern yang kompleks.

F. Glosarium

Advokasi Kebijakan Kesehatan

Upaya aktif yang dilakukan perawat dan tenaga kesehatan lain untuk memengaruhi kebijakan publik dalam bidang kesehatan guna memperbaiki kondisi kerja, kesejahteraan tenaga kesehatan, serta akses pelayanan kesehatan secara merata dan inklusif.

Burnout

Kondisi stres kerja kronis yang ditandai dengan kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berlebihan akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi secara berkelanjutan. Kondisi ini dapat menurunkan produktivitas, kualitas layanan, serta menyebabkan tingginya tingkat turnover tenaga kerja.

Clinical Nurse Specialist (CNS)

Perawat spesialis klinis yang memiliki kompetensi tinggi dalam mengelola pasien dengan kondisi medis kompleks, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan riset klinis, pendidikan, dan pengembangan praktik keperawatan lanjutan.

Electronic Health Record (EHR)

Sistem digital terintegrasi yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan mengakses data kesehatan pasien secara real-time dan sistematis. EHR membantu meningkatkan akurasi data, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempercepat pengambilan keputusan klinis.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan praktik klinis yang memanfaatkan hasil penelitian ilmiah terkini, pengalaman klinis, serta preferensi pasien sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan memberikan intervensi perawatan. Pendekatan ini bertujuan memastikan efektivitas, keamanan, dan kualitas pelayanan kesehatan.

Informed Consent

Persetujuan yang diberikan pasien setelah memperoleh informasi yang jelas, lengkap, dan transparan mengenai prosedur medis atau intervensi kesehatan tertentu, termasuk manfaat dan risiko yang terkait.

Interprofessional Collaboration (IPC)

Kerjasama antar berbagai profesi kesehatan dalam tim multidisiplin dengan tujuan memberikan perawatan holistik yang optimal kepada pasien. Dalam IPC, perawat berperan sentral sebagai koordinator perawatan yang mengintegrasikan berbagai aspek pengobatan, rehabilitasi, edukasi, serta dukungan psikososial.

Keperawatan Berbasis Teknologi

Praktik keperawatan modern yang mengintegrasikan teknologi informasi kesehatan seperti telehealth, rekam medis elektronik, serta perangkat wearable untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan akurasi pelayanan kesehatan.

Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan

Kondisi di mana sebagian masyarakat, khususnya di daerah terpencil, pedesaan, atau komunitas rentan, mengalami hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas akibat keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, transportasi, atau edukasi kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Holistik

Pelayanan kesehatan terpadu yang memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, emosional, dan spiritual pasien secara menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan pasien sebagai individu utuh dalam proses perawatan.

Pendidikan Berkelanjutan

Program peningkatan kompetensi bagi tenaga keperawatan yang dilakukan secara kontinu melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, lokakarya, webinar, kursus daring, atau studi lanjut guna memastikan perawat selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Perangkat Wearable

Perangkat elektronik yang dapat dikenakan di tubuh pasien seperti jam pintar (smartwatch) atau sensor khusus, digunakan untuk memonitor kondisi vital pasien secara real-time seperti denyut jantung, tekanan darah, aktivitas fisik, dan kadar gula darah.

Perawat Anestesi (Certified Registered Nurse Anesthetist/CRNA)

Perawat spesialis yang memiliki keahlian dalam memberikan anestesi, mengelola nyeri, serta melakukan pemantauan anestesi dalam berbagai prosedur medis, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dokter anestesi.

Perawat Gerontologi

Perawat spesialis yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan perawatan kepada populasi lanjut usia, meliputi pengelolaan penyakit degeneratif, gangguan kognitif, serta kebutuhan psikososial lansia.

Spesialisasi Keperawatan

Pengembangan kompetensi khusus dalam bidang tertentu pada praktik keperawatan, sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan kesehatan yang meningkat. Contohnya adalah Clinical Nurse Specialist, perawat anestesi, dan perawat gerontologi.

Telehealth

Pelayanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi digital untuk konsultasi, pemantauan, edukasi, dan intervensi kesehatan, memungkinkan layanan kesehatan tetap berjalan meskipun pasien dan tenaga kesehatan berada di lokasi yang berjauhan.

Tantangan Etika dan Moral

Dilema atau konflik yang dihadapi perawat dalam mengambil keputusan klinis yang melibatkan prinsip etika seperti penghormatan hak pasien, martabat manusia, dan perlindungan privasi serta keamanan data pasien, khususnya dalam isu sensitif seperti perawatan akhir hidup.

G. Daftar Pustaka

- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). American Nurses Association.
- Byrne, M. D., & Weston, C. (2020). Interprofessional collaboration in healthcare: The importance of teamwork. *Journal of Interprofessional Care*, 34(5), 563–570. <https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1694502>
- Chaghari, M., Ebadi, A., Ameryoun, A., & Safari, M. (2022). An attempt for empowering education: A qualitative study of continuing education challenges and strategies in nursing. *BMC Nursing*, 21(1), 74. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-00865-0>
- Harrington, L., Edelman, L. S., & Hoffmann, R. L. (2022). Technology in nursing practice: Improving patient outcomes through digital health interventions. *Nursing Outlook*, 70(3), 386–394. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.09.006>
- Jarden, R. J., Jarden, A., & Weiland, T. J. (2021). Burnout among nurses: Exploring effective interventions. *International Journal of Nursing Studies*, 119, 103933. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103933>
- Kleib, M., Chauvette, A., & Nagle, L. (2021). Nurses' perspectives on the use of electronic health records and informatics competency. *Computers, Informatics, Nursing*, 39(2), 59–66. <https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000693>
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2022). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Morley, G., Ives, J., & Bradbury-Jones, C. (2021). Ethical challenges experienced by nurses during COVID-19: Implications for nursing practice and ethics education. *Nursing Ethics*, 28(6), 743–759. <https://doi.org/10.1177/0969733020980296>
- Phillips, J., Crane, J., Hanly, L., & Knox, L. (2020). Implementation of telehealth services in nursing: Lessons learned during COVID-19. *Journal of Nursing Management*, 28(7), 1643–1648. <https://doi.org/10.1111/jonm.13160>
- Salmond, S. W., & Echevarria, M. (2020). Healthcare transformation and changing roles for nursing. *Orthopaedic Nursing*, 39(1), 12–25. <https://doi.org/10.1097/NOR.0000000000000625>

- World Health Organization. (2020). State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279>
- Yen, P. Y., Walker, D. M., Smith, J. M. G., Zhou, M. P., & Menser, T. L. (2021). Nurses' stress associated with nursing activities and electronic health records: Data triangulation from continuous stress monitoring, perceived workload, and a time-motion study. *Applied Ergonomics*, 94, 103398. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2021.103398>

PROFIL PENULIS



Ns. Kartika Wijayanti, M.Kep. Lahir di Kendal, 23 Maret 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Magister Keperawatan (Maternitas) Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 di Universitas Muhammadiyah Magelang sampai saat ini. Matakuliah utama yang penulis ampu adalah Keperawatan Maternitas dan keperawatan Kesehatan Reproduksi. Matakuliah lain yang diampu penulis adalah Patofisiologi, Farmakologi, Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) dan Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian pada masyarakat, dan aktif dalam organisasi profesi (PPNI) serta aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui E-mail : kartikawijayanti@unimma.ac.id



Maryadi, S.Kep., Ns., M.Kep Lahir di Kabupaten Sigi pada 19 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2013-2016, jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Alma Ata Yogyakarta tahun 2017-2020. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2022. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Paliatif, Literasi Digital, dan Biostatistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, penulis artikel ilmiah dan publikasi, serta kegiatan seminar yang berkaitan dengan pengembangan perguruan tinggi dan ilmu keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maryadi@ung.ac.id

PROFIL PENULIS



Ns. Ari Susiani, M.Kep.: Dosen pada Akademi Keperawatan Harum Jakarta, Lahir di Tegal Jawa Tengah, 9 Februari 1979; penulis menempuh Sekolah Dasar Negeri 05 Tegalsari, SMPN 6 Tegal; SMAN 4 Tegal. Dan lulusan D III Akademi Keperawatan Sismadi tahun 2000. Melanjutkan Pendidikan Sarjana dan profesi Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus tahun 2005. Melanjutkan Pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta lulus tahun 2013, dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah. penulis juga telah melakukan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat pada jurnal keperawatan nasional. Semoga kedepannya penulis terlibat aktif dalam menulis buku ajar.
Email penulis : 09arisusiani@gmail.com



Dr. Betty Suprapti, SKp.MKes. Lahir di Ciamis, 30 Maret 1958. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gajah Mada dan lulus tahun 2002. Lulus S3 pada tahun 2019 pada Universitas Islam Bandung. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1981 sebagai Guru SPK Dep.Kes Tasikmalaya, tahun 1993 sd 2001 sebagai Dosen Akper Dep.Kes Tasikmalaya, selanjutnya sebagai dosen Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 2001 sd tahun 2023. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya mengampu mata kuliah manajemen keperawatan, Etika keperawatan dan hukum kesehatan, Keperawatan Keluarga, Kebijakan Kesehatan, Pelayanan Primer, Komunikasi Terapeutik dan Administrasi Rumah Sakit. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, reviewer. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bettysuprapti@gmail.com
Motto: "Setelah kesulitan akan ada kemudahan"

PROFIL PENULIS



Ns. Aida Kusnaningsih, M.Kep., Sp.Kep. Mat.

Lahir di Tumpung Laung, Kalimantan Tengah pada tanggal 6 April 1979.

Latar belakang pendidikan formal yang ditempuh diantaranya:

- ✓ SDN 1 Tumpung Laung (1991),
- ✓ SMPN 1 Tumpung Laung (1994),
- ✓ SMAN 1 Muara Teweh (1997),
- ✓ Akper Depkes Palangka Raya (2000),
- ✓ Sarjana Keperawatan dan Ners Universitas Diponegoro Semarang (2009),

✓ Program Pasca Sarjana dan Program Spesialis Keperawatan Maternitas di Universitas Indonesia (2017).

Riwayat Pekerjaan:

✓ Tahun 2000-2001 bekerja di RSUD dr. Doris Sylvanus dan Klinik Bersalin Aridha Husada Palangka Raya.

✓ Sejak 2001 sampai sekarang (2025) aktif sebagai Tenaga Pengajar Di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya.

Sinopsis

"Konsep Dasar Keperawatan" adalah buku ajar yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam memahami berbagai konsep dasar yang esensial dalam menjalankan tugas keperawatan secara profesional. Buku ini menyajikan penjelasan komprehensif tentang sejarah perkembangan keperawatan, filosofi dan paradigma yang menjadi dasar praktik keperawatan, serta aspek etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap tenaga kesehatan.

Selain itu, buku ini juga mengupas berbagai tren dan isu kontemporer dalam dunia keperawatan, seperti penerapan teknologi dalam pelayanan kesehatan, pentingnya keperawatan berbasis bukti, serta peningkatan spesialisasi keperawatan. Interprofessional collaboration (IPC) yang menjadi pendekatan penting dalam praktik modern juga dibahas secara mendalam, menegaskan peran penting perawat dalam tim multidisiplin.

Buku ini ditujukan agar pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara efektif dalam praktik klinis sehari-hari. Dengan struktur yang sistematis, buku ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi keperawatan serta memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Konsep Dasar Keperawatan" adalah buku ajar yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam memahami berbagai konsep dasar yang esensial dalam menjalankan tugas keperawatan secara profesional. Buku ini menyajikan penjelasan komprehensif tentang sejarah perkembangan keperawatan, filosofi dan paradigma yang menjadi dasar praktik keperawatan, serta aspek etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap tenaga kesehatan.

Selain itu, buku ini juga mengupas berbagai tren dan isu kontemporer dalam dunia keperawatan, seperti penerapan teknologi dalam pelayanan kesehatan, pentingnya keperawatan berbasis bukti, serta peningkatan spesialisasi keperawatan. Interprofessional collaboration (IPC) yang menjadi pendekatan penting dalam praktik modern juga dibahas secara mendalam, menegaskan peran penting perawat dalam tim multidisiplin.

Buku ini ditujukan agar pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara efektif dalam praktik klinis sehari-hari. Dengan struktur yang sistematis, buku ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi keperawatan serta memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

